

علاج قلق الطهارة

HELPING
HEALTH
ANXIETY

ترجمة
دكتورة أمارة يحيى



مكتبة الأنجلو المصرية

علاج قلق الصدحة

الصادر عن:
مركز التدخلات الإكلينيكية
"أستراليا الغربية"

ترجمة
دكتورة أمارة يحيى عرفه



مقدمة الترجمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات... الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. أشعر بسعادة غامرة لإتمام ترجمة هذا البرنامج العلاجي لقلق الصحة في وقت يتعرض فيه العالم لتحديات كبرى على الصعيد الصحي. ومصدر سعادتي ليس فقط خروج هذا العمل للنور، في اضطراب لم يحظ بانتشار برامج علاجية له مقارنة باضطرابات أخرى، رغم ارتفاع نسب انتشاره، ولكن سعادتي بالأحرى سببها هذا البرنامج في حد ذاته.

هذا البرنامج من أفضل ما قرأت من ناحية الوضوح والدقة والتفصيل والتنظيم والسلاسة. كل خطوة تسلم ببراعة للخطوة التالية. لم يخطر ببالي سؤال واحد إلا ووجدت له إجابة. لم أقرأ جزءاً معيناً فأثار لديّ استفسارات محددة؛ إلا ووجدته يطرح في الفقرة التالية استفساراتي، ويجيب عنها.

هذا البرنامج المُلهم يمكن أن يُحتذى بطريقته العامة في التفكير لوضع برامج علاجية للاضطرابات الأخرى. فالبرنامج يبدأ بتحليل الاضطراب لأعراض، ومسببات، وعوامل استمرار، ومرتبات. ثم يجمع تلك العناصر معا في نموذج متكامل. ثم يوضح بدقة كيفية التعامل مع كل جزء من هذه الأجزاء. ويصوغ خطة منظمة لمنع الانتكاس، ثم يضع خطوات واضحة محددة لعيش حياة صحية.

اضطراب قلق الصحة من أكثر الاضطرابات التي كنت أجد صعوبة في التعامل معه، ولكن بعد أن منحني الله الاطلاع على هذا البرنامج اختلف الأمر.

يحتوي الكتاب على جميع الأسئلة والتدريبات وأوراق العمل التي يحتاجها القارئ لتحقيق أكبر استفادة تطبيقية من كل جزء في هذا البرنامج، وقد حرصت على إعطائها لونا مختلفا لتنبيه القارئ لتلك الأجزاء.

هذا الكتاب كتاب مساعدة ذاتية، يفيد المتخصصين وأيضا يفيد من يعانون من قلق الصحة، وآمل أن يجد القارئ العربي في هذا العمل مبتغاه، وأن يجعله الله تعالى سببا في تخفيف معاناة عباده، ويتقبله برحمته.

المتجمة: د. أمارة يحيى عرفه
مدرس علم النفس الإكلينيكي - جامعة القاهرة
٢٥ / ١١ / ٢٠٢٢

الفهرس

الصفحة	
٥	المرحلة ١: فهم قلق الصحة
٢٢	المرحلة ٢: استكشاف كيف ينشأ قلق الصحة
٤٣	المرحلة ٣: تحديد عوامل استمرار قلق الصحة
٧٠	المرحلة ٤: تقليل التركيز على الأعراض والمخاوف الصحية
٩٩	المرحلة ٥: إعادة تقييم التفكير غير المفيد المتعلق بالصحة
١٢٥	المرحلة ٦: تقليل الفحوص وطلب التطمين
١٦٠	المرحلة ٧: تحدي التجنب وسلوكيات الأمان
١٩٢	المرحلة ٨: تعديل القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة
٢١١	المرحلة ٩: الحياة الصحية والتخطيط لإدارة الذات

المرحلة الأولى

فهم قلق الصحة

١- مقدمة

٢- ما هي الصحة؟

٣- ما هو قلق الصحة؟

٤- متى يمثل قلق الصحة مشكلة؟

٥- الآثار السلبية لقلق الصحة

٦- ما الذي يمكن أن نتوقعه بناء على تلك المعلومات؟

٧- ملخص المرحلة الأولى

المقدمة

من وقت لآخر نقلق جميعا بشأن أشياء مثل: العلاقات، والعمل، والشئون المالية، وبالطبع صحتنا. سيلاحظ جميع الأفراد -من وقت لآخر- أحاسيس أو تغيرات في أجسادهم، وسوف يتساءلون عن احتمال وجود مشكلة طبية خطيرة لديهم، وسيتخذون خطوات للتخفيف من همومهم ومخاوفهم الصحية. ومع ذلك، هناك فرق بين القلق العام بشأن الصحة - والذي نشعر به جميعاً من وقت لآخر - وبين قلق الصحة الأكثر إشكالية.

هل أنت شخص تقلق كثيراً على صحتك؟ هل لاحظت أن جهودك المبذولة للعثور على إجابات بشأن أعراضك تؤثر عليك بطريقة سلبية؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد ترغب في الاستمرار في قراءة المراحل الخاصة بـ "علاج قلق الصحة". الهدف من المرحلة الحالية هو تزويدك ببعض المعلومات العامة عن قلق الصحة، لاكتشاف ما إذا كان قلق الصحة يمثل مشكلة بالنسبة لك، ومناقشة آثاره السلبية.

ما هي الصحة؟

قبل أن نتحدث عن قلق الصحة من المهم أن نفكر أولاً في ماهية "الصحة" وأن ندرك أن الصحة تعني أشياء مختلفة باختلاف الأشخاص. يعتبر كثير من الناس أن الصحة تعني غياب المرض أو الإصابة أو الإعاقة. ومع ذلك، فإن معنى الصحة يتغير من شخص لآخر، وعبر الثقافات والقارات. على سبيل المثال، قد يعتبر الأشخاص الرياضيون أنفسهم معتلين صحياً إذا تعرضوا لإصابة تمنعهم من التدريب. ومع ذلك، يمكن لأشخاص مصابين بحالة تشخيصية، مثل: مرض السكري أو الربو، أن يعتبروا أنفسهم يتمتعون بصحة جيدة إذا كانوا يديرون حالاتهم بشكل جيد. لذلك فإن معظم تعريفات الصحة تتجاوز مجرد غياب المرض أو الإصابة أو الإعاقة، لتشمل حالة الفرد الجسدية والعقلية والاجتماعية. الأهم من ذلك، بدلاً من التفكير في الصحة من منظور أبيض وأسود (أي أننا إما نتمتع بصحة جيدة أو لا نتمتع بها في هذه المجالات)، فإن معظم تعريفات الصحة تضع هذه المجالات الثلاثة (الجسدي والعقلي والاجتماعي) على متصل يتراوح من ضعيف جداً إلى ممتاز.

قبل أن نذهب إلى أبعد من ذلك، خذ بضع لحظات لوصف صحتك العامة.

لاحظ الآن: كيف وصفت صحتك؟ على أي شيء ركزت؟ ما هي جوانب الصحة التي برزت على أنها الأهم بالنسبة لك؟ هل وضعت في اعتبارك الأداء الجسدي والعقلي والاجتماعي وشعورك بالعافية؟

ما هو قلق الصحة؟

يأتي القلق في الأوقات التي نعتقد فيها أن شيئاً سيئاً قد يحدث أو سيحدث بالفعل. في الواقع هذه هي غريزة البقاء، إنها مفيدة لنا خاصة في المواقف التي تهدد الحياة الواقعية. على سبيل المثال: إذا واجهت حيواناً خطيراً، فمن المفيد لعقلك التعرف على التهديد، وإخبار جسدك بالركض أو الاختباء أو الاستعداد للهجوم. لذلك سوف يمر جسدك بمجموعة من التغيرات الفسيولوجية المعروفة باسم استجابة "الهجوم أو الهروب" "fight or flight response"، والتي تساعد في تحضير أجسامنا وحمايتنا من الخطر.

ومع ذلك، هناك أوقات يمكن أن نخبر فيها استجابة القلق بسبب مجرد تهديد محتمل. هل حدث يوماً وشعرت بالقلق من احتمال كراهية الآخرين لخطاب توشك أن تلقيه، ولاحظت أن قلبك ينبض بشكل أسرع؟ هل سبق لك أن مشيت في طريق ضيق مظلم في الليل وشعرت بالتوتر لأنك كنت قلقاً من احتمال حدوث شيء سيئ؟ في كلتا الحالتين قد يحدث شيء سيئ أو لا يحدث، ولكن المهم هو أنك إذا اعتقدت أن هناك خطراً معيناً، فستشعر عادةً بالقلق بدرجة ما. لذلك يشير قلق الصحة إلى "التفكير في احتمال وجود تهديد لصحتك، مما يثير استجابة القلق لديك".

على الرغم من أننا قد نفكر ونقلق بشأن أي عدد من المشكلات المتعلقة بالصحة -فإن هناك بعض المخاوف الصحية أكثر شيوعاً، وتشمل: الإصابة بالسرطان، أو مرض الزهايمر، أو التصلب المتعدد، أو ضمور العضلات، أو اضطراب نفسي مثل الفصام، واضطراب الغدة الدرقية، أو الإصابة بنوبة قلبية.

ومع ذلك فإن الأفراد بشكل عام لا يفكرون في مشكلات محددة، وإنما تكون مخاوفهم أكثر عمومية، فيعتقد الفرد ببساطة أن هناك شيئاً ما "ليس على ما يرام".

وأنت، بأي طريقة تقلق على صحتك؟ ما الذي تعتبره أكبر التهديدات لصحتك العامة؟ هل تقلق بشأن أعراض جسدية معينة؟ هل لديك مشكلة صحية معينة أو مرض أو داء تشعر بالقلق (أو حتى مقتنع) من أنك ربما تعاني منه الآن أو ستصاب به في المستقبل؟

في بعض الحالات، قد يكون الخوف الذي تشعر به موجهًا لصحة شخص تهتم لأمره. على سبيل المثال، فإن الأب الذي لاحظ أن طفله متعب في كثير من الأحيان؛ قد يشعر بالقلق من إصابة طفله بسرطان الدم، أو قد يبدأ الشخص الذي لاحظ أن شريكه يسعل كثيرًا في القلق من إصابته بسرطان الرئة. ورغم أن هذا البرنامج موجهٌ إلى المخاوف التي قد تنتابك بشأن صحتك أنت، فإنه يمكنك أيضًا استخدام معظم تلك التمارين إذا كنت قلقًا بشأن صحة شخص تهتم لأمره.

متى يمثل قلق الصحة مشكلة؟

يمكن إلى حد ما أن تؤثر الدرجات البسيطة من قلق الصحة علينا جميعًا من وقت لآخر. مَنْ منا لم يقلق عندما ينتظر نتائج بعض الفحوصات، أو كان لديه بعض الأفكار المقلقة حول نتوء جديد لاحظته؟ لذا علينا تحديد النقطة التي يصبح عندها قلق الصحة البسيط مشكلة. ففي حين يُعد القلق بشأن صحتك، وطلب المشورة والفحوصات الطبية الملائمة أمرًا يخبره جميع البشر -كما هو الحال مع أي شيء- فإن الإفراط في بعض الأشياء يمكن أن يكون ضارًا بالنسبة لك.

لذا قد تصبح المخاوف الصحية مشكلةً عندما تكون:

- مفرطة
- لا تتناسب مع الاحتمالات الواقعية لوجود مشكلة طبية حقيقية وخطيرة.
- مستمرة على الرغم من النتائج السلبية للفحوصات و/ أو طمأنة طبيبك الخاص.
- تؤدي إلى سلوكيات غير مفيدة مثل الإفراط في الفحص، أو طلب التطمين (على سبيل المثال: من الأطباء أو العائلة أو الأصدقاء)، أو التجنب (على سبيل المثال: تجنب الفحوصات والأطباء والمعلومات المتعلقة بالصحة)
- تسبب لك كربًا شديدًا، أو تُضعف قدرتك على ممارسة حياتك اليومية.

دعنا نكتشف ما إذا كان قلق الصحة يمثل مشكلة بالنسبة لك.

فيما يلي بعض العبارات عليك أن تفكر فيها:

[illegible]

(*) إضافة المترجمة: أقوم بهذا التفحص داخل ذهني فقط.

				أجد صعوبة في التركيز على أشياء أخرى غير الأحاسيس والأعراض الجسدية.
				أتفحص جسدي بدنياً (*) بحثاً عن وجود أعراض وتغيرات فيه.
				كثيراً ما أزور المتخصصين في المجال الصحي (مثل: الممارسين العامين أو الاختصاصيين) لمناقشة مخاوفي وأعراضي الصحية أو لإجراء فحوصات.
				أتجنب المتخصصين في المجال الصحي (مثل: الممارسين العامين أو الاختصاصيين) نظراً لشدة قلقي بشأن صحتي و/ أو نتائج الفحوص.
				تستمر همومي بشأن صحتي على الرغم من تطمين طبيبي لي أو رغم النتائج السلبية للفحوصات.
				أبحث عن معلومات حول أعراض (على سبيل المثال: على الإنترنت، أو في كتيبات من العيادات الصحية).
				أناقش أعراض مع عائلتي و/ أو أصدقائي.

(**) إضافة المترجمة: أقوم بهذا التفحص باستخدام يدي مثلاً.

				أتجنب الأشخاص أو الأماكن أو الأنشطة التي تثير لدي مخاوف صحية.
				أتجنب الأشخاص أو الأماكن أو الأنشطة التي تثير لدي أحاسيس جسدية معينة.

إذا كنت قد أجبت على معظم الأسئلة المذكورة أعلاه بـ (غالبا) أو (معظم الوقت)، فقد يكون قلق الصحة أمرا تريد العمل عليه. حتى إذا كنت قد أجبت على عدد قليل من العبارات المذكورة أعلاه بـ (غالبا) أو (معظم الوقت)، فربما لا تزال ترغب في البقاء معنا لأنك قد تتعلم بعض المهارات المفيدة في المستقبل.

ولكنني أعاني من أعراض حقيقية؟؟؟!

من المهم أن نعرف أن قلق الصحة يمكن أن يوجد لدى الأشخاص "الأصحاء"، ولدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض طبية حقيقية ولكن غير مبررة، وأيضا لدى الأشخاص الذين لديهم حالة طبية مُشخصة حاليا. هذا يعني أن الأعراض الجسدية التي تخبرها، والتي تُعد أساس قلق الصحة لديك "ليست كلها في رأسك".

سواء كانت لديك أعراض حقيقية أو حالة طبية فعلية أو لا، فهذه ليست القضية الرئيسية عندما يتعلق الأمر بقلق الصحة. إن المشكلة تكمن في كيفية استجابتك لأعراضك أو حالتك والتعامل معها. إذا كنت تستجيب للمشكلات أو الأعراض الصحية بقلق مفرط ومستمر، أو بإجراء الفحوص، أو بطلب التطمين، أو بالتجنب، فلا زال قلق الصحة مشكلة لديك.

الآثار السلبية لقلق الصحة

يمكن أن يؤثر قلق الصحة علينا بطرق سلبية عديدة. فيما يلي أكثر المجالات التي تتأثر بقلق الصحة:

العلاقات مع العائلة/الأصدقاء

قد يؤثر الوقت الذي تقضيه في القلق بشأن صحتك أو طلب المساعدة من المتخصصين على قدرتك على التواصل الاجتماعي أو الاهتمام بأمور عائلية مهمة. وقد يشاركك أفراد العائلة والأصدقاء في همومك، مما يؤدي إلى شعور الجميع بالكرب. من ناحية أخرى، قد يصابون بالإحباط معك إذا استمر قلقك على الرغم من النتائج السلبية للفحوص أو على الرغم من تطميناتهم المستمرة. وفي بعض الحالات، قد تشعر بالإحباط أو حتى الغضب تجاه عائلتك أو أصدقائك لعدم تفهمهم لما تمر به، أو لعدم مساعدتهم لك في جهودك التي تبذلها لاكتشاف المشكلة في صحتك.

العمل أو الدراسة

يجد عديد من الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة صعوبة في التوقف عن القلق بشأن علامات المرض والتحقق منها. كل هذا القلق يمكن أن يؤثر على قدرتك على التركيز في المهمة التي تقوم بها. وقد يتم أيضاً استنزاف وقت العمل أو الدراسة عن طريق المواعيد الطبية أو البحث على الإنترنت؛ مما يؤدي إلى تأخرك في عملك أو مهامك الدراسية.

التمتع بالحياة والرضا عنها

يمكن أن يؤدي التركيز على المشكلات الصحية المحتملة إلى ظهور نظرة متحيزة وقد يؤدي إلى مزاج كئيب. قد تجد نفسك في بعض الأحيان شديد التركيز على مخاوفك الصحية وعلى سعيك لليقين بشأن صحتك؛ مما يؤدي لتوقفك عن فعل الأشياء التي اعتدت أن تستمتع بها أو التي تعطيك شعورا بالإنجاز (على سبيل المثال: ممارسة الرياضة، والتواصل الاجتماعي). هذا الانسحاب يؤدي إلى مزيد من المزاج الاكتئابي، مما يُحد من فرصك في المتعة والنجاح.

العلاقة مع المختصين في مجال الصحة

يمكن أن تؤدي الزيارات المتكررة إلى الطبيب بدون نتائج واضحة إلى شعورك أنت ومقدم الرعاية الصحية بعدم الرضا. وقد تبدأ حتى في الشعور بالإحباط أو الغضب تجاه مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أو تجاه النظام الصحي بأكمله! ربما تكون قد مررت بشعور أن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لا يصدقك أو يعتقد أنك "متوهم"، وربما يكون طبيبك قد قال لك ذلك بالفعل.

من الواضح أن هذا ليس مفيداً لك أو للعاملين في مجال الصحة. إننا نريد أن يكون مقدمو الخدمة الصحية على استعداد للاستجابة لاحتياجاتنا الصحية. وكذلك يرغب معظم مقدمي الخدمات الصحية في مساعدتنا على معرفة لماذا نشعر بما نشعر به، ومساعدتنا في تقليل مخاوفنا ومشاكلنا الصحية أو التخلص منها أو إدارتها.

الشئون المالية

إن الفحوصات أو الإجراءات الطبية المتعددة أو المتكررة، والوقت الذي ينقضي بعيداً عن العمل، وحتى تكاليف السفر لحضور المواعيد الطبية، تُعد عبئاً إضافياً. ويمكن أن يصبح القلق وسلوك الفحص وطلب التطمين المرتبط بقلق الصحة لدى بعض الناس أمراً مرهقاً أو مستهلكاً للوقت بحيث يقلل قدرته على العمل.

أعراض القلق غير السارة

في كل مرة تقلق فيها على صحتك، فإنك تبدأ في استجابة الهجوم/ الهروب، كما أوضحنا ذلك من قبل. لذلك قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة بالتململ restless أو التوتر الجسدي أو عدم القدرة على الاسترخاء. وقد يعانون أيضاً من اضطراب النوم، والغثيان، وخفقان القلب، وألم الصدر أو الضغط، والتعرق، والدوخة أو دوار الرأس، والإحساس بالوخز، والشعور بالانفصال عن جزء من الجسم أو عن الجسم بأكمله. ونظراً لأنك تكون قلقاً بالفعل بشأن صحتك، فإن قلقك هذا يستثير أعراضاً فسيولوجية، وبالطبع فإن وجود مزيد من الأعراض الفسيولوجية يضفي مزيداً من الأحاسيس التي تقلق بشأنها!

إذا كنت تعاني من قلق الصحة، خذ لحظة لتدوين كيف يؤثر قلق الصحة عليك.

ما الذي تتوقعه من حزمة المعلومات هذه

سواء كنت تعاني من مخاوف صحية مفرطة فقط، أو مخاوف صحية مقترنة بأعراض جسمية، أو مخاوف صحية مصاحبة لحالات صحية تم تشخيصها أو لم تُشخص بعد، يمكن أن تساعدك حزمة المعلومات هذه على البدء في تقليل القلق المفرط، وتقليل أي سلوكيات غير مفيدة بدأت تتخبط فيها.

لقد بدأنا بمناقشة حول ماهية قلق الصحة وتأثيره على حياة الفرد. في المرحلتين التاليتين، سوف نستكشف ونناقش كيف ينشأ قلق الصحة وعوامل استمراره. وستركز المراحل بعد ذلك على ما يمكنك فعله للتغلب على قلق الصحة.

فيما يلي نعرض للمراحل التي تتكون منها هذه الحزمة من المعلومات:

- المرحلة ١: فهم قلق الصحة
- المرحلة ٢: استكشاف كيف ينشأ قلق الصحة
- المرحلة ٣: تحديد عوامل استمرار قلق الصحة
- المرحلة ٤: تقليل التركيز على الأعراض والمخاوف الصحية
- المرحلة ٥: إعادة تقييم التفكير غير المفيد المتعلق بالصحة
- المرحلة ٦: تقليل الفحوص وطلب التطمين
- المرحلة ٧: تحدي التجنب وسلوكيات الأمان
- المرحلة ٨: تعديل القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة
- المرحلة ٩: الحياة الصحية والتخطيط لإدارة الذات

عند استخدام برامج المساعدة الذاتية قد يتخطى بعض الأشخاص أقساماً معينة، أو يطلعون على الأجزاء بترتيب مختلف، لذا نوضح أنه تم تصميم هذه المراحل في حزمة معلومات بحيث تكتمل بالترتيب المُقدم. ونوصيك بالعمل من خلال هذه المراحل بالتسلسل، وإنهاء كل مرحلة قبل الانتقال إلى المراحل التي تليها في السلسلة. ونعتقد أنه من خلال القيام بذلك ستزيد الفائدة التي ستحصل عليها.

إننا نعتقد أن حزمة المعلومات هذه ستكون مفيدة لأي شخص يرغب في معالجة أي صعوبات يواجهها مع قلق الصحة. ونشجعك على القيام بهذه الرحلة عبر جميع مراحلها، ونأمل أن تحصل على نظرة متوازنة لصحتك، وأن تواصل الانخراط في السلوكيات الصحية المناسبة. قد تجد في بعض الأحيان أن العمل صعب بعض الشيء، لكننا نشجعك على البقاء معه ومواصلة العمل خلال هذه المراحل حتى تصل إلى النهاية.

نراكم في المرحلة التالية!

ملخص المرحلة الأولى

- القلق على صحتك خبرة إنسانية طبيعية.
- يشير قلق الصحة إلى القلق المفرط من احتمال وجود خطر على صحتك مما يثير استجابة (الهجوم/ الهروب).
- يصبح قلق الصحة مشكلة عندما يكون مفرطاً، ولا يتناسب مع الاحتمالات الواقعية لوجود مشكلة خطيرة، ويستمر على الرغم من النتائج السلبية للفحوص وطمأنة العاملين في المجال الصحي، ويؤدي إلى سلوكيات غير مفيدة مفرطة مثل: فحص الجسم وإجراء الفحوص الطبية، ويسبب لك كرباً شديداً أو يؤثر على أدائك.
- يمكن أن يوجد قلق الصحة لدى الأشخاص "الأصحاء"، ولدى الأشخاص الذين يعانون من أعراض طبية حقيقية ولكن غير مبررة، ولدى الأشخاص الذين لديهم حالة طبية مشخصة بالفعل. في حالة قلق الصحة، لا تكمن المشكلة فيما إذا كانت الأعراض الجسدية لديك حقيقية أم لا، ولكن تكمن فيما إذا كنت تستجيب لأعراضك وتتعايش معها بطريقة مفيدة أو غير مفيدة.
- يمكن أن يؤثر قلق الصحة على علاقاتك مع العائلة والأصدقاء، وحتى مع العاملين في مجال الصحة. ويمكن أن يؤثر أيضاً على قدرتك على الحفاظ على التزامات العمل أو الدراسة، كما يؤثر على مزاجك ونفقاتك.
- عندما تقلق بشأن صحتك فإنك تثير استجابة الهجوم/ الهروب، مما يؤدي لظهور مزيد من الأعراض الفسيولوجية التي قد تقلق بشأنها.

التالي...

في المرحلة التالية، سوف نستكشف ونتعلم المزيد حول كيفية نشأة قلق الصحة.

Helping Health Anxiety

About The Modules

CONTRIBUTORS

Dr Rebecca Anderson (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

Paula Nathan (MPsych¹)
Centre for Clinical Interventions

Dr Lisa Saulsman (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

¹Masters of Psychology (Clinical Psychology)

²Doctor of Philosophy (Clinical Psychology)

BACKGROUND

The concepts and strategies in these modules have been developed from evidence based psychological practice, primarily Cognitive-Behaviour Therapy (CBT). CBT for health anxiety is based on the approach that health anxiety is a result of problematic cognitions (thoughts) and behaviours.

REFERENCES

These are some of the professional references used to create the modules in this information package.

Abramowitz, J., Taylor, S., & McKay, D. (2010). Hypochondriasis and severe health anxiety. In McKay, D., Abramowitz, J., S., & Taylor, S. (Eds.). *Cognitive-behavior therapy: Turning failure into success* (pp. 327-346). Washington, DC: American Psychological Association.

Asmundson, G., & Taylor, S. (2005). *It's not all in your head: How worrying about your health could be making you sick – and what you can do about it*. New York: The Guilford Press.

Furer, P., & Walker, J. (2006). *Health anxiety treatment manual*. University of Manitoba: Manitoba.

Furer, P., Walker, J., & Stein, M. (2007). *Treating health anxiety and fear of death*. New York: Springer.

Papageorgiou, C., & Wells, A. (1998). Effects of attention training on hypochondriasis: A brief case series. *Psychological Medicine*, 28, 193-200.

Salkovskis, P., Warwick, H., & Deale, A. (2003). Cognitive-behavioural treatment for severe and persistent health anxiety (Hypochondriasis). *Brief Treatment and Crisis Intervention*, 3, 353-367.

Willson, R., & Veale, D. (2009). *Overcoming health anxiety: A self-help guide using cognitive behavioural techniques*. London: Robinson.

“HELPING HEALTH ANXIETY”

This module forms part of:

Anderson, R., Saulsman, L., & Nathan, P. (2011). *Helping Health Anxiety*. Perth, Western Australia: Centre for Clinical Interventions.

ISBN: 0 9757995 6 8

Created: August 2011

المرحلة الثانية

استكشاف كيف ينشأ قلق الصحة

١- مقدمة

٢- الخبرات السلبية المتعلقة بالصحة

٣- زيادة الهشاشة المتعلقة بالصحة

٤- حماية أنفسنا: قواعد وافتراسات غير مفيدة متعلقة بالصحة

٥- حماية أنفسنا: زيادة الحساسية الصحية

٦- نموذج قلق الصحة: كيف ينشأ قلق الصحة

٧- ورقة عمل: كيف ينشأ قلق الصحة

٨- الأخبار السارة

٩- ملخص المرحلة الثانية

١٠- حول المراحل

مقدمة

لقد ألقينا نظرة حتى الآن على الفرق بين المخاوف اليومية العادية بشأن الصحة والمستويات الأكثر تطرفاً وإشكالية لقلق الصحة. كما عرضنا أيضاً لبعض التأثيرات السلبية التي يمكن أن يؤثر بها قلق الصحة على أدائنا اليومي، وعلاقاتنا ورضانا عن الحياة والاستمتاع بها. ومع ذلك، فإن الشيء الذي يسأله كثير من الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة هو: "لماذا أعاني من قلق الصحة؟"

إن السبب الدقيق لقلق الصحة غير معروف. ورغم أن هناك بعض الأدلة على أن قلق الصحة -مثل جميع اضطرابات القلق- قد يكون جزئياً مشكلة وراثية أو قائمة على أساس بيولوجي، فإنه من المتفق عليه بشكل عام أن هناك عدداً من العوامل المهمة الأخرى التي تزيد من احتمالية الإصابة بهذه المشكلة. في هذه المرحلة، سوف نستكشف كيف يمكن لبعض هذه العوامل أن تساهم في نشأة قلق الصحة وتطوره.

الخبرات السلبية المتعلقة بالصحة

يشير قلق الصحة -كما نوقش في المرحلة الأولى- إلى القلق المفرط من احتمال وجود تهديد لصحتك مما يؤدي إلى إثارة القلق (استجابة الهجوم/الهروب). فمن أين يأتي هذا القلق المفرط؟

غالبًا ما يُعبر الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة عن تعرضهم لخبرات سابقة مما يلي:

١ - وجود أفراد في العائلة أو أشخاص آخرين من المحيطين يعانون من مرض خطير

يمكن أن تؤثر تجاربنا -خاصة خلال مرحلة الطفولة والمراهقة- على الكيفية التي ننظر بها إلى أنفسنا وإلى الآخرين وإلى المستقبل. إننا إذا شاهدنا شخصًا يعاني من الألم والمعاناة، فقد يؤدي ذلك إلى شعورنا بالضعف و القلق من احتمالية حدوث ذلك لنا أيضًا. وإذا شاهدنا شخصًا يتطور مرضه بشكل تدريجي، فقد نشعر بالعجز تمامًا. وقد ينشأ لدينا شعور بأن "المرض" يعني "العجز عن فعل أي شيء". وفي الحالات التي يكون فيها المرض الذي يعاني منه أحد أفراد الأسرة يشتمل على درجة من التوريث، فقد نبدأ في التركيز على احتمالية إصابتنا بهذا المرض.

٢- وفاة أحد أفراد الأسرة أو أي شخص معروف لك

رغم أننا نعرف أن الموت أمر مؤكد في نهاية المطاف بالنسبة لنا جميعاً، فإن معظمنا يمكنه تحمل عدم اليقين بشأن عدم معرفة موعد حدوثه وكيفيةها. ومع ذلك، إذا وُضِعنا في موقف أُجبرنا فيه على التفكير في شكل موتنا وتأثير موتنا على الآخرين، سيشعر معظم الناس بعدم الارتياح بشكل ما. إن موت شخص قريب أو معروف لنا يكون محزنًا في حد ذاته، ولكنه يؤدي أيضاً إلى زيادة وعينا بفنائنا، ويقودنا إلى التفكير في هذه القضايا. وإذا رأينا شخصاً يعاني من مرض طويل الأمد قبل الموت، فقد نربط بين المرض المصحوب بمعاناة شديدة وبين الموت المؤكد. وإذا حدثت وفاة مفاجئة، وخاصة لشخص كان يُنظر إليه سابقاً على أنه "يتمتع بصحة جيدة"، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة إحساسنا بالضعف والعجز.

٣- بعد أن واجهت مشكلة طبية بنفسك

قد تقودنا المعاناة من مشكلة طبية إلى "الانغماس" بشكل أكبر في أحاسيسنا وتغيراتها الجسدية، وتنبهنا إلى احتمالات تعرضنا لمزيد من المشكلات الطبية أو حتى الموت. غالباً ما يقوم الأطباء عند شرح التشخيص، بمراجعة المخاطر والمضاعفات المحتملة لهذا التشخيص مع المريض، وينبهونهم إلى معلومات لم تكن معروفة لهم من قبل. علاوة على ذلك، بالنسبة للأشخاص الذين تغلبوا على حالة طبية (مثل السرطان أو النوبة القلبية)، فإن إصابتهم بهذه الحالة مرة واحدة يزيد لديهم احتمالية تكرار المشكلة. إن التركيز على المخاطر المحتملة والمضاعفات وفرص التكرار يمكن أن يزيد من إحساسنا بحدوث تهديدات مستمرة لصحتنا، ويجعلنا نشعر بمزيد من القلق.

4- وجود أحد أفراد الأسرة يعاني من قلق الصحة

إننا نميل إلى تعلم كثير عن العالم ممن حولنا. لذلك إذا كبرنا ونحن نلاحظ أو نستمع إلى قلق الآخرين بشأن الصحة، وقيامهم بالفحص لعلامات المرض أو الإصابة بشكل متكرر؛ فيُحتمل بدرجة أكبر أن نستخدم استراتيجيات التعايش نفسها عندما نواجه مشكلات أو أحاسيس متعلقة بالصحة.

٥- المعلومات السلبية من وسائل الإعلام أو الإنترنت

تتيح لنا وسائل الإعلام والإنترنت اليوم الوصول الفوري إلى مجموعة من القصص المثيرة للاهتمام والمعلومات المتعلقة بالصحة. ومع ذلك، في محاولة "لبيع" تلك القصص، يتعين على وسائل الإعلام التأكد من أن برامجها أو قصصها تجذب انتباه الجمهور. وبالتالي يمكن أن تركز القصص المتعلقة بالصحة في وسائل الإعلام أو على الإنترنت على الأمراض النادرة والمشكلات الصحية المستعصية والحالات المميتة. علاوة على ذلك، يمكنهم إبراز تجارب المرضى الذين تم تشخيصهم بشكل خاطئ رغم جهودهم المتكررة في طلب المساعدة الطبية. إن التركيز الذي تفعله أحيانًا وسائل الإعلام على هذه الحالات والأحداث غير المحتملة يمكن أن يقودنا إلى التشكيك في رعايتنا الطبية، والنظر للأحاسيس والتغيرات الجسدية الحميدة بشك أكبر، ورؤية المشكلات الصحية غير المحتملة والتي تم تجاهلها سابقًا على أنها شائعة.

توقف لحظة لتدوين التجارب التي مررت بها والتي قد تزيد من مخاوفك بشأن صحتك.

زيادة الهشاشة المتعلقة بالصحة

من المنطقي أن هذه التجارب السلبية السابقة المتعلقة بالصحة قد تزيد من إحساسك العام بالهشاشة فيما يتعلق بصحتك. إذا كنت قد تعرضت في حياتك لتجارب سلبية متعلقة بالصحة؛ فقد يتطور لديك اعتقاد بأن صحتك معرضة للخطر، وقد تنتظر إلى المرض على أنه ليس شائعاً فحسب، بل ربما يكون مؤلماً أو مميتاً. في ظل هذا الشعور بالهشاشة الذي يحيط بك، فمن الطبيعي أن تركز انتباهك على الأحاسيس الجسدية أو المشكلات الصحية التي قد يتجاهلها الآخرون ببساطة.

سيتركز الجزء المتبقي من هذه المرحلة على محاولتك لتقليل مشاعر الضعف هذه وحماية صحتك من خلال تطوير قواعد وافتراضات متعلقة بالصحة، وتشغيل "حالة التأهب القصوى" لعلامات المرض.

حماية أنفسنا: قواعد وافتراضات غير مفيدة متعلقة بالصحة

يمكن أن توجد القواعد والافتراضات في جميع مجالات حياتنا، وهي موجودة بشكل عام لمساعدتنا على العمل بشكل جيد والحفاظ على صحتنا. في الغالب توفر لنا القواعد والافتراضات إرشادات مفيدة للعيش، طالما أنها واقعية ومرنة إلى حد ما. على سبيل المثال، قد تكون لديّ قاعدة تقول: "يجب أن أغسل أسناني مرتين يوميًا لمنع التسوس"، أو يكون لديّ الافتراض "إذا لم أمارس الرياضة بانتظام، فسيزداد وزني". تبدو هذه القواعد والافتراضات مفيدة من حيث أنها دقيقة إلى حد ما (أي أنه من المقبول عمومًا أن عدم ممارسة الرياضة سيؤدي إلى زيادة الوزن)، كما أنها مرنة أيضًا (على سبيل المثال، في حين أنه من الجيد تفريش الأسنان مرتين يوميًا، من غير المحتمل أن تكون هناك مشكلة إذا نسيت تفريشها من حين لآخر). ومع ذلك، يمكن أن نجد لدينا بعض القواعد والافتراضات غير المفيدة التي نحاول أن نقود حياتنا من خلالها. تميل القواعد أو الافتراضات إلى أن تكون غير مفيدة عندما تكون غير دقيقة و/ أو غير مرنة بطريقة ما.

في قلب قلق الصحة تكمن بعض القواعد والافتراضات غير المفيدة، والتي غالبًا ما تتكون من معلومات غير دقيقة أو عبارات "الينبغيات" أو "الإلزام" أو "إذا... إذن..." غير المرنة. تذكر أن ذلك يرجع غالبًا إلى تجاربك السابقة التي تكونت بسببها تلك القواعد أو الافتراضات. على سبيل المثال، تخيل أنك نشأت مع أب قلق للغاية، والذي كان يستجيب لأي شكوى صحية طفيفة بزيارة أو أكثر

للطبيب، وقضاء كثير من الوقت في القلق، حتى وإن ذكر الطبيب إنه لا يوجد ثمة شيء يُقلق. هذه التجارب قد تقودك إلى تكوين بعض الإرشادات (أي القواعد والافتراضات) حول صحتك. فيمكنك تكوين قاعدة بأنه "يجب أن أكتشف ما الذي يسبب هذا الإحساس". يمكنك أيضا أن تبدأ في افتراض "إذا لم أخبر الطبيب عن أي أعراض أشعر بها، فقد تفوتني معلومة مهمة".

ضع في اعتبارك أن قواعدك وافتراضاتك قد تكونت كوسيلة لمحاولة حمايتك، ولا تُعد مشكلة إلا عندما تكون غير دقيقة و/أو غير مرنة.

فيما يلي بعض القواعد والافتراضات الشائعة غير المفيدة المتعلقة بقلق الصحة.

أمثلة للقواعد غير المفيدة المتعلقة بالصحة:

- "يجب أن آخذ جميع الأعراض والتغيرات الجسدية على محمل الجد".
- "يجب أن أتخلص من كل الأعراض لأكون بصحة جيدة".
- "يجب أن أخبر الطبيب بجميع الأحاسيس الجسدية الجديدة".
- "يجب أن يكون لديّ تشخيص واضح حتى أتمكن من المضي قدماً".
- "يجب أن يكون طبيبي واثقا (متيقنا)".
- "يجب أن يكون طبيبي قادراً على شرح كل الأحاسيس والتغيرات الجسدية".

أمثلة لافتراضات غير المفيدة المتعلقة بالصحة:

"كل شعور بعدم الارتياح في جسدي وكل التغيرات الجسدية تُعد إشكالية".
 "إذا طلب طبيبي إجراء فحص ما، فلا بد أن هناك شيئاً ما على غير ما يرام".
 "إذا كان طبيبي لا يعرف بالضبط ما هي المشكلة، فلا بد أن الأمر خطير حقاً".
 "إذا لم آخذ من الطبيب "الروشتة" خالية تماماً، فلا بد أنني مريض".
 "إذا لم أستمّر في التحقق/ إجراء الفحوص، فقد يفوتني شيء مهم حقاً".
 "إذا لم أستمّر فيما أفعل، فقد يفوت طبيبي شيء مهم".
 "إذا لم أكن منتبهاً لكل إحساس في جسمي، فقد تزداد المشكلة الكامنة سوءاً".
 "إذا مرضت، فلا توجد فرص أخرى".
 "إذا فاتني اكتشاف عرض صحي مهم، فقد يتسبب هذا في وفاتي".

يمكن أيضاً الجمع بين القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة على النحو التالي:

"إذا لم يتمكن طبيبي من إخباري بالأمر بدقة، فلا بد أن الأمر خطير ويحتاج إلى مزيد من الفحوص".
 "يجب أن أواصل قياس حجم هذه الكتلة، وإلا فلن أعرف إذا ازدادت سوءاً".
 "الأطباء تفوتهم أشياء، لذلك يجب أن أرى عديداً من الأطباء المختلفين حتى أحصل على تشخيص واضح".

توقف لحظة لتفكر في أنواع القواعد أو الافتراضات التي قد تتبناها بشأن صحتك. خذ بضع دقائق لكتابتها. خذ لحظة أيضا للتفكير في كيفية ربط ذلك بتجاربك السابقة المتعلقة بالصحة.

حماية أنفسنا:

زيادة الحساسية المتعلقة بالصحة

هناك جزء مفيد جدًا من استجابة الهجوم/ الهروب وهو أنه يجعلك تركز انتباهك على التهديدات المحتملة، وطرق الهروب من هذه التهديدات. على سبيل المثال: إذا كنت تمشي في الأدغال وتتنظر إلى الزهور البرية وواجهت ثعبانًا، فسينجذب انتباهك إلى الثعبان، وقد تجد صعوبة في النظر إلى أي شيء آخر غير الثعبان، إلا إذا كنت تبحث عن الطريق الآمن وكان بعيدًا، أو إن كنت تبحث عن عصا تحمي بها نفسك. في تلك اللحظة، قد لا تركز على صوت النسيم الذي يهب عبر الأشجار، أو لون السماء والغيوم، أو إن كانت قدمائك تشعر بالراحة في حذائك، أو حركة الطيور بين الأشجار وهي تتمايل فوقها. فلقد استحوذ على انتباهك التركيز على التهديد الكائن أمامك، وعلى محاولة حماية نفسك من الأذى. قد تجد أيضًا عند مواصلة سيرك في ذلك اليوم، إنك تقوم بمسح (نقصي) الأرض بشكل متكرر. إنك تكون في حالة تيقظ أعلى بشكل عام. وقد تقفز حتى عند سماع صوت حفيف الأوراق أو مشاهدة حركة طفيفة تلمحها بطرف عينك.

معظم الناس في معظم الأوقات لا ينتبهون كثيرًا للانزعاج الطفيف، والتغيرات البسيطة في وظائف أجسامهم (مثل معدل ضربات القلب، وإفراز اللعاب)، والضوضاء الجسدية، والكتل الصغيرة والنتوءات التي تظهر وتختفي، ومستويات الطاقة التي تزداد أو تنقص في عضلاتهم. إننا في الغالب نقبل أن تكون أجسادنا مثل السيارات القديمة المزعجة - أحيانًا تعمل بشكل جيد، وأحيانًا

تعمل بشكل خشن قليلاً، ولكن في معظم الأحوال تستمر في العمل طالما نضيف الوقود ونقوم بصيانتها في بعض الأحيان.

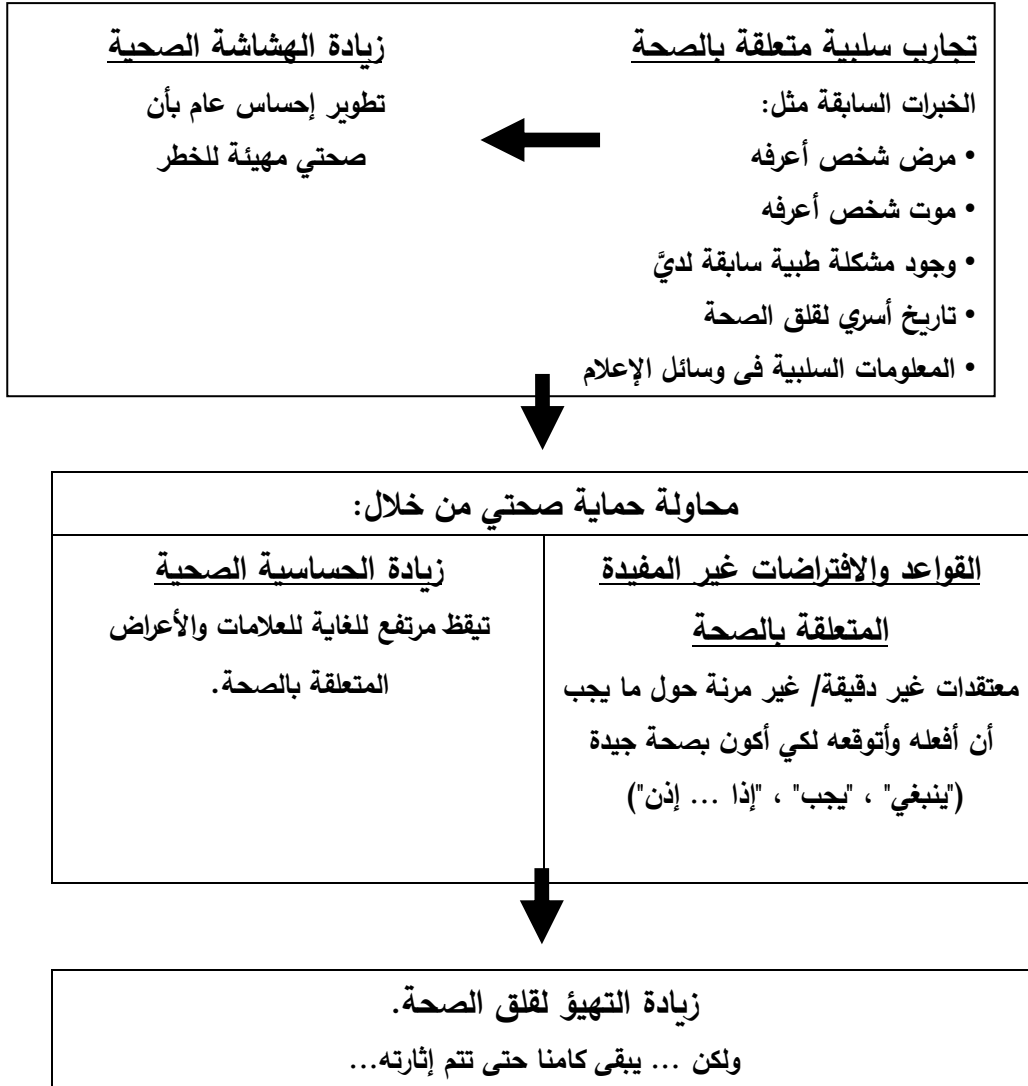
ومثلما يبدو الشعبان مهدداً للبعض منا، وبالتالي يشعرون بالحساسية تجاه وجوده من أجل حماية أنفسهم، يعتقد الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة أن صحتهم مهددة، ويصبحون حساسين لصحتهم من أجل حماية أنفسهم. في حالة قلق الصحة، قد تصبح أكثر حساسية أو "رصدًا" لعلامات المرض أو أعراضه. حيث يميل الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة إلى إيلاء اهتمام أكبر للأحاسيس أو التغيرات في أجسادهم، وملاحظة الأشياء التي لن يوليها الآخرون أي اهتمام.

لسوء الحظ، قد يؤدي التركيز على أحد الأعراض في بعض الأحيان إلى تضخيم شدة هذا العرض. بالعودة إلى مثال الشعبان الخاص بنا، كلما ركزت على الشعبان كلما زاد وعيك بحجمه ولونه وشكله. وبالمثل، كلما ركزت على أعراضك، زاد وعيك بخصائص هذا العرض، وزادت احتمالية القلق بشأن تلك الأعراض وزيادة التركيز عليها.

خذ لحظة للتفكير في العلامات أو الأعراض التي تميل إلى البحث عنها أو القلق بشأنها وقم بتسجيلها أدناه. هل لديك عرض وإحساس معين تركز عليه، أو هل لديك عدة أشياء تقلقك وتهتم بها؟ كم من الوقت تقضي كل يوم في التركيز على هذا العرض أو الإحساس؟

نموذج قلق الصحة: كيف ينشأ قلق الصحة؟

هناك طريقة مفيدة لتجميع المعلومات التي تم تناولها حتى الآن؛ وهي وضعها في رسم تخطيطي حتى تتمكن من رؤية كيفية انسجامها معًا. إننا نسمي هذا الرسم التخطيطي "نموذجًا". وخلال المضي في هذا الدليل سنشير في كثير من الأحيان إلى هذا النموذج لتذكير أنفسنا بكيفية نشأة قلق الصحة. وسنضيف أيضًا مزيدًا من المعلومات في المرحلة التالية حيث سنقوم بفحص عوامل استمرار قلق الصحة.



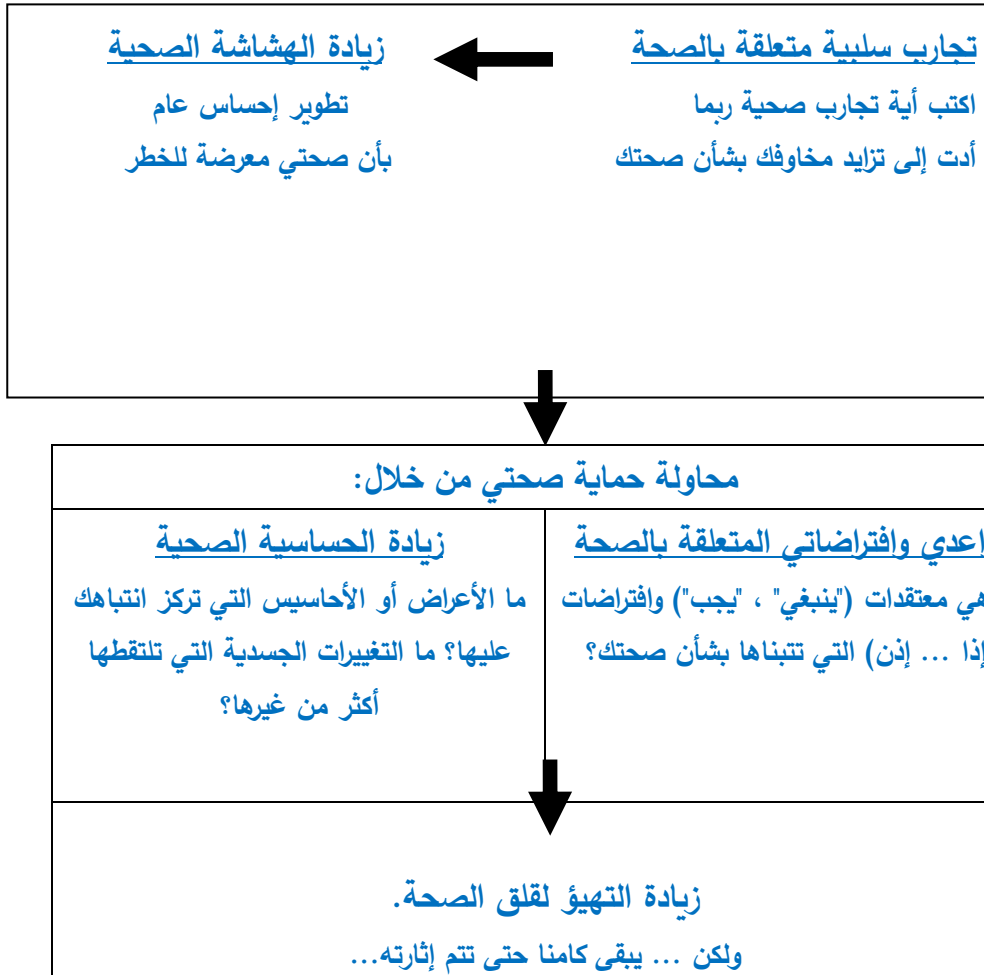
كما ترى، يوضح هذا النموذج أن تجاربنا السابقة يمكن أن تزيد من إحساسنا بالهشاشة، وتزيد مخاوفنا العامة بشأن صحتنا. ومن ثم نكون القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة في محاولة لحماية أنفسنا من الأذى، بالإضافة إلى أننا نكون أكثر رسدا للتغيرات والأحاسيس الجسدية.

يخبر عديد من الأشخاص أنواعا من أحداث الحياة التي ناقشناها، ومن ثم ستكون لدى نسبة منا قواعد وافتراضات معينة حول صحتهم، وستتم إثارة تلك القواعد والافتراضات مع الأحاسيس والتغيرات الجسدية. لذلك، قد نكون مهيين لقلق الصحة، ولكن قد يظل هذا التهيو في وضع الخمول حتى يؤدي حدث أو أكثر إلى إثارة قلق الصحة أو "تنشيطه".

في المرحلة التالية سنناقش الأشياء التي قد تؤدي إلى حدوث نوبة من قلق الصحة، وسناقش أيضًا عددًا من الأشياء التي تعمل على استمرار قلق الصحة بمجرد تنشيطه.

ورقة عمل: كيف ينشأ قلق الصحة

دعنا نتوقف لحظة للتفكير في كيفية تضافر (خبراتك السابقة المتعلقة بالصحة، وقواعدك وافتراضاتك المرتبطة بالصحة، ووعيك بأحاسيسك الجسدية)، وكيف أدى ذلك لزيادة احتمالية إصابتك بقلق الصحة. يمكنك العودة إلى الصفحات القليلة السابقة ونسخ إجاباتك من كل قسم في النموذج أدناه.



أخبار سارة...

نظرًا لأن قابليتك للإصابة بقلق الصحة ينشأ من مجموعة من العوامل البيولوجية إلى جانب بعض التجارب السلبية من الماضي المتعلقة بالصحة، فقد يبدو للوهلة الأولى أن الأمر محبطٌ بعض الشيء؛ لأن تركيبتنا البيولوجية وتجاربنا السابقة أشياء لا يمكن أن تتغير. لكن الخبر السار هو أنه لا يهم بالضرورة كيف نشأت قابليتك لقلق الصحة، طالما يتعلق الأمر بسيرك قدما في خطوات لتغييرها. من المهم حقًا الاستمرار في القراءة، لأنه كما ستري في المرحلة التالية، أن هناك أشياء نقوم بها في الحاضر "هنا والآن" تعمل على استمرار قلق الصحة، وهذه هي الأشياء التي يمكننا معالجتها وتغييرها من أجل التغلب على قلق الصحة.

ملخص المرحلة الثانية

- يمكن أن تجعلنا تجاربنا السابقة نشعر بالهشاشة إلى حد ما، وتقودنا إلى زيادة المخاوف بشأن صحتنا. وقد تشمل هذه التجارب السابقة:
 - وجود أفراد من العائلة أو ممن حولك يعانون من مرض خطير.
 - وفاة أحد أفراد الأسرة أو أي شخص تعرفه.
 - وجود أحد أفراد الأسرة يعاني من قلق الصحة.
 - إصابتك أنت نفسك بمرض طبي.
 - معلومات سلبية من وسائل الإعلام أو الإنترنت.
- يبدأ بعض الأشخاص الذين لديهم هذه الخبرات في تكوين قواعد وافتراسات غير مفيدة متعلقة بالصحة، ويصبحون أكثر حساسية تجاه الأحاسيس والتغيرات الجسدية. إننا نقوم بذلك في محاولة لحماية أنفسنا من التهديدات التي قد تتعرض لها صحتنا وتقليل إحساسنا العام بالضعف.
- إن القواعد والافتراضات المرتبطة بالصحة تم تصميمها بشكل عام لمساعدتنا على المُضي في حياتنا والحفاظ على صحتنا. وعندما تكون هذه القواعد والافتراضات غير دقيقة و/أو غير مرنة؛ هنا فقط تصبح غير مفيدة.
- يميل الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة إلى إيلاء اهتمام أكبر للأحاسيس أو التغيرات في أجسادهم، وملاحظة الأشياء التي لن يوليها الآخرون أي اهتمام.
- التركيز على الأحاسيس والتغيرات الجسدية يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تضخيم شدة الأعراض، مما يزيد من احتمالية القلق والتركيز على الأعراض.

• في حين أننا قد نكون عرضة لنشأة قلق الصحة بسبب (تجاربنا السابقة، والقواعد والافتراضات، والحساسية للأعراض أو التغييرات)؛ يمكن أن يظل قلق الصحة كامناً حتى يؤدي حدث أو أكثر إلى إثارته أو "تنشيطه".

التالي ...

في المرحلة التالية، سننظر فيما يثير قلق الصحة، وما الذي يعمل على استمراره بعد ذلك.

Helping Health Anxiety

About The Modules

CONTRIBUTORS

Dr Rebecca Anderson (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

Paula Nathan (MPsych¹)
Centre for Clinical Interventions

Dr Lisa Saulsman (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

¹Masters of Psychology (Clinical Psychology)

²Doctor of Philosophy (Clinical Psychology)

BACKGROUND

The concepts and strategies in these modules have been developed from evidence based psychological practice, primarily Cognitive-Behaviour Therapy (CBT). CBT for health anxiety is based on the approach that health anxiety is a result of problematic cognitions (thoughts) and behaviours.

REFERENCES

These are some of the professional references used to create the modules in this information package.

Abramowitz, J., Taylor, S., & McKay, D. (2010). Hypochondriasis and severe health anxiety. In McKay, D., Abramowitz, J., S., & Taylor, S. (Eds.). *Cognitive-behavior therapy: Turning failure into success* (pp. 327-346). Washington, DC: American Psychological Association.

Asmundson, G., & Taylor, S. (2005). *It's not all in your head: How worrying about your health could be making you sick – and what you can do about it*. New York: The Guilford Press.

Furer, P., & Walker, J. (2006). *Health anxiety treatment manual*. University of Manitoba: Manitoba.

Furer, P., Walker, J., & Stein, M. (2007). *Treating health anxiety and fear of death*. New York: Springer.

Papageorgiou, C., & Wells, A. (1998). Effects of attention training on hypochondriasis: A brief case series. *Psychological Medicine*, 28, 193-200.

Salkovskis, P., Warwick, H., & Deale, A. (2003). Cognitive-behavioural treatment for severe and persistent health anxiety (Hypochondriasis). *Brief Treatment and Crisis Intervention*, 3, 353-367.

Willson, R., & Veale, D. (2009). *Overcoming health anxiety: A self-help guide using cognitive behavioural techniques*. London: Robinson.

“HELPING HEALTH ANXIETY”

This module forms part of:

Anderson, R., Saulsman, L., & Nathan, P. (2011). *Helping Health Anxiety*. Perth, Western Australia: Centre for Clinical Interventions.

ISBN: 0 9757995 6 8

Created: August 2011

This is a translation of CCI (Centre for Clinical Interventions) materials as translated by [Amara Yehia Arafat] but not reviewed by CCI (Centre for Clinical Interventions, Western Australia). Original materials located at www.cci.health.wa.gov.au

المرحلة الثالثة

تحديد عوامل استمرار قلق الصحة

١- مقدمة

٢- كيف يُستثار قلق الصحة؟

٣- عوامل استمرار قلق الصحة

- التفكير غير المفيد المتعلق بالصحة
- زيادة أعراض القلق
- التركيز على الأعراض
- سلوكيات الفحص وطلب التطمين
- التجنب وسلوكيات الأمان

٤- وضع كل ذلك معًا

- نموذج استمرار قلق الصحة
- ورقة عمل: كيف يستمر قلق الصحة لديّ

٥- الأخبار السارة

٦- ملخص المرحلة الثالثة

٧- حول المراحل

مقدمة

في المرحلة الثانية اكتشفنا كيف تؤدي تجاربنا السابقة إلى الشعور بمزيد من الهشاشة، مما يزيد من قلقنا بشأن صحتنا، ويجعلنا أكثر حساسية للأعراض والتغيرات الجسدية. كما أوضحنا أيضًا مفهوم قلق الصحة "الكامن" - فإن لم نواجه شيئًا "ينشط" أو يثير قلق الصحة لدينا، فقد لا يزعجنا ذلك لفترات من حياتنا. في هذه المرحلة، سنناقش المحفزات المحتملة لقلق الصحة، ونستكشف كيف يستمر قلق الصحة على المدى الطويل.

كيف يُستثار قلق الصحة؟

إذا سألت أي صديق أو أحد أفراد الأسرة عما إذا كان شعر بالقلق من قبل بشأن صحتهم، فمن المحتمل أن يعترف معظم الناس بوجود بعض المخاوف المتعلقة بالصحة من وقت لآخر. ومن المثير للاهتمام أن المحفزات التي قد تجعل أي شخص يقلق بشكل عابر بشأن صحتهم؛ قد تؤدي هي نفسها إلى نوبة من قلق الصحة لدى شخص آخر. يحدث قلق الصحة عادةً عندما يتم الجمع بين هذه المحفزات ومجموعة من القواعد أو الافتراضات غير المرنة وغير الدقيقة المتعلقة بالصحة. يمكن أن تكون هذه المحفزات شيئًا داخليًا بداخلنا أو خارجيًا في بيئتنا.

المحفزات الداخلية

تذكر أننا في المرحلة السابقة تحدثنا عن أجسادنا على أنها مثل السيارات القديمة. بمرور الوقت سوف تُصدر بعض الأصوات الغريبة وتصبح حركتها أكثر خشونة.

وبشكل عام من الطبيعي أن تشعر ببعض الأعراض والأحاسيس في جسمك. مثل: عدم ارتياح في المعدة، أو وخز أو تنميل في أجزاء من جسمك، أو طنين في أذنيك، أو حساسية للحرارة أو البرودة في أسنانك، أو زيادة أو نقصان في معدل ضربات القلب، أو تغيرات في إنتاج اللعاب، أو تغيرات في مستويات الطاقة لديك. وقد تظهر عليك أعراض جديدة أو غير مألوفة في بعض الأحيان، مثل الصداع أو ظهور طفح جلدي. وكثير من النساء أثناء الحمل يخبرن مجموعة من الأحاسيس الجديدة والغريبة في أجسادهن. وقد يكون لديك حتى أحاسيس غير معتادة، مثل ظهور طعم غريب في فمك أو ارتعاش عضلي تحت إحدى عينيك.

المحفزات الخارجية

إلى جانب الأشياء التي تحدث داخل جسمك، يمكن لعدد من الأشياء الخارجية أن تلفت انتباهك نحو احتمالية وجود مشكلات صحية لديك، وبالتالي تؤدي إلى نوبات لقلق الصحة. على سبيل المثال:

- وجود مخاوف متعلقة بالصحة في الأخبار العامة.
- المواعيد الطبية القادمة.
- أن تكون على اتصال بأشخاص مرضى.
- أن تعرف أن شخصا تم تشخيصه بمرض ما.
- أن تحصل على نتائج غير حاسمة في فحص طبي.
- إخبارك بأن لديك مشكلة صحية.
- أن تكون بعيدا عن أنظمة الرعاية الصحية المعروفة (مثل السفر إلى الخارج).

توقف لحظة لكتابة أي محفزات واجهتها فيما يتعلق بقلق الصحة

المحفزات الخارجية

المحفزات الداخلية

عوامل استمرار قلق الصحة

١ - التفكير غير المفيد المتعلق بالصحة

إذا تم تنشيط القواعد أو الافتراضات غير المفيدة المتعلقة بالصحة لديك من خلال أنواع المحفزات المذكورة للتو؛ فمن المحتمل أن تؤثر سلباً على طريقة تفكيرك في الأحاسيس أو التغيرات في جسمك، وتفسيرك للمعلومات الصحية من المتخصصين الطبيين أو المصادر الأخرى. وبشكل عام، يميل الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة إلى المبالغة في تقدير احتمالية تعرضهم لمشكلة صحية خطيرة، والتقليل من قدرتهم على التعامل مع مثل هذه المشكلة. كما يميلون إلى استبعاد العوامل الأخرى التي تشير إلى أن الأمور لن تكون بالسوء الذي يتوقعونه (على سبيل المثال، يتغاضون عن طمأننة الطبيب بأن المرض الخطير غير مرجح، ويركزون على النتائج المحتملة الأكثر سلبية بدلاً من فرص العلاج أو الإدارة الجيدة). وبذلك فإنهم ينظرون إلى جميع التجارب المتعلقة بالصحة على أنها "كارثة" أو سيناريو "أسوأ الاحتمالات".

التفسير الكارثي للأحاسيس الجسدية

إذا كان لديك افتراض غير مفيد متعلق بالصحة مثل "كل التغيرات الجسدية ومشاعر عدم الارتياح هي علامة على مرض خطير"، ثم واجهت بعد ذلك شعوراً بالألم في مفاصلك، فقد تأتي تفسيراتك لهذا الألم كارثية، وقد تتوقع أشياء مثل: "قد

يكون هذا التهاب المفاصل"، أو "ربما أعاني من سرطان العظام"، أو "هذه المشكلة ستكون نهايتي"، أو "قد يكون هذا شيئاً غير قابل للشفاء".

التفسير الكارثي للمعلومات المتعلقة بالصحة

قد تسيء تفسير المعلومات المتعلقة بالصحة بحيث تفترض أنها تشير إلى أنك معرض لخطر أكبر مما أنت عليه بالفعل. على سبيل المثال، تخيل أن طبيبك أخبرك أن فحص الدم أظهر انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، ولكن هذا "ربما بسبب نزلات البرد فقط". إذا كان لديك افتراض غير مفيد متعلق بالصحة يقول: "إذا كان طبيبي لا يعرف بالضبط ما هي المشكلة، فلا بد أنها خطيرة حقاً"، فمن المرجح أن تخطر ببالك أفكار مثل "ربما يكون سرطان الدم"، أو "أن الطبيب لم يطلب فحوصات لمشكلات خطيرة مثل فيروس نقص المناعة أو مرض الذئبة، ومن المحتمل أن يكون هذا ما أعانيه بالفعل".

خذ لحظة لكتابة بعض الأفكار غير المفيدة التي جالت بخاطرك فيما يتعلق

بصحتك. ما الذي تقوله لنفسك عن صحتك أو عن أية معلومات صحية تلقيتها؟

٢- زيادة أعراض القلق

يمكنك أن تتخيل أنك إذا بدأت في التفكير في أفكار كارثية حول أحاسيسك الجسدية، فمن المحتمل أن تحفز استجابة الهجوم/ الهروب كرد فعل على هذا التهديد الذي تصوريته بشأن صحتك. إن استجابة الهجوم/ الهروب وُجدت في الأساس لحمايتك من خلال مساعدتك على الكفاح في معركة "الهجوم" أو "الهروب" لإنقاذ نفسك، وتشتمل استجابة الهجوم/ الهروب على التغيرات الجسمية التالية:

- توتر عضلي أو الشعور بالتعب أو الإرهاق.
 - قفز وتسارع ضربات القلب أو خفقان القلب.
 - تغيرات في معدل التنفس/ ضيق التنفس أو ألم أو ضغط في الصدر.
 - دوار، أو دوخة، أو تشوش الرؤية، أو ارتباك، أو إحساس بعدم الواقعية، وهبّات مفاجئة من السخونة.
 - خدر ووخز في أصابع اليدين والقدمين.
 - زيادة في التعرق.
 - اتساع حدقة العين، أو عدم وضوح الرؤية، أو ظهور بقع أمام العينين، أو شعور بأن الضوء شديد السطوع.
 - جفاف الفم، أو الشعور بالغثيان أو اضطراب في المعدة.
- قد تلاحظ واحدًا من هذه الأعراض أو بعضًا منها أو كلها بدرجات متفاوتة الشدة.

تعد استجابات الإنذار الجسدي هذه مهمة عند مواجهة خطر حقيقي، ولكنها يمكن أن تحدث أيضًا عندما يكون هناك خطر متصور فقط. فإذا قلت لنفسك أشياء مثل: "قد يكون هذا شيئًا غير قابل للشفاء" أو "قد أصاب بالسرطان" أو "ربما فات طبيبي شيء مهم"، فمن المحتمل أن تؤدي هذه المخاطر المتصورة إلى ظهور أعراض القلق (الهجوم/الهروب).

لسوء الحظ، يمكن للأشخاص الذين يميلون إلى ملاحظة العلامات والأعراض الصحية والقلق بشأنها أن يقلقوا من بعض أعراض القلق نفسه (الهجوم/الهروب) - ويقفزوا إلى استنتاج مفاده أن هذه الأعراض تُعد علامة أخرى على وجود مشكلة ما حقًا!

هذا يمكن أن يؤدي إلى حلقة مفرغة، حيث تؤدي الأعراض الجسمية إلى أفكار كارثية حول وجود مشكلات صحية، وتؤدي هذه الأفكار بدورها إلى ظهور أعراض القلق، ثم تؤدي أعراض القلق بعد ذلك إلى مزيد من الأفكار الكارثية حول وجود مشكلات صحية، والتي تؤدي إلى مزيد من أعراض القلق ... وهكذا. وعلى الرغم من أن المحرك لكل هذا تفكيرك الكارثي، فإنك تخبر أعراضًا جسدية حقيقية.

٣- التركيز على الأعراض

في المرحلة الثانية ناقشنا أن جزءاً مفيداً من (استجابة الهجوم/ الهروب) هو التركيز على الشيء الذي نشعر بالتهديد منه، وكذلك التركيز على طرق الهروب المحتملة، وتحدثنا أيضاً عن مدى صعوبة تشتيت انتباهنا بعيداً عن هذا الشيء المهدد، واستخدمنا مثال مواجهة ثعبان في الأدغال، حيث يصعب علينا في هذا الموقف أن ننظر بعيداً عنه.

لسوء الحظ، يمكن أن يؤدي تركيز انتباهك على شيء ما إلى تضخيم شدة شعورك بذلك الشيء. بالعودة إلى مثال الثعبان، إذا ركزت انتباهك على الثعبان، فسوف تصبح أكثر وعياً بحجمه ولونه وشكله. وقد تلاحظ أيضاً صوته وهو يتحرك على الأرض. بشكل عام، يساعدك التركيز بشكل مكثف على تقييم التهديد الذي أمامك ومراقبته.

وبالمثل، كلما ركزت على أعراضك، زاد وعيك بخصائص تلك الأعراض. ولسوء الحظ، يمكن أن يؤدي التركيز على أحد الأعراض إلى تضخيم شدة هذا العرض، وبالتالي خلق مزيد من القلق بشأنه وزيادة رغبتك في التركيز على هذا العرض أكثر.

جرب هذا التمرين. ركز على معدتك ... لاحظ كل الأحاسيس الصغيرة التي يمكن أن تشعر بها... قد يكون ذلك انقباضاً أو قرقرة أو رفرفة أو أي شيء آخر... ركز تماماً على أي أعراض أو أحاسيس تلاحظها في معدتك. ابق مع هذا لمدة دقيقة واحدة. اسأل نفسك الآن ما إذا كنت قد لاحظت أيًا من هذه الأحاسيس قبل أن تركز عمداً على معدتك؟ أيضاً مع استمرار الوقت الذي تقضيه في التركيز على معدتك، هل أصبحت الأحاسيس ملحوظة بشكل أكبر أم أقل؟

عادة ما يجد الناس أنهم يلاحظون مجموعة كاملة من الأحاسيس لم يكونوا على دراية بها من قبل، ويبدو أن هذه الأحاسيس تزداد مع مرور الوقت، لأنهم يهتمون بها أكثر فأكثر.

خذ لحظة لكتابة أي أعراض أو أحاسيس أو مناطق في جسمك تميل إلى التركيز عليها بانتظام. عندما تركز انتباهك، ما أكثر شيء تلاحظه في هذا العرض أو الإحساس أو المنطقة المعينة في جسمك؟ هل شد؟ ما هو مستوى الألم أو الانزعاج؟ هل يبقى على حاله أم يتغير؟

٤ - سلوكيات الفحص وطلب التطمين

إن الفحص أو طلب التطمين بشأن الأشياء التي نشعر بالقلق حيالها هو سلوك بشري طبيعي. تراود معظم الناس فكرة "لست متأكدًا من أنني أغلقت الباب جيدًا"، ثم يعودون ويقومون بالتحقق أو يسألون رفيقًا "هل أغلقت الباب عندما غادرنا؟" يؤدي ذلك عادةً إلى انخفاض شعورنا بالقلق، ويسمح لنا بمواصلة حياتنا اليومية.

فيما يتعلق بصحتنا، فإننا نشجع بالفعل على فحص أجسادنا وطلب التطمين. على سبيل المثال، غالبًا ما يتم تشجيعنا على مراقبة الشامات بحثًا عن أي تغيير يطرأ عليها، وكثيرًا ما يتم تشجيع النساء على فحص أثدائهن بانتظام. ونحن نشجع بعد ذلك على الاتصال بالمختص الطبي إذا كنا قلقين بشأن صحتنا، أو لاحظنا أي تغييرات في صحتنا العامة. تمامًا مثل المثال السابق عندما تحققنا مما إذا كنا قد أغلقنا الباب، فإن التحقق أو الحصول على تطمينات بشأن حالتنا الصحية سيؤدي عادةً إلى انخفاض الشعور بالقلق، ويسمح لنا بمواصلة حياتنا اليومية.

ومع ذلك، يميل الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة إلى الاستمرار في الانشغال بشأن صحتهم، والاستمرار في الشعور بالقلق، وبالتالي يواصلون الانخراط في الفحص وطلب التطمين لمحاولة تقليل مخاوفهم ومشاعرهم غير السارة.

ولقد أقرَّ الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة بالانخراط بشكل متكرر في:

- تفحص أجسادهم في المرأة بحثًا عن علامات لعدم التناسق أو مناطق تغير لونها أو شامات أو كتل جديدة.
- وخز أو جس أو قرص الجلد أو الثدي أو المعدة أو مناطق أخرى من الجسم.
- فحص إفرازات الجسم (مثل اللعاب والبول والبراز) بحثًا عن وجود دم أو علامات للعدوى.
- قياس أجزاء من أجسامهم (على سبيل المثال، باستخدام شريط قياس أو مسماك (مقياس السُمك calipers)).
- مراقبة العمليات الجسدية (مثل قياس النبض وفحص ضغط الدم).
- مراقبة وزن الجسم أو إفرازات الجسم.
- سؤال أفراد الأسرة والأصدقاء ومقدمي الرعاية الصحية عن أعراضهم.
- البحث عن أعراضهم على الإنترنت أو في المقالات الطبية.
- نشر أعراضهم على مواقع الإنترنت للحصول على آراء الآخرين حول أعراضهم.
- طلب إجراء الفحوصات أو التقييمات الطبية والآراء الثانية.

في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي جهود الفحص المبذولة في حد ذاتها إلى ظهور أعراض جديدة ومؤلمة. على سبيل المثال، عند إجراء الفحص الذاتي للثدي، لاحظت سالي منطقة متكتلة لم تلاحظها من قبل، ومن ثم استمرت على مدار الأسبوعين التاليين في الانشغال بهذه المنطقة، وبدأت في الضغط عليها وعصرها لمعرفة ما إذا كانت أي من الكتل تتضخم. كما أبلغت صديقها ووالدتها بمخاوفها، وجعلتهما أيضا يتفحصان المنطقة المتكتلة وطلبت منهما النصيحة.

يوماً بعد يوم، أصبحت المنطقة أكثر إيلاًماً وأكثر حساسية للمس، مما تسبب في زيادة مخاوفها من وجود مشكلة خطيرة.

خذ لحظة لكتابة أي سلوكيات فحص أو تطمين تنخرط فيها. ما الذي كنت تبحث عنه؟ ماذا وجدت؟ هل كانت هناك أي عواقب سلبية لسلوكيات الفحص والتطمين؟

٥ - التجنب وسلوكيات الأمان

في الوقت الذي يهدف فيه الفحص وطلب التطمين إلى تقليل مشاعر القلق الموجودة بالفعل، فإن التجنب وسلوكيات الأمان استراتيجيات تستخدم لمحاولة منع الشعور بالقلق.

يحاول الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة بشكل عام تجنب المحفزات الداخلية والخارجية التي حددناها مسبقاً في هذه المرحلة. ولكي تتجنب المحفزات الداخلية، يمكنك تجنب الانخراط في الأشياء التي تؤدي إلى تغييرات في حالتك الفسيولوجية، وقد يشمل ذلك: ممارسة الرياضة، وصعود السلالم، وشرب القهوة، وممارسة الجنس، وتناول الأطعمة الغنية بالتوابل، وشرب المشروبات الغازية. ولتجنب المحفزات الخارجية، يمكنك تجنب مجموعة كبيرة من الأشخاص أو الأماكن أو المواقف التي قد تُذكرك بالمشكلات الصحية. على سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن يشمل ذلك:

- تجنب المتخصصين الطبيين أو الفحوصات.
- تجنب عيادات الأطباء.
- تجنب مشاهدة الأخبار أو قراءة الجرائد.
- تجنب المرور بأماكن إقامة الجنازات.
- تجنب كتابة وصية.
- تجنب الاتصال الهاتفي لمعرفة نتائج الفحوص.
- تجنب تناول أطعمة قريبة من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
- تجنب زيارة صديق مصاب بمرض غير معدٍ.
- تجنب استخدام الحمامات العامة.
- تجنب مشاهدة الأعمال الدرامية الطبية على التلفاز.

- تجنب زيارة قريب كان مريضاً في الوقت القريب.
- تجنب قراءة المعلومات التي يقدمها الطبيب.

يعني التجنب أنه على المدى القصير سيكون هناك عدد أقل من الأشياء التي تُذكرك بالقضايا المتعلقة بالصحة، وبالتالي تقل فرصة الشعور بالهم والقلق. ومع ذلك، قد يؤدي التجنب على المدى الطويل إلى الإبقاء على مخاوفك مستمرة، أو حتى يزيدها سوءاً.

أما مصطلح "سلوكيات الأمان" safety behaviors فيشير إلى شكل خفي من التجنب. إن استخدام سلوكيات الأمان يعني أنك قد لا تتجنب شيئاً ما بشكل صريح، ولكنك ستقترب فقط من ذلك المكان أو الشخص أو النشاط المخيف إذا اتخذت خطاً احترازية معينة. على سبيل المثال، قد يظل الشخص الذي يخشى الإصابة بمرض الالتهاب السحائي meningococcal disease في الذهاب للأماكن العامة ويستمر في حضور المواعيد الطبية، ولكنه يفعل ذلك فقط إذا كان يحمل مطهرًا لليدين ومضادات حيوية في حقيبته. وبالمثل، فإن الشخص الذي يخاف من الإصابة بنوبة قلبية قد يستمر في ممارسة أعماله اليومية، إذا كان فقط بالقرب من الآخرين، ويحمل هاتفًا محمولاً في جميع الأوقات تحسباً لاحتياجه استدعاء سيارة إسعاف.

إن الانخراط في سلوكيات الأمان يقلل بشكل مؤقت من مخاوفك وهمومك المتعلقة بالصحة، ولكنك في المرة القادمة التي تواجه موقفًا مشابهًا، ستشعر بالحاجة إلى استخدام سلوكيات الأمان نفسها مرة أخرى، ولن تتعلم أبدًا أنه يمكنك البقاء على قيد الحياة بدونها.

خذ لحظة لكتابة الأشياء التي قد تتجنبها بسبب مخاوفك الصحية. يمكن أن يشمل ذلك بعض الأشخاص أو الأماكن أو الأنشطة أو الأشياء أو حتى الأطعمة. وهل هناك أي سلوكيات تنخرط فيها لزيادة إحساسك بالأمان في هذه المواقف.

ملحوظة: على الرغم من أن التجنب والفحص يبدوان كأنهما سلوكان متضادان، فإنه يمكنك الانخراط في كليهما في الوقت نفسه. على سبيل المثال، قد تقومين بإجراء فحوصات ذاتية يومية للثدي، ولكنك تتجنبين إخبار الآخرين بمخاوفك أو تتجنبين الذهاب إلى الطبيب للقيام بفحصك مرة أخرى. وأيضاً يمكنك الانخراط في الفحص فقط أو التجنب فقط، أو القليل من كل منهما. ويختلف الجمع بين سلوكيات الفحص والتجنب من شخص لآخر.

وضع ما سبق في نموذج متكامل: نموذج لكيفية استمرار قلق الصحة

من الطبيعي تمامًا أن يخبر جميعنا المحفزات الداخلية والخارجية، فكيف إذن تؤدي هذه المحفزات إلى قلق الصحة؟ تذكر ما ورد في المرحلة الثانية، إنك إذا كنت قد مررت بالفعل بعدد من التجارب السلبية المتعلقة بالصحة، فقد تكون أكثر حساسية أو "أكثر انتباهًا" من الآخرين لملاحظة هذه المحفزات الداخلية والخارجية. وهذا بدوره يزيد من فرصة ظهور قلق الصحة لديك.

بشكل عام، عندما تتعرض لمحفز داخلي أو خارجي، يتم تنشيط القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة لديك. ونعني بـ "التنشيط" أنها تنتقل من حالة السكون إلى التشغيل مثل مفتاح الضوء. وبمجرد تنشيطها، تبدأ تلك القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة في التأثير على طريقة تفكيرك وشعورك وسلوكك استجابةً لتلك المحفزات.

فإذا كانت لديك قواعد وافتراضات مرنة وواقعية بشأن صحتك، فمن المحتمل ألا تقلقك هذه المحفزات الداخلية أو الخارجية كثيرًا. على سبيل المثال، لنفترض أنك لاحظت ألمًا في مفاصلك، بالإضافة إلى أن لديك قاعدة مفادها "إذا تفاقم هذا الألم أو ظل مستمرًا لمدة أسبوع آخر، فسأطلب من الطبيب فحصه". هذه القاعدة:

- **مرنة:** لأنها تسمح بأن يخبر الفرد أحاسيس جسدية قد تكون طبيعية، دون قلق مفرط، أو فحص، أو طلب رأي طبي.
- **واقعية:** لأنها لا تستبعد احتمال وجود مشكلة قد تحتاج إلى عناية طبية.

ومع ذلك، تخيل أنك لاحظت ألماً في مفاصلك، بالإضافة إلى وجود افتراض غير مفيد مفاده "كل مظاهر عدم الراحة والتغيرات الجسدية علامة على وجود مرض خطير". كيف يمكنك بعد ذلك الاستجابة لهذا الألم في مفاصلك؟ ما الأفكار التي ستفكر فيها بشأن هذا الألم؟ كيف ستشعر في كل مرة تفكر فيها في ألم المفاصل؟ كيف تقيّم فرصتك في الحصول على نتيجة جيدة حتى إذا قمت بزيارة الطبيب؟

بشكل عام، عندما تتبنى مجموعة من القواعد أو الافتراضات غير المفيدة المتعلقة بالصحة بالإضافة إلى المحفزات الداخلية أو الخارجية التي تلفت انتباهك إلى مشكلات متعلقة بالصحة، فأنت مهية بشكل أكبر للتعرض لقلق الصحة، لأنك من المرجح أن تفسر الأحاسيس أو التغيرات الجسدية على أنها علامة على مرض خطير، وأن تسيء تفسير المعلومات المتعلقة بالصحة، مما يثير مزيداً من الأحاسيس الفسيولوجية في كل مرة تقلق فيها.

بعد ذلك ربما تتخبط في جهود غير مفيدة للسيطرة على قلقك أو تقليل خطر إصابتك بالمرض، وقد تقوم بالتركيز على أعراضك في محاولة لرصد أي تهديدات صحية محتملة وتقييمها، وربما تقوم بالفحص أو طلب التطمين لزيادة إحساسك باليقين بشأن حالتك الصحية، وقد تتخبط أيضاً في تجنب أوسلوكميات الأمان لمنع إثارة قلق الصحة لديك من البداية.

على المدى القصير، قد توفر لك هذه السلوكيات إحساساً مؤقتاً بالراحة أو السيطرة على مخاوفك الصحية، ولكن على المدى الطويل يمكن أن تكون هناك عواقب سلبية لهذه السلوكيات. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي التركيز على الأعراض إلى زيادة شدة تلك الأعراض، وقد تؤدي سلوكيات الفحص إلى حساسية أو التهاب، وقد يؤدي البحث عن الفحوصات الطبية ثم إجرائها إلى تعزيز اعتقادك بأن هناك مشكلة ما، ويمكن لعملية البحث عن الأعراض أن تنبّهك إلى تفسيرات

كارثية ولكن غير مرجحة لأعراضك. كل هذه السلوكيات تخلق مزيداً من الهم وبالتالي تعمل على استمرار قلق الصحة لديك.

يمكن أيضاً أن يُحد التجنب وسلوكيات الأمان من قدرتك على تعلم أي شيء جديد عن صحتك. فمثلاً:

- إن لم تذهب إلى الطبيب لإجراء فحص طبي، فلن تعرف ما إذا كنت تعاني من مشكلة صحية أم لا. لذلك قد تستمر في القلق بشأن صحتك.
- إذا تجنبت الأشخاص أو الأماكن التي تعتقد أنها قد تجعلك مريضاً، فلن تتمكن أبداً من معرفة مدى إمكانية حدوث ذلك بالفعل؛ لذلك على المدى الطويل تشعر أنه يجب عليك الاستمرار في تجنبه.

توضح الحالة التالية كيف يمكن أن يتطور الأمر إلى حلقة مفرغة من القلق.

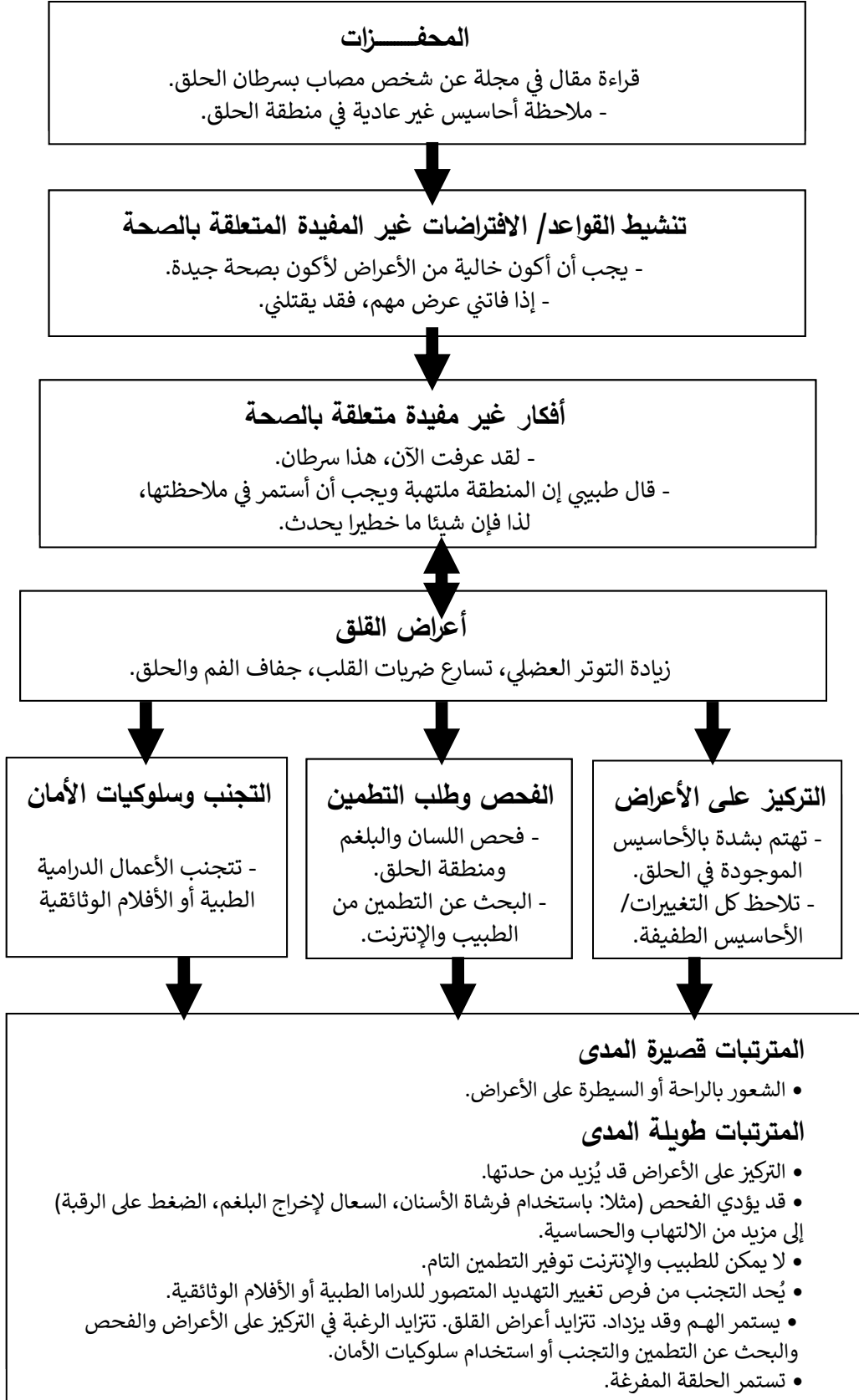
كانت سارة امرأة في الثلاثين من عمرها استمرت في زيارة طبيبها شاكية من التهاب في الحلق. كانت سارة قد قرأت مقالاً في مجلة عن شخص أصيب بسرطان الحلق على الرغم من كونه غير مدخن. منذ ذلك الحين بدأت سارة تشعر بالقلق من أنها قد تصاب بهذه المشكلة أو أن هذه المشكلة لديها بالفعل، وبدأت في ملاحظة بعض الأحاسيس غير المعتادة في منطقة حلقها (أي ضيق tightness، أو جفاف في الحلق). أخبرها طبيبها لعدة مرات أن حلقها "يبدو ملتهباً" ولكن لا توجد علامات على الإصابة بسرطان حقيقي. وأخبرها ألا تقلق بشأن الألم، وأن تعود لزيارته إذا تطورت الأعراض.

كانت سارة غير راضية عن استجابة طبيبها، وبدأت تتخبط يومياً في سلوكيات السعال القسري لمحاولة "إخراج" أكبر قدر ممكن من البلغم حتى تتمكن من فحصه بحثاً عن وجود دم أو علامات للعدوى. وكانت أحياناً تستخدم فرشاة

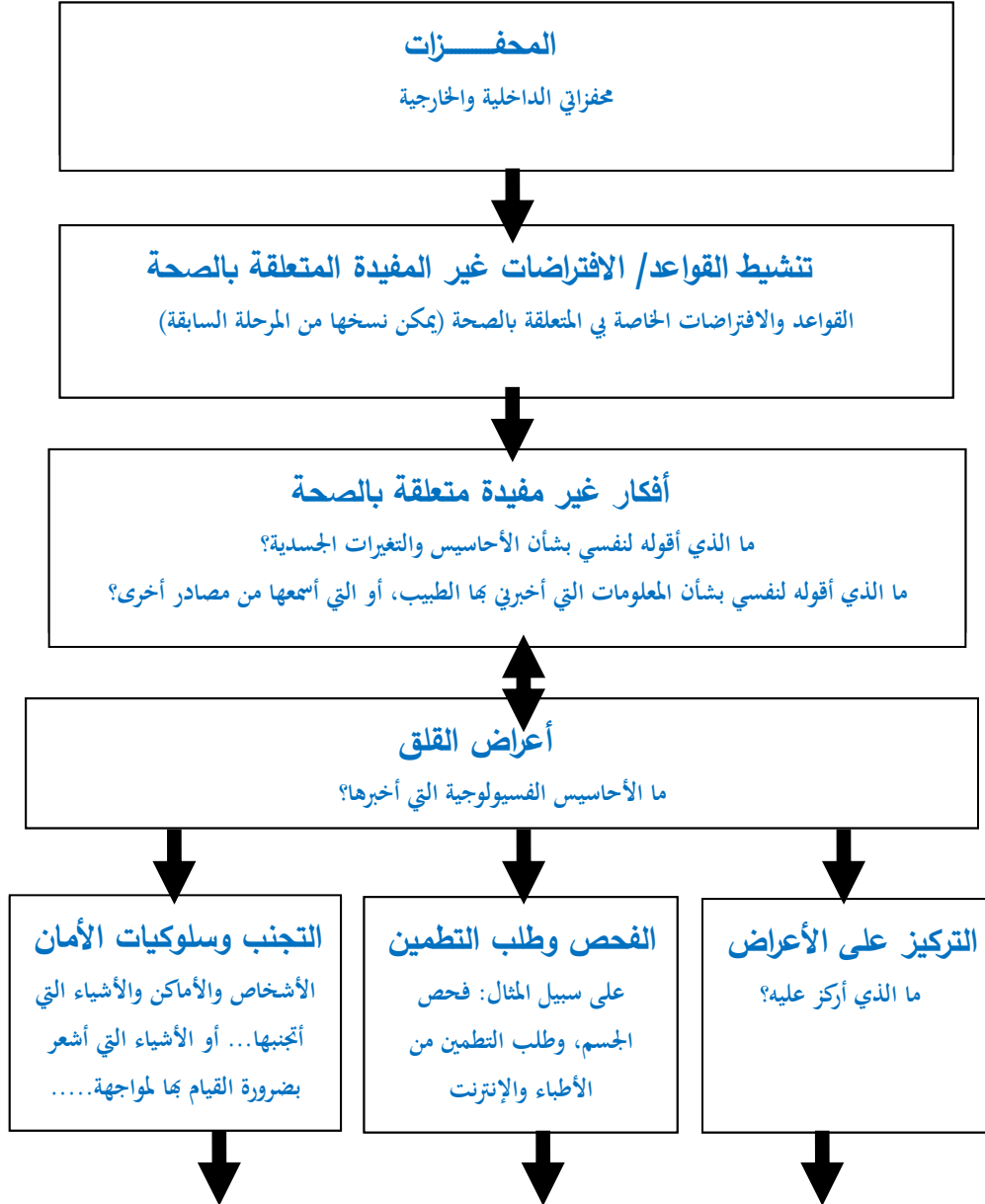
أسنانها للضغط على الجزء الخلفي من لسانها حتى تتمكن من التحقق من مناطق الألم، وانخرطت أيضًا في تفحص رقبته بيدها palpating بانتظام، والتحقق من وجود كتل ومناطق حساسة. واجهت سارة صعوبة في التركيز وفي أداء وظيفتها لأنها كانت تركز باستمرار على الأحاسيس غير السارة، وكانت تقضي وقتًا في البحث عبر الإنترنت عن أعراضها والعلاجات المحتملة. بدأت سارة في إطفاء التلفاز كلما ظهرت الأعمال الدرامية الطبية أو الأفلام الوثائقية الطبية على التلفزيون، قائلة إنها ليست بحاجة إلى تذكيرها بما قد يحمله المستقبل.

في الصفحة التالية، قمنا بجمع هذه المعلومات في نموذج، بحيث يكون من السهل معرفة كيف تم تحفيز قلق الصحة لسارة وعوامل استمراره. كما ترى، وقعت سارة في حلقة مفرغة من القلق على صحتها، وظهور مزيد من الأعراض الفسيولوجية (بما في ذلك الأعراض الفسيولوجية للقلق نفسه)، والانخراط في جهود للسيطرة على قلقها و أعراضها، مما قد يؤدي على المدى الطويل إلى استمرار المشكلة. في الصفحة التي تلي النموذج الخاص بسارة، توجد ورقة عمل لتجميع المثال الخاص بك.

عوامل استمرار قلق الصحة لدى سارة



عوامل استمرار قلق الصحة لدي



المرتبات قصيرة المدى

الشعور بالراحة أو السيطرة على الأعراض.

المرتبات طويلة المدى

على سبيل المثال، تبقى الأفكار والقواعد والافتراضات دون تعديل، ومن ثم يستمر القلق.

زيادة الرغبة في التركيز على الأعراض والفحص وطلب التطمين والتجنب أو استخدام سلوكيات الأمان.

مزيد من الأخبار السارة...

في البداية، قد يبدو الأمر محبطاً أن ترى أن جهودك لمحاولة التحكم في قلقك وأعراضك أو تقليلهما يمكن أن تؤدي في الواقع إلى زيادتهما. ومع ذلك، فإن القدرة على فهم عوامل استمرار قلق الصحة لديك يوماً بعد يوم؛ تتيح لك معرفة

نقطة البدء لإجراء بعض التغييرات لكسر هذه الحلقة المفرغة.

ستغطي بقية المراحل مجموعة من الاستراتيجيات المعرفية والسلوكية التي تهدف إلى التفكيك التدريجي للأفكار والسلوكيات والقواعد والافتراضات غير المفيدة التي يمكن أن تعمل على استمرار هذه الدائرة.

بالنظر إلى النموذج قد تتساءل لماذا لا نبدأ في تحدي القواعد والافتراضات غير المفيدة أولاً. السبب وراء تركنا هذه الأمور لوقت لاحق هو أنه يمكن أن يكون تغييرها أصعب إلى حد ما من أفكارك وسلوكياتك غير المفيدة (كذلك قد

تكون هذه القواعد والافتراضات موجودة منذ بعض الوقت). لذلك سنعود إلى هذه العناصر في نهاية المراحل بمجرد أن تبدأ الحلقة المفرغة القديمة في "التأكل". نحن نشجعك على الالتزام بالعمل من خلال المراحل بالترتيب، واستكمال جميع التدريبات وأوراق العمل، حيث سيحقق لك ذلك أكبر فائدة.

ملخص المرحلة الثالثة

- يمكن إثارة قلق الصحة من خلال مجموعة من المحفزات الداخلية أو الخارجية.
- من الطبيعي تمامًا أن تخبر هذه المحفزات الداخلية والخارجية، ولكنها إذا اقترنت بقواعد أو افتراضات غير مفيدة متعلقة بالصحة، يمكن أن تؤدي إلى:
 - تفكير سلبي متعلق بالصحة.
 - زيادة في أعراض القلق.
 - تركيز الانتباه على الأعراض المخيفة.
 - سلوكيات التحقق وطلب التطمين.
 - التجنب وسلوكيات الأمان.
- على المدى القصير، قد توفر هذه السلوكيات إحساسًا بالراحة أو السيطرة على الأعراض.
- على المدى الطويل، قد تؤدي هذه السلوكيات إلى:
 - زيادة التركيز على الأعراض.
 - مزيد من الهم والقلق بشأن الأعراض.
 - مزيد من أعراض القلق.
 - حساسية أو ألم في المنطقة التي يتم فحصها.
 - رغبة متزايدة في التحقق والبحث عن آراء ثانية.
 - زيادة استخدام التجنب وسلوكيات الأمان.

• الخطوة الأولى نحو كسر هذه الحلقة المفرغة هي فهم عوامل استمرار قلق الصحة.

التالي...

ستتعلم في المرحلة التالية كيف تبدأ في تقليل تركيزك على أعراضك ومخاوفك الصحية.

Helping Health Anxiety

About The Modules

CONTRIBUTORS

Dr Rebecca Anderson (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

Paula Nathan (MPsych¹)
Centre for Clinical Interventions

Dr Lisa Saulsman (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

¹Masters of Psychology (Clinical Psychology)

²Doctor of Philosophy (Clinical Psychology)

BACKGROUND

The concepts and strategies in these modules have been developed from evidence based psychological practice, primarily Cognitive-Behaviour Therapy (CBT). CBT for health anxiety is based on the approach that health anxiety is a result of problematic cognitions (thoughts) and behaviours.

REFERENCES

These are some of the professional references used to create the modules in this information package.

- Abramowitz, J., Taylor, S., & McKay, D. (2010). Hypochondriasis and severe health anxiety. In McKay, D., Abramowitz, J., S., & Taylor, S. (Eds.). *Cognitive-behavior therapy: Turning failure into success* (pp. 327-346). Washington, DC: American Psychological Association.
- Asmundson, G., & Taylor, S. (2005). *It's not all in your head: How worrying about your health could be making you sick – and what you can do about it*. New York: The Guilford Press.
- Furer, P., & Walker, J. (2006). *Health anxiety treatment manual*. University of Manitoba: Manitoba.
- Furer, P., Walker, J., & Stein, M. (2007). *Treating health anxiety and fear of death*. New York: Springer.
- Papageorgiou, C., & Wells, A. (1998). Effects of attention training on hypochondriasis: A brief case series. *Psychological Medicine*, 28, 193-200.
- Salkovskis, P., Warwick, H., & Deale, A. (2003). Cognitive-behavioural treatment for severe and persistent health anxiety (Hypochondriasis). *Brief Treatment and Crisis Intervention*, 3, 353-367.
- Willson, R., & Veale, D. (2009). *Overcoming health anxiety: A self-help guide using cognitive behavioural techniques*. London: Robinson.

“HELPING HEALTH ANXIETY”

This module forms part of:

Anderson, R., Saulsman, L., & Nathan, P. (2011). *Helping Health Anxiety*. Perth, Western Australia: Centre for Clinical Interventions.

ISBN: 0 9757995 6 8

Created: August 2011

المرحلة الرابعة

تقليل التركيز على الأعراض والمخاوف المتعلقة بالصحة

١- مقدمة

٢- التركيز على الأعراض والمخاوف المتعلقة بالصحة

٣- التغلب على عوائق تدريب الانتباه

٤- تدريب الانتباه

• التركيز على المهام اليومية المعتادة

• تدريب التأمل

٥- تأجيل مخاوفك المتعلقة بالصحة

٦- متى تطلب العناية الطبية؟

٧- ملخص المرحلة الرابعة

٨- حول المراحل

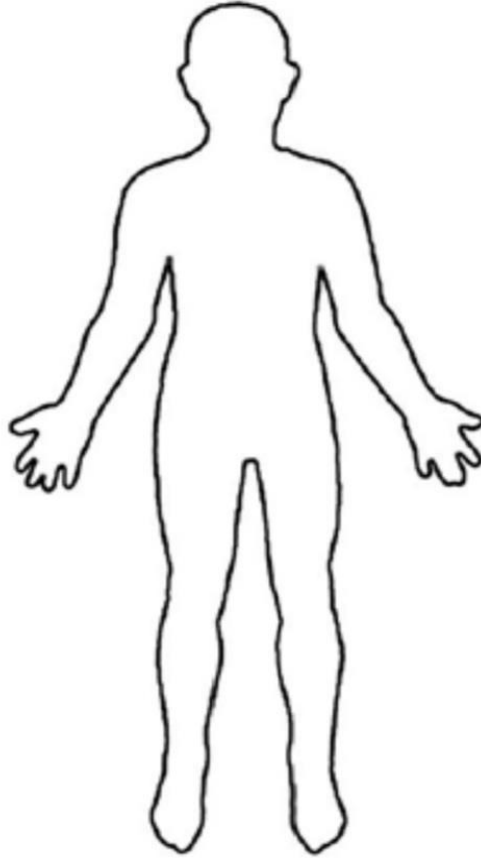
مقدمة

في المرحلتين الثانية والثالثة، ناقشنا كيف يكون للتركيز على الأعراض عواقب سلبية تتمثل في زيادة شدة الأعراض، هذا بدوره قد يخلق مزيداً من الانشغال بالأعراض، مما يؤدي إلى مزيد من الإحساس بالقلق، فتزداد رغبتنا في التركيز على أعراضنا أكثر! سنتقدم لنا هذه المرحلة الطرق التي يمكنك من خلالها البدء في تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في التركيز على الأعراض والمخاوف الصحية، ومن ثم البدء في كسر هذه الحلقة المفرغة.

التركيز على الأعراض والمخاوف المتعلقة بالصحة

غالباً ما يجد الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة أنفسهم يفحصون أجسادهم بحثاً عن علامات اعتلال في صحتهم، ثم يقلقون بشأن هذه الأحاسيس الجسدية. من الطبيعي -إلى حد ما- أن تكون على دراية بالأحاسيس والتغيرات الجسدية لديك، وأن تُولي بعض الاهتمام للمشكلات الصحية المحتملة. ومع ذلك، إذا كنت تقضي كثيراً من الوقت في التركيز على أعراضك، أو وجدت صعوبة في التوقف عن التفكير في هذه الأعراض، فقد تحتاج إلى البدء في إعادة توجيه انتباهك.

قبل أن نبدأ في العمل على هذا، دعنا نتوقف للتفكير فيما تميل إلى التركيز عليه عندما تشعر بالقلق بشأن صحتك. توقف لحظة لسرد تلك الأحاسيس أو المناطق الخاصة بجسمك التي تميل إلى التركيز عليها بشكل متزايد عندما تكون قلقًا بشأن صحتك. قد ترغب أيضًا في إبرازها أو وضع دائرة حولها في الرسم التخطيطي التالي لصورة الجسم. إذا لم تكن منزعجًا من أحاسيس بعينها أو مناطق معينة من جسمك، ولكنك تقضي معظم وقتك في الانشغال بشأن المرض أو الوفاة بشكل عام، فلا يزال بإمكانك سرد المخاوف المتعلقة بالصحة التي تشغل بالك في المساحة أدناه.



لسوء الحظ - كما ذكرنا سابقًا - قد يؤدي التركيز على أعراضنا إلى تضخيم حدة هذه الأعراض، وبالتالي زيادة أعراض الهم والقلق. كذلك عندما نركز على أعراضنا؛ فإن هذا يستحوذ على انتباهنا بعيدًا عن الأنشطة اليومية وحتى عن المهام الضرورية. على سبيل المثال، هل سبق أن وجدت صعوبة في التركيز على عمل منزلي ما، أو مشروع في عملك، أو حتى مجرد قراءة هذه الخطوات لأن انتباهك ذهب إلى منطقة معينة من جسمك، أو عاد للانشغال بمخاوفك الصحية، أو بإحساس جسدي معين؟

لذلك فإن تعلم إعادة توجيه انتباهك هو خطوة مهمة في التغلب على قلق الصحة لديك. تلك الخطوة لن تقلل من مقدار تركيزك على أحاسيسك فحسب، بل ستحرر انتباهك حتى تتمكن من التركيز على أنشطة وتجارب أخرى.

التغلب على عوائق تدريب الانتباه

قبل أن تبدأ العمل في تدريب "إعادة توجيه الانتباه"، قد يكون من المهم فحص ما إذا كان لديك أي معتقدات إيجابية حول الاستمرار في التركيز على أعراضك أو مخاوفك الصحية.

من أمثلة هذه المعتقدات الإيجابية:

- "التركيز على الأعراض التي أعانيها يساعدني حقًا في تقييم مدى خطورتها".
- "التركيز على جسدي يعني أنني سأواجه أي مشكلات قبل فوات الأوان".
- "عدم التركيز على الأعراض هو مجازفة بقدرتي".
- "الانشغال بصحتي يجعلني مستعدًا لأي شيء".
- "انشغالي بصحتي يساعدني في حل مشاكلي الصحية".
- "إذا واصلت التفكير، فسأمنع المرض".

من المنطقي أنك إذا كنت تحمل مثل هذه المعتقدات الإيجابية حول تركيز انتباهك على أعراضك ومخاوفك الصحية؛ فإنك ستستمر في القيام بذلك. وبعد كل هذا، ستقول لنفسك: إن ما أفعله مفيد ويحميني!

إذا كانت لديك أي معتقدات إيجابية حول التركيز على أعراضك ومخاوفك، حتى وإن كانت بدرجة بسيطة؛ فإننا نوصيك أولاً بتحليل هذه المعتقدات وتحديثها. بمجرد أن تجيب على سؤال: هل تركيزك على الأعراض أو المخاوف الصحية مفيد حقًا؟ ستكون وقتها في وضع أفضل لتقرير رغبتك في تغيير هذا السلوك.

فيما يلي مجموعة من الأسئلة التي يمكنك طرحها على نفسك لتقييم معتقداتك الإيجابية حول التركيز على الأعراض والمخاوف المتعلقة بالصحة.

المعتقد الإيجابي المراد تقييمه: _____ إلى أي مدى تقتنع بهذا الآن (٠٪ = لا على الإطلاق ، ١٠٠٪ = مقتنع تمامًا): _____
ما هو الهدف من تركيز انتباهك بهذه الطريقة؟ هل تركيز انتباهك بهذه الطريقة يحقق هدفك حقاً؟ وضح بدقة كيف يساعدك ويحميك؟ إذا تم تشخيصك بمشكلة صحية غذاء؛ كيف ساعدك التركيز على الأعراض والمخاوف بالفعل في تجهيزك لهذه المشكلة الصحية؟ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

هل هناك عواقب سلبية لتركيز انتباهك بهذه الطريقة؟

هل يُزيد من شدة أحاسيسك الجسدية؟

هل يُثير مزيداً من أعراض الهجوم/ الهروب بسبب القلق الشديد؟

هل من الممكن أن يؤدي تركيزك على أحد الأعراض أو القلق بشأنه؛ إلى
افتقاد عرض آخر؟

كيف يمكنك تحديد الأعراض أو الهموم التي ستركز عليها؟

إذا كان هناك طفل ما يركز على أعراضه ومخاوفه بقدر ما تركز، فهل تشجعه
على فعل ذلك أكثر؟ إن كنت لن تشجعه، فلماذا؟

ما هي الاستنتاجات التي يمكنك التوصل إليها مما سبق؟

أعد تقييم قوة اقتناعك بالمعتقد الإيجابي (٠% = لا على الإطلاق ، ١٠٠% =
مقتنع تماماً): _____%

تدريب الانتباه

كيف يمكننا إذن التخلي عن التركيز على أعراضنا والقلق بشأنها، وإعادة انتباهنا إلى هنا والآن؟ حسنًا، ففكر في انتباهك كأنه عضلة، إن لم تقم بتمرينها بانتظام؛ فستصبح عضلة ضعيفة ولن تعمل بشكل جيد. نحتاج إلى تقويتها من خلال إعطائها تمارين منتظمة !!

هناك طريقتان يمكنك من خلالهما منح انتباهك تمرينًا منتظمًا، تتضمن إحداهما التدريب على مواصلة الانتباه أثناء الانخراط في المهام اليومية المعتادة، وتتضمن الأخرى ممارسة التأمل بطريقة مقصودة.

من المهم أن نتذكر أثناء الانخراط في هذه التمرينات أنه من الطبيعي تمامًا لعقولنا أن تشرذم إلى أشياء أخرى. هذا ما تفعله العقول. إنها تتجرف إلى الذكريات والمخاوف والأحاسيس والصور الذهنية والتخطيط وأحلام اليقظة، وهذا على سبيل المثال لا الحصر. عندما تلاحظ أن عقلك قد بدأ يشرذم خلال هذه الأنشطة، احرص على عدم انتقاد نفسك على هذا، فهو أمر طبيعي تمامًا. بدلاً من ذلك، ففكر في كل "شرود" على أنه فرصة لتدريب مهاراتك في جذب انتباهك مرة أخرى إلى هنا والآن. ففكر في الأمر بهذه الطريقة، فالمهارة التي تتعلمها ليست أن يكون لديك انتباه متواصل تمامًا، ولكنها مهارة جذب انتباهك عندما يشرذم وإعادته مرة أخرى. وبذلك لا يهم حقًا عدد المرات التي يشرذم فيها انتباهك؛ لأن هذا جزء من التدريب.

التركيز في المهام اليومية المعتادة

ربما لاحظت أنك عندما تقوم بالمهام اليومية المعتادة مثل غسل الأطباق أو الكي، فإن عقلك في الواقع لا يركز على المهمة التي تقوم بها. غالبًا ما تكون هذه هي الأوقات التي تبدأ فيها أذهاننا في الشرود. لذلك، تعد هذه الأنواع من المهام فرصًا رائعة للتدريب على تقوية عضلات انتباهنا. عند التركيز على المهام المعتادة يكون الهدف هو التدريب تدريجيًا على مواصلة انتباهك في نشاط محدد لفترات زمنية أطول فأطول - وبالتالي إعطاء انتباهك تمرينًا جيدًا.

خذ لحظة للتفكير في بعض الأنشطة اليومية المعتادة التي تنخرط فيها، وتجد عقلك يشرد كثيرًا عند القيام بها (على سبيل المثال: غسل الأطباق، والكي، والعناية بالنباتات، والاستحمام، والتنظيف بالمكنسة الكهربائية، وتناول الطعام). اكتبها أدناه حتى تتمكن من الرجوع إليها عند التخطيط لتمرين الانتباه.

اختر اثنتين من تلك المهام للقيام بتمرين الانتباه الأول.

قم بتسجيل المهمة ومتى وأين ستفعلها في ورقة عمل تمرين الانتباه. الآن، ابدأ المهمة دون محاولة تركيز انتباهك عن قصد. في البداية "قبل التمرين" قم بقياس مستوى انتباهك، من خلال تقدير النسبة المئوية لانتباهك الذي يركز على نفسك حاليًا (متضمنًا تركيزك على أفكارك الخاصة، والأعراض، والأحاسيس

المزعجة) مقابل النسبة المئوية لانتباهك الذي يركز على المهمة الحالية التي اخترتها.

بعد أن تُقيّم النسبة المئوية لانتباهك المركز على نفسك مقابل النسبة المئوية لانتباهك المركز على المهمة؛ ابدأ في ممارسة المهمة التي تم اختيارها، وفي كل مرة تلاحظ أن عقلك قد ضلّ طريقه بعيداً عن المهمة، أعد انتباهك مرة أخرى إلى المهمة من خلال التركيز على ما يلي:

- اللمس: كيف تحس بهذه المهمة؟ ما هو ملمسها (على سبيل المثال: خشن، أملس)؟ ما هو المكان في جسمك الذي يتلامس مع هذه المهمة؟ هل هناك مناطق في جسمك أكثر أو أقل احتكاكاً بالمهمة؟
- البصر: ماذا تلاحظ في المهمة؟ ما الذي يلفت انتباهك؟ كيف تبدو لك؟ وماذا عن الضوء ... الظلال .. الحدود .. الألوان؟
- السمع: ما الأصوات التي تلاحظها؟ ما أنواع الضوضاء المرتبطة بالمهمة؟
- الرائحة: ما هي الروائح التي تلاحظها؟ هل تتغير الروائح أثناء القيام بالمهمة؟ كم عدد الروائح الموجودة؟
- التدفق: ما النكهات التي تلاحظها؟ هل تتغير النكهات أثناء القيام بالمهمة؟ ما هي جودة هذه النكهات؟

لست مضطراً إلى تدوين الإجابات على هذه الأسئلة. ما عليك سوى استخدامها لمساعدتك في إعادة توجيه انتباهك إلى المهمة التي تقوم بها. وبمجرد الانتهاء من التمرين الخاص بالتركيز على المهام اليومية المعتادة، قد ترغب في إعادة تقييم مستوى انتباهك الذي يركز على الذات مقابل التركيز على المهمة، والتفكير فيما تعلمته من إكمال النشاط.

ورقة عمل تمرين الانتباه

(التركيز على المهام اليومية المعتادة)

المهمة المعتادة التي أختيرت لتمرين الانتباه : _____ أين ومتى سأقوم بالتمرين: _____
ألاحظ قبل البدء في تمرين الانتباه، أين يتركز انتباهي؟ • التركيز الذاتي (متضمنًا: الأفكار، والأعراض والأحاسيس المزعجة): _____ % • التركيز على المهمة (المهمة التي انخرطت فيها بالفعل): _____ % _____ % ١٠٠
أثناء تمرين الانتباه، أعد انتباهك مرة أخرى إلى المهمة التي بين يديك من خلال التركيز على: • اللمس: كيف تحس بهذه المهمة؟ ما هو ملمسها (على سبيل المثال: خشن، أملس)؟ ما هو المكان في جسمك الذي يتلامس مع هذه المهمة؟ هل هناك مناطق بجسمك أكثر أو أقل احتكاكًا بالمهمة؟ • البصر: ماذا تلاحظ في المهمة؟ ما الذي يلفت انتباهك؟ كيف تبدو لك؟ وماذا عن الضوء ... الظلال .. الحدود .. الألوان؟ • السمع: ما الأصوات التي تلاحظها؟ ما أنواع الضوضاء المرتبطة بالمهمة؟ • الرائحة: ما هي الروائح التي تلاحظها؟ هل تتغير الروائح أثناء القيام بالمهمة؟ كم عدد الروائح الموجودة؟

• التدوق: ما النكهات التي تلاحظها؟ هل تتغير النكهات أثناء القيام بالمهمة؟
ما هي جودة هذه النكهات؟

تذكر أنه من الطبيعي أن يشرّد عقلي. بدلاً من أن أضغط على نفسي بسبب هذا، استخدم كل مرة يشرّد فيها ذهني كفرصة لتدريب عضلات انتباهي مرة أخرى.

لاحظت بعد الانتهاء من تمرين الانتباه، أين كان يتركز انتباهي؟

• التركيز الذاتي (متضمنًا: الأفكار، والأعراض والأحاسيس المزعجة): _____ %

• التركيز على المهمة (المهمة التي انخرطت فيها بالفعل): _____ %

100 %

ماذا تعلمت من هذا التمرين؟ ما هي الاستنتاجات التي يمكنك التوصل إليها من هذا التمرين؟

تمرين التأمل

يعد استخدام تمرين التأمل طريقة أخرى يمكنك من خلالها تحقيق ممارسة منتظمة تساعدك على التواجد في اللحظة الحاضرة، والتعامل مع شروود الذهن، والابتعاد عن الأفكار والأحاسيس المؤلمة.

اليقظة هي أحد أنواع التأمل التي يمكن أن تساعدك على التحرر من الأفكار والأحاسيس المزعجة. يتضمن هذا النهج التدرب على كيفية ملاحظة شروء انتباهك، ثم إعادة توجيهه بمهارة إلى الحاضر، إلى هنا والآن.

إنها ليست محاولة للتحكم في أفكارك أو أحاسيسك أو جعلها تختفي. وإنما يعني تقبل أن تكون هذه الأفكار والأحاسيس حاضرة في عقلك وجسمك، ولكنك تختار تحويل انتباهك مرة أخرى إلى تنفسك.

يمكن الجمع بين اليقظة ونشاط "دعه يمر leting go"، حيث تختار أن تلاحظ الأفكار أو المشاعر أو الأحاسيس الجسدية المزعجة، ثم تتركها تمر.

من المهم أن تتذكر أن هذا ليس حلاً سريعاً، وليس سهلاً، إنه يتطلب ممارسة منتظمة. ومن خلال الممارسة اليومية ستصبح في نهاية المطاف أفضل في ترك أفكارك وأحاسيسك المكثرة بشكل طبيعي عندما تظهر على مدار اليوم.

خطوات التأمل

(١) لبدء ممارسة التأمل، اجلس على كرسي واتخذ وضعية استرخاء وبقطة، ثم اسأل نفسك، ما الذي أخبره الآن؟ ما هي الأفكار التي لدي الآن، وما هي المشاعر الحالية، وما هي الأحاسيس الجسدية؟ اسمح لنفسك فقط بالإقرار بوجود هذه الخبرات، وملاحظتها، ووصفها لنفسك، دون إصدار حكم، ودون محاولة تغييرها أو جعلها تختفي. اقض من ٣٠ ثانية إلى دقيقة واحدة تفعل هذا فقط.

(٢) الآن ركز وعيك على تنفسك، كن واعياً بأنفاسك وبحركات بطنك صعوداً وهبوطاً وهي تتحرك مع تنفسك من لحظة إلى أخرى، واترك كل الأفكار تذهب. يمكن أن تقول لنفسك مع كل نفسٍ تُخرجه "استرخ" أو "دعها تمر". إذا شرد عقلك بعيداً إلى أفكار ومشاعر وأحاسيس أخرى، فلا تحاول تغييرها أو التخلص منها. ما عليك سوى الاعتراف بوجود هذه الأفكار والمشاعر، والسماح لهم بالتواجد هناك، ثم دع كل ذلك يمر، وأعد تركيزك مرة أخرى على أنفاسك. افعل هذا لمدة دقيقة أو دقيقتين.

(٣) الآن قم بتوسيع وعيك لاستشعار أن جسدك بالكامل يتنفس، كن على وعي بالأحاسيس الموجودة في جميع أنحاء جسمك. إذا كانت لديك أي مشاعر قوية، فيمكن أن تقول لنفسك "مهما كان الأمر، فلا بأس، فقط دعني أشعر بذلك." اسمح لنفسك بالتنفس مع هذه المشاعر، وإذا شرد ذهنك في الأفكار أو الأحاسيس المزعجة، فما عليك سوى الاعتراف بذلك

وتركه يمر، وأعد تركيزك مرة أخرى على استشعار أن جسدك بالكامل يتنفس. استمر في القيام بذلك لمدة دقيقة أو دقيقتين أخريين.

عندما تصبح أكثر ألفة بهذه المهارة، يمكنك محاولة زيادة وقت الخطوتين الثانية والثالثة. نوصيك بالاستمرار في زيادة هذا الوقت حتى تتمكن من التدريب مرتين يوميًا لمدة عشر دقائق أو أكثر، ثم واطب على التدريب يوميًا بهذا المستوى. تذكر أن انتباهك مثل العضلات، إذا أوقفت التمرين المنتظم فلن تعمل عضلاتك بشكل جيد. يمكنك استخدام "يوميّات تدريب الانتباه" لمتابعة تقدمك.

يوميّات تدريب الانتباه

يمكنك استخدام هذه الورقة للتخطيط لكل من تدريب الانتباه، وتسجيل تقدمك على طول الطريق. يطلب منك العمود الأخير تدوين أي تعليقات حول التجربة- ماذا لاحظت؟ أين شرد عقلك؟ هل كنت قادراً على ملاحظة ذلك؟ هل تمكنت من مقاطعة هذا؟ كيف تقارن ممارستك للتمرين هذه المرة بالأوقات الأخرى التي مارسته فيها؟

التعليقات	المدة	مهمة الانتباه	التاريخ والوقت
كان هذا صعباً للغاية حيث ظل عقلي راغباً في القفز إلى التفكير في العمل.	٣ دقائق	التأمل	على سبيل المثال: الاثنين يوم ٢٨ في الشهر - الساعة ٨ صباحاً
لقد لاحظت كثيراً من الأشياء التي لم ألاحظها عادة، لكنني كنت لا أزال أفكر كثيراً في صحتي. ربما كان الأمر أسهل قليلاً من التأمل حيث كان لدي شيء لأركز عليه.	١٠ دقائق	التركيز على مهمة منزلية معتادة (غسيل الأطباق)	الاثنين يوم ٢٨ في الشهر - الساعة ٥.٣٠ مساءً

نوصيك بممارسة تمارين التركيز على المهام اليومية المعتادة مرة يومياً، وممارسة التأمل مرتين يومياً. إذا وجدت صعوبة في ممارسة تمارين التأمل المنتظمة، يمكنك بدلاً من ذلك زيادة عدد التدريبات التي تركز على المهام المعتادة التي تقوم بها يومياً. تذكر أن التركيز على المهام اليومية المعتادة لا يتطلب منك القيام بأي شيء إضافي، ولكنك فقط تؤدي تلك الأنشطة -التي تقوم بها بالفعل- بطريقة معينة.

تأجيل مخاوفك المتعلقة بالصحة

على الرغم من أنك بدأت في تدريب عضلات انتباهك لمساعدتك في التغلب على تركيزك المفرط على الأعراض الجسدية؛ فقد تلاحظ أن انتباهك يستمر في العودة مرة أخرى إلى المخاوف بشأن أعراض أو أحاسيس معينة، أو مخاوف عامة بشأن صحتك. وعلى الرغم أنه من الطبيعي تمامًا أن تظهر المخاوف المتعلقة بالصحة في أذهاننا، ولكن زيادة تركيزنا على هذه المخاوف يُزيد أعراض القلق التي نثيرها في أجسامنا، وهذا بدوره يعطينا مزيداً من المخاوف بشأن صحتنا!

لذلك سيحاول عديد من الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة إيقاف انشغالاتهم وهمومهم الصحية من خلال محاولة تشتيت انتباههم أو إخبار أنفسهم ألا يفكروا في صحتهم. لسوء الحظ، فإن محاولة عدم التفكير في شيء ما قد يكون له تأثير معاكس من خلال جعلنا نفكر فيه أكثر!

على سبيل المثال، حاول ألا تفكر في فيل وردي لمدة الـ ٦٠ ثانية القادمة

ولاحظ مدى نجاحك.

ومن ثم، إذا كان التركيز على مخاوفنا يخلق مزيداً من المخاوف والأعراض، ومحاولة عدم التركيز على مخاوفنا تزيد في الواقع مقدار المخاوف، فماذا يجب

أن نفعل؟!؟ لحسن الحظ، هناك خيار ثالث يمكننا استخدامه يسمى **تأجيل الهم**

.Worry Postponement

إن تأجيل همومك المتعلقة بالصحة يعني: **وليكن** أنه خَطَرٌ ببالك فكرة مقلقة أولية (على سبيل المثال، "ماذا لو كان ألم صدري هذا نوبة قلبية")، **وليكن** حتى أنك بدأت في التركيز على تلك الأعراض التي تقلق بشأنها، ومع ذلك، فالمطلوب منك بمجرد أن تلاحظ ذلك أن تتخذ قراراً بعدم "تَعَقُّب" همومك أو أعراضك في ذلك الوقت بالذات.

عدم تَعَقُّب الفكرة المقلقة أكثر من ذلك يعني: ألا تحاول تقييم الأعراض أو الأحاسيس أكثر من ذلك، وألا تحاول الاسترسال ذهنياً مراراً وتكراراً في توقع الأسوأ أو افتراض السيناريوهات والحلول المتعلقة بالأعراض (على سبيل المثال: "قد يكون هذا سرطاناً، أعتقد أن الألم يزداد سوءاً؟ ماذا سيحدث لي ولعائتي إذا كان كذلك؟ يجب أن أرى طبيبي" إلخ). بدلاً من ذلك، تقوم بتأجيل التفكير في صحتك إلى وقت لاحق، باستخدام مهارات الانتباه الخاصة بك لجذب انتباهك مرة أخرى إلى هنا والآن، والعودة إلى المهمة التي تقوم بها.

كيفية التأجيل

١. حدد فترة القلق

- حدد وقتًا ومكانًا ومدة زمنية معينة للتفكير في همومك الصحية والتركيز على أعراضك.
- حاول الحفاظ على الفترة الزمنية المخصصة للقلق كما هي كل يوم (على سبيل المثال: الساعة السادسة مساءً، في غرفة الطعام، لمدة ٢٠ دقيقة).
- نوصي بما لا يزيد عن ٣٠ دقيقة في اليوم.
- حاول ألا تكون فترة القلق قبل النوم.

٢. التأجيل

- عندما تلاحظ أنك منشغل بشأن أعراض معينة أو اتجه تركيزك إلى أعراض ما على مدار اليوم، فقم بإدراج مخاوفك في ورقة عمل تأجيل المخاوف الصحية، أو حتى في دفتر ملاحظات أو على أي قطعة من الورق إذا لم تكن ورقة العمل متاحة لك.
- دوّن المخاوف باختصار (في عبارة قصيرة، على سبيل المثال: "لاحظت ألمًا في جانبي، وأعتقد أنه التهاب في الزائدة الدودية").
- قرر أنك ستفكر في الأمر لاحقًا، وارجئه للفترة المخصصة للقلق.
- استخدم مهارات الانتباه الخاصة بك لجذب انتباهك مرة أخرى إلى الحاضر، وطمئن نفسك أنك ستفكر في هذه الهموم والأحاسيس خلال الفترة المخصصة للقلق.

٣. عندما تصل إلى الفترة المخصصة للقلق

- لا تفكر في الأشياء التي أدرجتها في ورقة العمل إلا إذا شعرت بضرورة ذلك.

- لست مضطراً للانشغال بالتفكير بشأن أعراض وأحاسيس لم تعد تزعجك، أو لا صلة لها بك الآن.

- إذا وجدت أنك بحاجة إلى التفكير فيما يقلقك، فقم بالتفكير خلال الوقت المحدد فقط.

- إذا نفذ الوقت المخصص للقلق قبل تغطية كل الأشياء المدرجة في قائمتك، ذكّر نفسك أنه سيتم تغطية هذه العناصر في اليوم التالي خلال فترة القلق التالية.

نوصيك بممارسة هذه الاستراتيجية خلال الأسبوع المقبل من خلال استكمال ورقة عمل تأجيل مخاوف الصحة. ونقترح عليك بعد ذلك الاستمرار في استخدام استراتيجية التأجيل طالما أنك لا تزال قلقاً بشأن صحتك.

ورقة عمل تأجيل مخاوف الصحة

حدد فترة القلق

وقت البدء:	وقت الانتهاء:	المكان:
------------	---------------	---------

سجل بإيجاز مخاوف الصحة لديك

ثم استخدم استراتيجيات الانتباه الخاصة بك لإعادة انتباهك إلى الحاضر. نذكر نفسك أنك ستعود إلى هذه المخاوف والأحاسيس خلال الفترة المخصصة للقلق لديك.

اليوم	المخاوف (بكلمات قليلة فقط)
الاثنين	
الثلاثاء	
الأربعاء	
الخميس	
الجمعة	
السبت	
الأحد	

بعد ممارسة هذه الاستراتيجية لمدة أسبوع، توقف لحظة لمراجعة كيف سار الأمر مع استراتيجية التأجيل.

- ماذا حدث للهموم المتعلقة بالصحة التي أجلتها؟ هل ما زلت بحاجة للتفكير بشأنها لاحقًا؟

- إذا تمكنت من التأجيل، فماذا حدث للأعراض التي كنت مهموما بشأنها؟

- إذا واجهتك مشكلة في التأجيل - فهل قمت بالفعل بكتابة مخاوفك (هذا ما

نوصي به) أم حاولت فقط تذكرهم في ذهنك (هذا ما لا نوصي به)؟

- هل تحتاج إلى مزيد من العمل على ممارسة تدريب الانتباه الخاص بك؟

متى تستشير الطبيب؟

خلال هذه المرحلة، ناقشنا طرق تقليل تركيزنا على الأعراض والأحاسيس الجسدية والقلق بشأنها. ومع ذلك، فإننا لا نريدك أن تتجاهل الأعراض التي قد تشير إلى احتياج حقيقي للرعاية الطبية. **فكيف نعرف متى نؤجل مخاوفنا ومتى نتصرف حيالها؟**

على الرغم أنه لا توجد إجابات بسيطة على هذا السؤال، فقد أوصت باتريشيا فورر وزملاؤها الخبراء في قلق الصحة بجامعة مانيتوبا بالإرشادات التالية:

- استخدم علاجات الرعاية الذاتية المألوفة لك بالفعل للتعامل مع أعراض البرد والإنفلونزا أو الصداع أو آلام الظهر (مثل: أخذ قسط من الراحة، والأدوية المألوفة لك، والكمادات الساخنة/ الباردة).
- بالنسبة لكثير من الأعراض، مثل الألم أو نزلات البرد، **جرب نهج "الانتظار لمدة أسبوعين"**. فإن كثيرا من الأعراض ستختفي دون مساعدة طبية خلال هذه الفترة الزمنية. يمكنك التفكير في هذا على أنه **تمرين تأجيل مطول**، فبدلاً من الانتظار حتى الوقت المخصص للقلق في تلك الليلة، ستقوم بتأجيل التفكير في الأمر لمدة أسبوعين آخرين. ومن الواضح أن هذا سيتطلب تدريباً أكثر على استخدام استراتيجيات الانتباه لديك!
- إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوعين، فاستشر طبيبك.
- استشر الطبيب بشكل عاجل إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وألم شديد، وعلامات تدل على تفاقم الحالة.

يجب أن نوضح أيضًا أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من تشخيصات معينة أو الذين يتناولون أدوية محددة، قد تكون هناك مؤشرات محددة أخرى تحتاج تدخلات طبية فورية. فإذا كنت ممن تم تشخيصه بالفعل أو كنت تتناول دواء معينًا، نوصيك بالتحدث مع طبيبك لوضع إرشادات خاصة بك حول متى تقوم بتأجيل مخاوفك ومتى يكون عليك التصرف فورًا حيالها.

ملخص المرحلة الرابعة

- غالبًا ما يجد الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة أنفسهم يتفحصون أجسادهم بحثًا عن علامات اعتلال الصحة ثم يشعرون بالهم بشأن الأحاسيس الجسدية.
- يمكن أن يؤدي التركيز على الأعراض إلى تضخيم حدة هذه الأعراض، وبالتالي زيادة أعراض الهم والقلق.
- تعلم إعادة توجيه الانتباه يساعدك على تقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في التركيز على الأعراض التي تعاني منها والمخاوف بشأنها، وبالتالي يُعد خطوة مهمة في التغلب على قلق الصحة لديك.
- هناك طريقتان يمكن من خلالهما إعادة توجيه انتباهك. تتضمن الطريقة الأولى التركيز على المهام اليومية المعتادة من خلال التدريب على مواصلة الانتباه أثناء القيام بالمهام المنزلية اليومية. وتتضمن الطريقة الثانية التأمل، وهو ممارسة يومية أكثر رسمية تتمثل في إعادة تركيز انتباهك على تنفسك في كل مرة ينجرف فيها عقلك إلى أفكار أو أحاسيس مختلفة.
- بمجرد أن تبدأ في تقوية عضلات انتباهك، يمكنك الجمع بين تمرين الانتباه وبين تمرين التأجيل لتقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في الهم والتركيز على صحتك.

• رغم أننا قدمنا بعض الإرشادات، ولكن من المهم أيضاً أن تعمل مع طبيبك لوضع مجموعة الإرشادات الخاصة بك فيما يتعلق بمتى يجب عليك تأجيل مخاوفك بشأن أعراضك، ومتى يجب عليك طلب المساعدة الطبية.

التالي ...

في المرحلة التالية، سوف نستكشف طرقاً للتعامل مع أفكارك غير المفيدة المتعلقة بالصحة أثناء فترة القلق لديك.

Helping Health Anxiety

About The Modules

CONTRIBUTORS

Dr Rebecca Anderson (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

Paula Nathan (MPsych¹)
Centre for Clinical Interventions

Dr Lisa Saulsman (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

¹Masters of Psychology (Clinical Psychology)

²Doctor of Philosophy (Clinical Psychology)

BACKGROUND

The concepts and strategies in these modules have been developed from evidence based psychological practice, primarily Cognitive-Behaviour Therapy (CBT). CBT for health anxiety is based on the approach that health anxiety is a result of problematic cognitions (thoughts) and behaviours.

REFERENCES

These are some of the professional references used to create the modules in this information package.

- Abramowitz, J., Taylor, S., & McKay, D. (2010). Hypochondriasis and severe health anxiety. In McKay, D., Abramowitz, J., S., & Taylor, S. (Eds.). *Cognitive-behavior therapy: Turning failure into success* (pp. 327-346). Washington, DC: American Psychological Association.
- Asmundson, G., & Taylor, S. (2005). *It's not all in your head: How worrying about your health could be making you sick – and what you can do about it*. New York: The Guilford Press.
- Furer, P., & Walker, J. (2006). *Health anxiety treatment manual*. University of Manitoba: Manitoba.
- Furer, P., Walker, J., & Stein, M. (2007). *Treating health anxiety and fear of death*. New York: Springer.
- Papageorgiou, C., & Wells, A. (1998). Effects of attention training on hypochondriasis: A brief case series. *Psychological Medicine*, 28, 193-200.
- Salkovskis, P., Warwick, H., & Deale, A. (2003). Cognitive-behavioural treatment for severe and persistent health anxiety (Hypochondriasis). *Brief Treatment and Crisis Intervention*, 3, 353-367.
- Willson, R., & Veale, D. (2009). *Overcoming health anxiety: A self-help guide using cognitive behavioural techniques*. London: Robinson.

“HELPING HEALTH ANXIETY”

This module forms part of:

Anderson, R., Saulsman, L., & Nathan, P. (2011). *Helping Health Anxiety*. Perth, Western Australia: Centre for Clinical Interventions.

ISBN: 0 9757995 6 8

Created: August 2011

المرحلة الخامسة

إعادة تقييم التفكير غير المفيد المتعلق بالصحة

١- مقدمة

٢- اتصال العقل والجسم

٣- كيفية معالجة الأفكار غير المفيدة المتعلقة بالصحة

○ يوميات الأفكار - مثال

○ يوميات الأفكار - ورقة عمل

٤- ملخص يوميات أفكاري

٥- وقفة مهمة بشأن الدليل الواقعي

٦- ملخص المرحلة

٧- حول المراحل

مقدمة

تحدثنا في المرحلة الثالثة عن كيفية بقاء قلق الصحة كامناً لبعض الوقت، ولكن عندما تتم استثارته فمن المحتمل أن يؤثر سلباً على طريقة تفكيرنا في الأعراض والأحاسيس الجسدية والمعلومات المتعلقة بالصحة. وتدرّبنا في المرحلة الرابعة على توجيه انتباهنا بعيداً عن هذه الأعراض والهموم المكثّرة من خلال تقوية عضلة انتباهنا أولاً، ثم تعلمنا إرجاء أو "تأجيل" التفكير في مخاوفنا المتعلقة بالصحة إلى وقت لاحق. في هذه المرحلة، سنفحص ما يمكنك فعله مع هذه الأفكار السلبية وغير المفيدة بمجرد وصولك إلى "الفترة المخصصة للقلق" التي حددتها. سوف ندرس هذه الأفكار بمزيد من التفصيل، ونناقش طرق تقييمها والتغلب عليها.

اتصال العقل والجسم

إن ما تفكر فيه والأفكار التي تدور في ذهنك مهمة جداً في تحديد ما تشعر به. توقف للحظة وفكّر: عندما تشعر بالرضا، ما هي أنواع الأفكار التي تدور في رأسك؟ بالمقابل، عندما تشعر بالسوء، ما أنواع الأفكار التي لديك؟

من المنطقي بالنسبة لمعظم الناس أن نقول:

ليست المواقف التي نمر بها هي ما تحدد ما نشعر به، ولكن الأفكار والمعاني والتفسيرات التي نقدمها لهذا المواقف هي التي تحدد مشاعرنا.

هذا مثال على ما نعيشه. تخيل أنك في السرير ليلاً، وسمعت صوت ضوضاء عالية. هناك على الأقل ثلاث طرق مختلفة للتفكير في هذا الموقف، وهناك انفعالات، وأحاسيس جسدية، وسلوكيات تختلف وفقاً لطرق التفكير المختلفة.

مثال: أنا في السرير ليلاً وسمعت ضوضاء عالية			
سلوكيا	بدنيا	انفعاليا	
أضحك، وأنادي عليها.	ابتسم، أشعر بالهدوء.	اللهو والتسلية.	<u>الفكرة الأولى:</u> أتوقع أن هذه هي قطتي الصغيرة المشاغبة، وأتساءل عن نوع الشغب الذي قامت به للتو.
التركيز على وجود ضوضاء أخرى، الإمساك بالهاتف والاتصال بالشرطة.	تسارع ضربات القلب، وتوتر، وتعرق.	قلق	<u>الفكرة الثانية:</u> يا إلهي، يبدو أن هناك من يحاول اقتحام منزلي.
أعود للنوم	هادئ تماماً	محايد	<u>الفكرة الثالثة:</u> هممم.. يبدو أن الجيران يُخرجون سلة المهملات الخاصة بهم.

ونظرًا لأننا عادة لا نكون على وعي بهذه الأفكار، فقد لا ندرك مدى تأثيرها علينا. هل يمكنك الآن أن ترى كيف يكون لاعتقاداتنا دور مهم جدًا في تحديد ما نشعر به انفعاليًا وجسديًا، وكيف يمكن أن تؤثر على ما نفعله؟ بشكل عام، فإن تأثير أفكارنا على حالتنا الانفعالية والجسدية عادة ما يكون عملية مفيدة تمامًا. فإذا اقتحم شخص ما منزلك *بالفعل*؛ فإن انطلاق استجابة القلق لديك -متضمنة سرعة ضربات قلبك والبدء في التعرق- يعني أنك أكثر استعدادًا بدنيًا للتعامل مع هذا الموقف المهدد.

ومع ذلك، غالبًا ما يدرك الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة أن هناك تهديدًا لصحتهم أكبر مما هو عليه في الواقع. هذا لا يعني أنك تتخيل الأعراض - بل هي أعراض حقيقية! ولكنك إذا فسرت هذه الأعراض أو فكرت فيها بطريقة كارثية؛ فغالبًا سيؤدي ذلك إلى مشاعر وأحاسيس سلبية شديدة في جسمك.

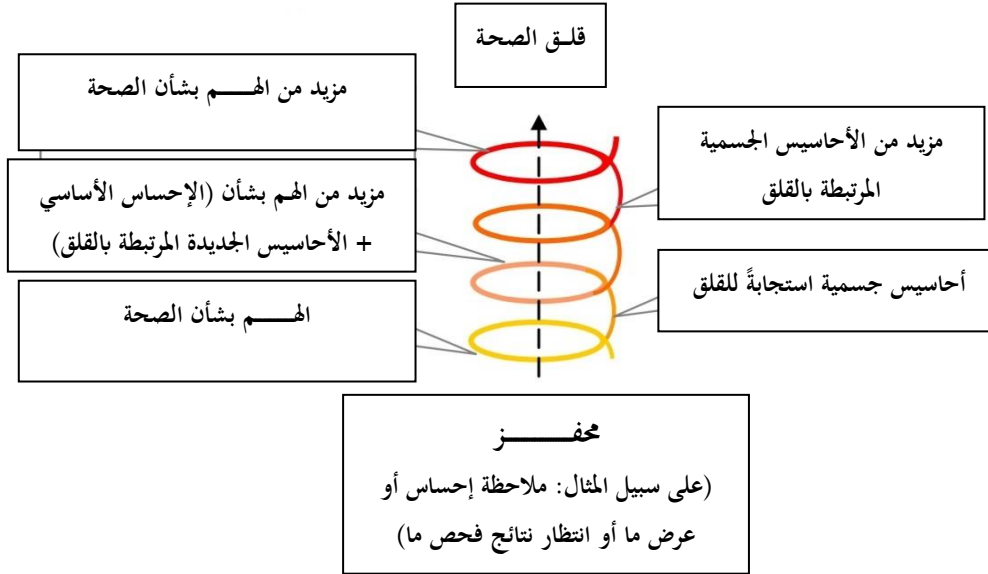
يميل الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة إلى:

- المبالغة في تقدير احتمالية تعرضهم الآن أو في المستقبل لمشكلة صحية خطيرة.
- المبالغة في تقدير مدى سوء الأمور.
- تجاهل أو استبعاد التفسيرات المحتملة الأخرى (الأقل كارثية) لأعراضهم ولاستجابة أطبائهم.
- التقليل من قدرتهم على معالجة أي مشكلة صحية أو التعامل معها أو إدارتها.

فيما يلي بعض الأمثلة للأفكار الشائعة التي يخبرها الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة:

لقد كنت متعبًا جدًا ومرهقًا - قد أكون مصابًا بسرطان الدم.
 كانت والدتي مصابة بالسرطان، لذلك هناك فرصة كبيرة لإصابتي به أيضًا.
 قلبي يتسارع - سأصاب بنوبة قلبية.
 قد أصاب بمرض خطير وأموت.
 أنا متأكد من إصابتي بمرض السكري لأنني ذهبت إلى الحمام أربع مرات اليوم.
 جنبي يؤلمني - قد يكون هذا سرطان المبيض أو المعدة.
 لدي أفكار غريبة - قد أكون مصابًا بالفصام ولا أعرف.
 قد تقتلني هذه العملية.
 لم أر هذا الشامه من قبل - قد يكون سرطان الجلد.
 لقد أصبت بالإسهال لمدة ثلاثة أيام - قد يكون هذا سرطان القولون.
 أعاني من صداع - يمكن أن يكون وربما في المخ
 أو تمدد الأوعية الدموية *an aneurism*
 ركبتني تؤلمني - لا بد أنني أعاني من التهاب المفاصل.
 ما زلت أنسى الأشياء - قد تكون هذه بداية الخرف.
 أشعر بضعف شديد مؤخرًا - قد يكون هذا علامة على التصلب المتعدد.
 نظرًا لأن كل هذه الأفكار المرتبطة بالصحة تتعلق بتهديد محتمل لصحة الفرد وعافيته، فمن المتوقع أن تستثير استجابة القلق. هذه هي الطريقة التي تعمل بها العلاقة بين العقل والجسد! ولسوء الحظ، قد يؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة من

القلق بشأن صحتنا، فالقلق يثير مزيداً من الأحاسيس الجسمية، تلك الأحاسيس الجسمية التي يلاحظها الفرد فيقلق بشأنها أكثر.



لحسن الحظ هناك شيء يمكننا فعله حيال هذه الحلقة المفرغة. سوف تستكشف في هذه المرحلة كيف يمكننا البدء في كسر هذه الحلقة من خلال تحديد تلك الأفكار المقلقة التي تراودك بشأن صحتك وتحديثها.

ملاحظة: سنتطرق هنا إلى السلوكيات التي تنشأ عن هذه الأفكار، ولكننا سنعود إليها في المرحلتين السادسة والسابعة.

كيفية معالجة الأفكار غير المفيدة المتعلقة بالصحة

تتمثل إحدى طرق المساعدة في معالجة الأفكار غير المفيدة المتعلقة بالصحة في تحديها وجهاً لوجه. تذكر أن أفكارنا هي مجرد أفكار. أحياناً تكون أفكارنا دقيقة، وأحياناً تكون صحيحة جزئياً فقط، وأحياناً لا تمثل حقيقة الموقف على الإطلاق، والطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها معرفة مدى دقة أفكارنا حقاً هي مناقشتها بدقة وفحصها وتقييمها.

هناك طريقة مفيدة للتفكير في هذا الأمر وهي أن تتخيل أنك مُحَقِّق يجمع الأدلة لصالح قضية وضدها، وينظر في الأسباب والتفسيرات المحتملة الأخرى، ويحاول التوصل إلى أكثر التفسيرات دقة وأكثرها ترجيحاً. لا يجب أن تحاول تقييم هذه الأفكار في ذهنك لأن هذا قد يؤدي إلى التشوش والارتباك. أفضل طريقة هي كتابتها، ونقترح عليك استخدام "يوميات الأفكار". لقد تم تصميم يوميات الأفكار لإرشادك خلال عملية التقييم خطوة بخطوة. إن الكتابة تجعل الأمور أكثر وضوحاً وأكثر إفادة لك.

في الصفحات القليلة التالية تعليمات لكيفية إكمال "يوميات الأفكار" ومثال على ذلك. يلي ذلك "يوميات أفكار" فارغة حتى يمكنك التدرب عليها.

في البداية سيُطلب منك في يوميات الأفكار تحديد أفكارك غير المفيدة المتعلقة بالصحة. ولمساعدتك على القيام بذلك، اسأل نفسك أولاً:

• ما الذي أثار النوبة الحالية لقلق الصحة؟

ثم:

• ما الذي يقلقني؟

• ما الذي أتوقعه؟

• ما هي الاستنتاجات التي أقفز إليها؟

بعد أن تقوم بتدوين هذه الأفكار، حدد أكثر هذه الأفكار إزعاجًا وقم بتقييم قوة اعتقادك بين ٠ و ١٠٠٪.

ستحتاج بعد ذلك أن تسأل نفسك - عندما أفكر بهذه الطريقة، بماذا أشعر؟

• ما هي المشاعر التي أشعر بها؟ (على سبيل المثال: هم، خوف، حزن، انشغال بال، قلق).

• قِيم شدة مشاعرك بين ٠ و ١٠٠٪.

• ما هي الأحاسيس الجسدية التي ألاحظها؟ (على سبيل المثال: تسارع ضربات القلب، توتر عضلي، تعب).

بمجرد الانتهاء من القسم الأول، تكون جاهزًا للبدء في تحدي الأفكار غير

المفيدة المتعلقة بالصحة. فيما يلي الأسئلة التي سيتم طرحها في "يوميات

أفكارك" لتحدي هذا النوع من الأفكار:

• ما هو الدليل الواقعي على صحة هذه الفكرة؟

- ما هو الدليل الواقعي على عكس هذه الفكرة؟
- ملاحظة: تأكد من تضمين الأدلة عالية الجودة فقط، كما ستري في آخر هذه المرحلة تحت عنوان "وقفه مهمة بشأن الدليل الواقعي".
- كيف يؤثر عليّ توقُّع أسوأ سيناريو؟
- ما الذي يمكنني فعله للتأقلم إذا حدث بالفعل "التوقع الأسوأ"؟
- هل هناك أي تفسيرات أخرى محتملة للأعراض التي أعانيها، أو لاستجابة طبيبي؟
- ما هو التفسير الأكثر احتمالاً؟
- ما الذي يمكنني فعله في الوقت الحالي للتعامل مع هذا العرض أو الموقف؟
- الهدف النهائي من "يوميات الأفكار" هو تخليق أفكار أكثر واقعية بشأن الصحة. وبمجرد الوصول لإجابات للأسئلة "الصعبة" الموجودة في "يوميات أفكارك"، اسأل نفسك:
- ما هو التفكير الأكثر واقعية حول هذا العرض أو الموقف؟
- الخطوة الأخيرة هي:
- إعادة تقييم درجة اعتقادك الآن في فكرتك الأصلية.
- إعادة تقييم حدة المشاعر التي كنت تشعر بها في الأصل.
- قيّم ما إذا كان هناك أي تغيير في أحاسيسك الجسدية.

إذا كنت لا تواجه سوى عدد قليل من الأفكار غير المفيدة المتعلقة بالصحة يوميًا، ولا تستهلك تلك الأفكار قدرًا كبيرًا من وقتك، ولا تعطلك عن أنشطتك اليومية، فننصحك باستخدام يوميات الأفكار فقط عندما تلاحظ أنك تشعر بالهم أو القلق على صحتك.

أما إذا كنت تعاني من عديد من الأفكار غير المفيدة المتعلقة بالصحة على مدار اليوم، ومقدار الوقت الذي تقضيه في التفكير في صحتك يعطلك عن أنشطتك اليومية؛ فإننا نوصيك بأن تقوم بدمج تمرين تأجيل القلق الموجود في المرحلة الرابعة مع استخدام "يوميات الأفكار" هذه. هذا يعني أنك عندما تجد نفسك قلقًا بشأن صحتك، فإنك ستؤجل التفكير في أي أفكار حول صحتك حتى مجيء الوقت والمكان المخصصين، وعندما تصل إلى هذا الوقت والمكان المحددين، يمكنك حينئذ قضاء بعض الوقت في تسجيل "يوميات الأفكار" لتقييم أفكارك.

إذا بدأت العمل في "يوميات الأفكار" لتحدي أفكارك غير المفيدة المتعلقة بالصحة، فمن المحتمل أنك ستشهد انخفاضًا في قوة اعتقادك بصحة هذه الأفكار، وبالتالي ستلاحظ انخفاضًا في شدة مشاعرك وأحاسيسك الفسيولوجية. ورغم أن الأمر سيستغرق بعض الجهد والممارسة، فإننا نوصيك بالاستمرار في استخدام "يوميات الأفكار" حتى تصبح عادة لديك أن تتوقف وتفحص أفكارك.

يوميّات الأفكار - مثال

تحديد الأفكار غير المفيدة المتعلقة بالصحة

ما الذي أثار النوبة الحالية لقلق الصحة؟ حصلت على نتيجة فحص سلبية لنقص الحديد بعد شعوري بالتعب والإرهاق لعدة أسابيع. قال لي الطبيب أن كل ما عليّ فقط هو مراقبة الأعراض التي أعانيها، والعودة إليه إذا ساءت.
ما الذي يقلقني؟ ما الذي أتوقعه؟ ما هي الاستنتاجات التي أقفز إليها؟ إذا لم يكن نقص الحديد هو السبب، فلا بد أن السبب شيء أسوأ بكثير. لم يطلب طبيبي فحوصاً أخرى بحثاً عن مشاكل أكثر خطورة. قد يعني هذا التعب شيئاً خطيراً، مثل اللوكيميا. ضع خطأً تحت الفكرة الأكثر إزعاجاً ثم قيّم درجة اعتقادك فيها (٠-١٠٠٪)؟ ٨٠٪
بماذا شعرت عندما فكرت بهذه الطريقة؟ قيّم شدة المشاعر (٠-١٠٠٪): الأحاسيس الجسدية: قلق (٩٠٪) زيادة ضربات القلب، شعور بثقل على الصدر

تحدي الأفكار غير المفيدة المتعلقة بالصحة

ما هو الدليل الواقعي على صحة هذه الفكرة؟	ما هو الدليل على عكس هذه الفكرة؟
- إنني أشعر بالتعب. - لقد بحثت على الإنترنت ووجدت أن التعب والإرهاق من أعراض سرطان الدم. - أظهرت نتائج الفحوص أنه لا يوجد نقص في الحديد. - لم يقيم طبيبي بإجراء فحص لسرطان الدم على وجه التحديد.	- ما قاله طبيبي من أن التعب والإرهاق شائعان للغاية وقد يكونان مرتبطين بالضغط. - ليس لدي أعراض سرطان الدم الأخرى (تورم الغدد الليمفاوية، أو التهابات متكررة، أو حدوث كدمات بسهولة، أو فقدان الوزن غير المبرر، أو ألم في المفاصل والعظام).
كيف يؤثر عليّ توقُّع أسوأ سيناريو؟ يجعلني أشعر بالقلق والغضب قليلاً من طبيبي لعدم إجراء مزيد من الفحوص. أجد صعوبة في إبعاد تركيزي عن التعب.	
ما الذي يمكنني فعله للتأقلم إذا حدث بالفعل "التوقع الأسوأ"؟ سأبدأ العلاج. من المحتمل أن يشمل ذلك العلاج الكيميائي، وزرع نخاع العظم إذا تم العثور على ما يتطابق بالنسبة لي. سأفكر بالطبع في احتمال الموت.	

من المحتمل أن تكون التجربة بأكملها صعبة للغاية، لكنني سأحصل على دعم العائلة والأصدقاء.

هل هناك أي تفسيرات أخرى محتملة للأعراض التي أعانيها، أو لاستجابة طبيبي؟

هل قمت مؤخرًا بتغيير روتيني أو نظامي الغذائي أو أدويتي أو مستويات نشاطي؟ هل أحتاج إلى تحسين هذه الأمور؟ هل كنت أعاني من زيادة التوتر مؤخرًا؟ أو هل عانيت من مرض طبي بسيط - مثل الزكام، يمكن أن يفسر ما أشعر به؟ لقد كنت مشغولًا جدًا ومرهقًا في العمل مؤخرًا. ربما لم أكن أعتني بنفسي أو أنام كالمعتاد. ربما يرى طبيبي كثيرًا من الأشخاص الذين يشعرون بهذه الأعراض وليس لديهم اللوكيميا، لذا لم يشعر بالقلق حيال أعراضني.

ما هو التفسير الأكثر احتمالاً؟

أنا فقط مرهق جداً، وأحتاج إلى الاعتناء بنفسني بشكل أفضل قليلاً.

ما الذي يمكنني فعله في الوقت الحالي للتعامل مع هذا العرض أو الموقف؟

سأحرص على شراء بعض الفواكه والخضروات الطازجة لأتناولها، بدلاً من مجرد تناول القهوة. سأخذ أيضاً بعض الوقت لأسترخي من خلال أخذ حمام فقاعات، وسوف أذهب إلى الفراش مبكراً بعض الشيء، وسأطلب بعض المساعدة في إدارة مشروع كبير في العمل.

توليد أفكار أكثر واقعية بشأن الصحة

ما هو التفكير الأكثر واقعية حول هذا العرض أو الموقف؟ ربما تكون هذه مجرد علامة على أنني متوتر ومرهق. ليس لدي أي أعراض أخرى ولذلك لم يشعر طبيبي بالقلق كثيرا بشأن هذا التعب.		
ما هي درجة اعتقادي الآن في فكري الأصلية (٠ - ١٠٠) % ؟ ٤٠ %		
ما درجة شدة مشاعري الآن (٠ - ١٠٠) % ؟ ٣٠ %		
ما مدى شدة أحاسيسي الجسدية الآن (ضع دائرة)		
أقل	نفس الشدة	أكثر شدة شدة

يوميّات الأفكار

تحديد الأفكار غير المفيدة المرتبطة بالصحة

ما الذي أثار النوبة الحالية لقلق الصحة؟
ما الذي يقلقني؟ ما الذي أتوقعه؟ ما هي الاستنتاجات التي أقفز إليها؟ ضع خطأً تحت الفكرة الأكثر إزعاجاً ثم قيّم درجة اعتقادك فيها (٠-١٠٠٪)؟
بماذا أشعر عندما أفكر بهذه الطريقة؟ قيّم شدة المشاعر (٠-١٠٠٪): الأحاسيس الجسدية:

تحدي الأفكار غير المفيدة المرتبطة بالصحة

ما هو الدليل الواقعي <u>على صحة</u> هذه الفكرة؟	ما هو الدليل <u>على عكس</u> هذه الفكرة؟
--	--

كيف يؤثر عليّ توقُّع الأسوأ؟
ما الذي يمكنني فعله للتأقلم إذا حدث بالفعل "التوقع الأسوأ"؟
هل هناك أي تفسيرات أخرى محتملة للأعراض التي أعانيها، أو لاستجابة طبيبي؟ هل قمت مؤخرًا بتغيير روتيني أو نظامي الغذائي أو أدويتي أو مستويات نشاطي؟ هل أحتاج إلى تحسين هذه الأمور؟ هل كنت أعاني من زيادة التوتر مؤخرًا؟ أو هل عانيت من مرض طبي بسيط - مثل الزكام، يمكن أن يفسر ما أشعر به؟
ما هو التفسير الأكثر احتمالاً؟
ما الذي يمكنني فعله في الوقت الحالي للتعامل مع هذا العرض أو الموقف؟

توليد أفكار أكثر واقعية بشأن الصحة

ما هو التفكير الأكثر واقعية حول هذا العرض أو الموقف؟
ما هي درجة اعتقادي الآن في فكري الأصلية (٠ - ١٠٠) %؟

ما درجة شدة مشاعري الآن (٠ - ١٠٠) %؟		
ما مدى شدة أحاسيسي الجسدية الآن (ضع دائرة)		
أكثر شدة	نفس الشدة	أقل شدة

ملخص يوميات أفكار

بمجرد الانتهاء من كتابة عدد من يوميات الأفكار، يمكنك إكمال ورقة العمل هذه كدليل مرجعي سريع لتذكيرك بأفكارك الواقعية الجديدة المتعلقة بالصحة. تُستخدم هذه الطريقة إذا راودتك الفكرة نفسها أو فكرة مماثلة مزعجة وغير مفيدة، يمكنك ببساطة مراجعة ورقة العمل هذه بدلاً من البحث في جميع يوميات الأفكار الكاملة. ومع ذلك، إذا قرأت شيئاً من عمود "الأفكار الواقعية الجديدة المتعلقة بالصحة" ووجدت أنك لا تصدقه بالفعل، فإنك تحتاج إلى العودة إلى يوميات الأفكار وتطبيق ورقة عمل أخرى حول هذه المسألة.

الفكرة الواقعية الجديدة المتعلقة بالصحة	الفكرة غير المفيدة الأصلية المتعلقة بالصحة
ربما تكون هذه مجرد علامة على أنني متوتر ومرهق. ليس لدي أي أعراض أخرى ولذلك لم يشعر طبيبي بالقلق كثيراً بشأن هذا التعب.	مثال: قد تكون لدي مشكلة خطيرة مثل سرطان الدم.

وقفة مهمة بشأن "الدليل الواقعي"

مع غزارة المعلومات المتاحة لنا بسهولة عبر وسائل الإعلام ومحركات البحث على الإنترنت، من المهم بالنسبة لنا أن نكون مستهلكين أذكياء للمعلومات التي نلتقهاها. عند الانتهاء من "يوميات الأفكار"، نحتاج إلى النظر في "الأدلة الواقعية" سواء كانت مؤيدة أو معارضة لأفكارنا. ولكن كيف يمكننا معرفة ما إذا كانت المعلومات التي لدينا "واقعية" أم لا؟

لسوء الحظ، لا تخضع جميع المعلومات الصحية المتوفرة في المجالات والصحف وعلى الإنترنت لعملية مراقبة الجودة. قد تبدو بعض مواقع الويب، مقنعة تمامًا من مظهرها الخارجي، ولكنها لا تمثل في الواقع أفضل الممارسات وأحدث المعلومات المتعلقة بالصحة. قد يكون هذا مُحيرًا وخطيرًا بالنسبة لنا.

قد يكون الأمر مُحيرًا عندما نتلقى رسائل مختلطة حول ما إذا كنا بحاجة إلى إجراء تغييرات في أشياء مهمة، مثل: أنظمتنا الغذائية أو الأدوية أو خيارات نمط الحياة الأخرى أو لا. وقد يكون الأمر مُحيرًا أيضًا عندما نتلقى رسائل مختلطة حول أهمية أعراض معينة، وعلاقتها بمشكلات صحية خطيرة، والاحتياج إلى طلب المساعدة من المتخصصين في مجال الصحة. وقد يكون الأمر خطيرًا عندما نتخذ قرارات أو تغييرات بشأن صحتنا بناءً على معلومات غير موثوقة أو واقعية.

أثناء حديثنا في المرحلة التالية عن كيفية البحث عن المعلومات في المصادر المختلفة، يمكننا البدء في تقليل أي ارتباك أو مخاطر، واتخاذ موقف أكثر فائدة وتمحيصاً لما نطلع عليه؛ من خلال تغيير الطريقة التي نبحث بها عن المعلومات الصحية.

طريقة البحث عن المعلومات

في كثير من الأحيان يمكننا تحويل الشيء الذي نفكر فيه إلى عبارة مكتوبة في محرك البحث على الإنترنت. على سبيل المثال، إذا كنا قلقين بشأن تأثيرات القلق في الإصابة بأزمة قلبية، فقد نكتب "القلق والنوبات القلبية" ونبدأ في البحث. قد يكون هذا النوع من البحث إشكالياً؛ لأنه يمكن أن يؤدي إلى نتائج متحيزة. ذلك لأنه على الأرجح سيقوم:

- بانتقاء صفحات الويب التي تتحدث عن وجود روابط بين القلق والنوبات القلبية.

- واستبعاد أي روابط لا تتحدث عن مثل هذه العلاقة أو تدحضها.

وبالتالي، فإن هذا البحث غير المفيد يمكن أن يعزز اعتقادك المقلق بوجود رابطة بين القلق والإصابة بالنوبات القلبية!!

هناك خطوتان يمكنك اتباعهما لتغيير طريقة جمع المعلومات من الإنترنت وانتقائها.

الخطوة ١: تدرب على استخدام عبارات بحث أكثر فائدة وأقل تحيزاً لمعرفة ما تريد معرفته.

فمثلاً:

بإمكانك	بدلاً من:
أن تجرب:	
"القلق والنوبات القلبية"	"ما الذي يسبب النوبات القلبية؟" أو
"الأسباب الرئيسية	
للنوبات القلبية"	أقل فائدة
أكثر فائدة	انتقاء أكثر تحيزاً
أقل تحيزاً	انتقاء

الخطوة ٢: ابحث عن طرق لانتقاء المعلومات من وجهات نظر مختلفة. يمكنك القيام بذلك عن طريق كتابة عبارات غير متماثلة. على سبيل المثال، يمكن أن تجرب: "هل القهوة ضارة لك؟" و "هل القهوة مفيدة لك؟" يمكن أن تقودك هذه الاستراتيجيات إلى الخروج ببعض المعلومات الصحية المختلفة جداً!

إذا كنت شخصاً يستخدم الإنترنت في البحث عن معلومات صحية، فخذ لحظة للتفكير في بعض الطرق البديلة التي يمكنك من خلالها البحث عن هذه المعلومات:

بدلاً من: يمكنني (أيضاً) تجربة:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

تقييم المعلومات الصحية

حتى مع وجود استراتيجيات بحث جيدة، فغالبًا ما نواجه معلومات غير مفيدة أو حتى متضاربة (على سبيل المثال: يفيد مقال في إحدى المجلات بأن القهوة مفيدة لك بينما يوضح مقال آخر أن القهوة ضارة لك).

لسوء الحظ، في هذه الأيام وفي هذا العصر، يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى الإنترنت إرسال معلومات عبر العالم والادعاء بأنها واقعية. في الوقت نفسه هناك بعض مواقع الويب أو بعض المقالات في المجلات تحتوي على معلومات مفيدة من مصادر موثوقة. فكيف نعرف ما هي المعلومات الجيدة وما هي المعلومات غير الجيدة؟

هناك عشرة أسئلة يمكن طرحها:

- هل هذه المعلومات مكتوبة من قِبَل متخصص مؤهل ومُعتمد في المجال الصحي (على سبيل المثال: ممارس عام، أو طبيب نفسي)؟
- هل يمثل الكاتب مؤسسة صحية راسخة وذات سمعة طيبة (على سبيل المثال: هيئة حكومية، أو جامعة، أو مستشفى عام)؟
- هل الكاتب متجرد عن المصالح التجارية (أي أنه لا يحاول بيع منتج لك أو إثارة قصة لبيع مجلة)؟
- هل يحتوي المقال على أدلة متعددة لدعم ادعاءاته (أي يناقش نتائج عديد من الدراسات البحثية التي أجرتها مؤسسات مرموقة بدلاً من رواية القصص أو الحديث عن دراسة أُجريت لمرة واحدة)؟
- هل تم توفير معلومات كافية لك للتحقق من خلفية البحث بنفسك؟

- هل اعتمدت خلفية البحث على أشخاص مشابهين لك (على سبيل المثال: في العمر، والطول/ الوزن، والجنس، والتشخيص، والمشكلات المرضية المشتركة، إلخ)؟
- هل تم إجراء البحث على عديد من الأشخاص؟
- هل الإحصائيات مذكورة بوضوح؟
- هل هذه المعلومات متوافقة مع المعلومات الصحية التي قرأتها من جهات أخرى حسنة السمعة، (على سبيل المثال: الهيئات الحكومية الأخرى، والجامعات، والمستشفيات الكبرى)؟
- هل تم تقديم تاريخ المراجعة (المعلومات المقدمة) حتى تتمكن من معرفة مدى حداثة المعلومات؟

كلما زاد عدد الأسئلة التي أجبت عليها بالموافقة، فمن المرجح أن تكون معلوماتك الصحية أفضل. ومع ذلك فإنه من المهم أن تتذكر أن المعلومات الواردة من الإنترنت ووسائل الإعلام هي مصدر واحد فقط، ولا ينبغي استخدامها بمفردها لتشخيص حالة طبية أو نفسية، أو لإجراء تغييرات مهمة في أدويةك أو نظامك الغذائي أو خيارات نمط الحياة الأخرى. يمكن أن يساعدك طبيبك العام أو العيادة الصحية المحلية في فهم المخاطر والفوائد المحددة لمثل هذه التغييرات بناءً على تاريخك الطبي و/ أو النفسي الشخصي الكامل.

ملخص المرحلة الخامسة

- تؤثر أفكارنا على انفعالاتنا وعلى حدوث بعض الأحاسيس الجسدية في أجسامنا. يُعرف هذا بالاتصال بين العقل والجسد.
- يميل الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة إلى:
 - المبالغة في تقدير احتمالية إصابتهم بمشكلة صحية خطيرة.
 - المبالغة في تقدير مدى سوء الأمور.
 - تجاهل أو استبعاد التفسيرات الأخرى الممكنة لأعراضهم أو استجابات أطبائهم (تلك التفسيرات التي غالبًا ما تكون أقل كارثية).
 - التقليل من قدرتهم على علاج مشكلاتهم الصحية أو التعامل معها أو إدارتها.
- عندما نعتقد أن هناك تهديدًا على صحتنا، يتسبب هذا في استثارة استجابة القلق لدينا، مما يؤدي إلى مزيد من الأحاسيس الجسدية، والتي قد نشعر بالقلق أيضًا بشأنها. ومن ثم يمكن أن يؤدي هذا إلى حلقة مفرغة من قلق الصحة.
- إحدى الطرق للتغلب على هذه الحلقة المفرغة من قلق الصحة هي تحدي الأفكار غير المفيدة المتعلقة بالصحة وجهاً لوجه باستخدام يوميات الأفكار. يتضمن ذلك تحديد ما نتوقعه أو نقلق بشأنه، وتحدي تنبؤاتك أو توقعاتك، وتطوير أفكار أكثر واقعية تتعلق بالصحة.

• إذا كنا نستخدم أدلة من الإنترنت أو وسائل الإعلام لتقييم مدى دقة أفكارنا المتعلقة بالصحة؛ فنحن بحاجة إلى التأكد من وصولنا إلى المعلومات من المنظمات الصحية الموثوق بها وذات السمعة الطيبة وغير المتحيزة.

التالي ...

في المرحلة التالية، سنبدأ في استكشاف طرق لتقليل عمليات الفحص المفرطة وسلوكيات طلب التطمين.

Helping Health Anxiety

About The Modules

CONTRIBUTORS

Dr Rebecca Anderson (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

Paula Nathan (MPsych¹)
Centre for Clinical Interventions

Dr Lisa Saulsman (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

¹Masters of Psychology (Clinical Psychology)

²Doctor of Philosophy (Clinical Psychology)

BACKGROUND

The concepts and strategies in these modules have been developed from evidence based psychological practice, primarily Cognitive-Behaviour Therapy (CBT). CBT for health anxiety is based on the approach that health anxiety is a result of problematic cognitions (thoughts) and behaviours.

REFERENCES

These are some of the professional references used to create the modules in this information package.

Abramowitz, J., Taylor, S., & McKay, D. (2010). Hypochondriasis and severe health anxiety. In McKay, D., Abramowitz, J., S., & Taylor, S. (Eds.). *Cognitive-behavior therapy: Turning failure into success* (pp. 327-346). Washington, DC: American Psychological Association.

Asmundson, G., & Taylor, S. (2005). *It's not all in your head: How worrying about your health could be making you sick – and what you can do about it*. New York: The Guilford Press.

Furer, P., & Walker, J. (2006). *Health anxiety treatment manual*. University of Manitoba: Manitoba.

Furer, P., Walker, J., & Stein, M. (2007). *Treating health anxiety and fear of death*. New York: Springer.

Papageorgiou, C., & Wells, A. (1998). Effects of attention training on hypochondriasis: A brief case series. *Psychological Medicine*, 28, 193-200.

Salkovskis, P., Warwick, H., & Deale, A. (2003). Cognitive-behavioural treatment for severe and persistent health anxiety (Hypochondriasis). *Brief Treatment and Crisis Intervention*, 3, 353-367.

Willson, R., & Veale, D. (2009). *Overcoming health anxiety: A self-help guide using cognitive behavioural techniques*. London: Robinson.

“HELPING HEALTH ANXIETY”

This module forms part of:

Anderson, R., Saulsman, L., & Nathan, P. (2011). *Helping Health Anxiety*. Perth, Western Australia: Centre for Clinical Interventions.

ISBN: 0 9757995 6 8

Created: August 2011

المرحلة السادسة

تقليل الفحص وطلب التطمين

- ١- مقدمة
- ٢- لماذا نقوم بالفحص ونطلب التطمين؟
- ٣- سلوكيات الفحص وطلب التطمين الشائعة
- ٤- الفحص وطلب التطمين المفيدان في مقابل غير المفيد
- ٥- كيفية تقليل عمليات الفحص والتطمين غير المفيدة
 - تقليل الفحص وطلب التطمين - مثال ١
 - تقليل الفحص وطلب التطمين - مثال ٢
 - تقليل الفحص وطلب التطمين - ورقة عمل
- ٦- ملخص المرحلة
- ٧- حول المراحل

مقدمة

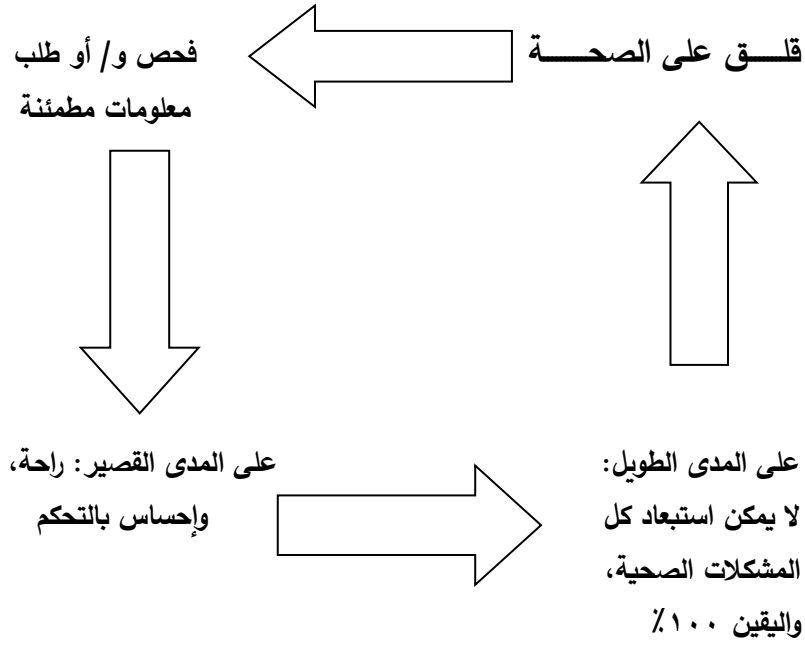
في المرحلة الثالثة، أوضحنا أن الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة ينخرطون غالباً في إجراءات مفرطة للفحص وطلب التطمين. وهم يقومون بذلك بشكل عام في محاولة منهم لتخفيف قلق الصحة، ولكن ما يحدث بالفعل أن هذه السلوكيات تغذي قلقهم. في هذه المرحلة، سنعيد النظر في الطرق المختلفة التي يتبعها الأشخاص في الفحص وطلب التطمين بشأن صحتهم، ونستكشف الفرق بين الفحص وطلب التطمين المفيد وغير المفيد، ونستكشف استراتيجيات تقليل هذه السلوكيات أو القضاء عليها.

لماذا نقوم بالفحص ونطلب التطمين؟

ينخرط كثيرٌ منا في سلوكيات الفحص وطلب التطمين بشأن الصحة. ونحن نقوم بذلك لتقليل قلقنا، وزيادة إحساسنا بالتحكم واليقين بشأن صحتنا، ولطمأنة أنفسنا بأن صحتنا ليست في خطر. وغالباً ما تعطينا هذه السلوكيات بعض الراحة على المدى القصير.

لسوء الحظ، إننا لا يمكننا التأكد حقاً من أننا بصحة جيدة تماماً. إن طبيعة الفحوصات الطبية هي أن تقرر أو تستبعد تشخيصاً معيناً. ولا يمتلك الأطباء

"فحوصا لكل شيء" يكون على غير ما يُرام في أجسامنا. لذلك يمكن أن نفع أحيانًا في حلقة طمأنة مفرغة حيث يقودنا قلقنا بشأن صحتنا إلى الفحص و/ أو البحث عن معلومات مطمئنة حول صحتنا، ويمنحنا هذا إحساسًا بالتحكم أو الراحة على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل لا يمكننا استبعاد جميع المشكلات الصحية المحتملة، وبالتالي تدور الحلقة مرة أخرى.



كما ذكرنا سابقاً، من المستحيل أن يحصل أي شخص على ضمان بنسبة ١٠٠٪ بأنه يتمتع بصحة تامة. ومع ذلك، فإن عدم اليقين هو شيء يجب على جميع البشر أن يتعلموا تحمله. لسوء الحظ، فإن الإجراء المفرد للفحص وطلب التطمين يمنعا في النهاية من بناء هذا التحمل وتقبل الأمر بأن صحتنا غير مؤكدة. إننا نقضي كثيراً من وقتنا منشغلين بمحاولة تخلص أنفسنا من حالة عدم اليقين هذه (عن طريق الفحص وطلب التطمين)، بدلاً من البقاء مع عدم اليقين وبناء تحملنا له.

تتمثل إحدى طرق كسر حلقة طلب التطمين في تقليل سلوكيات الفحص والطمأنة لدينا إلى مستوى أكثر إفادة، وممارسة تحمل وتقبل بعض عدم اليقين وبعض القلق الذي يصاحب عدم القيام بالفحص أو طلب معلومات مطمئنة.

في هذه المرحلة سوف نستكشف الأنواع المختلفة من الفحص وطلب التطمين لدى الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة. وسنناقش أيضاً الفرق بين المستويات المفيدة وغير المفيدة من الفحص وطلب التطمين، والطرق التي يمكنك من خلالها البدء في تقليل هذه السلوكيات.

سلوكيات الفحص وطلب التطمين الشائعة

قدمنا في المرحلة الثالثة مجموعة من سلوكيات الفحص وطلب التطمين الشائعة. ولكي نقوم بتلخيصها الآن، توقف لحظة لإلقاء نظرة على القائمة التالية، وحدّد ما إذا كان هناك أي من السلوكيات المدرجة تقوم به بشكل متكرر ومُعاد. قد تكون على وعي بسلوكيات أخرى غير المدرجة هنا، لذلك تم تخصيص مساحة إضافية لإدراجها أدناه.

- تفحص الجسد في المرآة بحثًا عن علامات لعدم التناسق أو مناطق تغير لونها أو شامات أو كتل جديدة.
- وخز أو تفحص باليد أو قرص الجلد أو الثدي أو المعدة أو مناطق أخرى من الجسم.
- فحص إفرازات الجسم (مثل اللعاب والبول والبراز) bodily excretions بحثًا عن وجود دم أو علامات عدوى.
- قياس أجزاء من الجسم (على سبيل المثال، باستخدام شريط قياس أو قياس سمك calipers).
- مراقبة العمليات الجسمية (مثل قياس النبض وفحص ضغط الدم).
- وزن الجسم أو إفرازات الجسم.
- سؤال أفراد الأسرة والأصدقاء ومقدمي الرعاية الصحية عن الأعراض التي تعاني منها.
- البحث عن الأعراض الخاصة بك على الإنترنت أو في المقالات الطبية.

- نشر الأعراض الخاصة بك على مواقع الإنترنت للحصول على آراء الآخرين حول هذه الأعراض.
- طلب إجراء الفحوصات أو التقييمات الطبية والآراء الثانية.
- سلوكيات فحص أو طلب تطمين أخرى:

- خذ لحظة للتفكير في عدد المرات التي تقوم فيها بهذه السلوكيات وقم بتسجيل ذلك أدناه. إذا لم تكن متأكدًا، فقد ترغب في إجراء استقصاء صغير لتحديد شدة وتكرار سلوكياتك.
- على سبيل المثال: يمكن أن:
- تطلب من العائلة أو الأصدقاء تدوين ملاحظة في كل مرة تسألهم فيها عن مشكلة صحية خلال فترة محددة.
 - تضع دفتر ملاحظات وقلم رصاص بجوار المرأة وتسجل كل مرة تقوم فيها بفحص نفسك.
 - تراجع يومياتك لمعرفة عدد المواعيد الطبية التي قمت بها في الشهر الماضي.
 - تسجل مقدار الوقت الذي تقضيه على الإنترنت في البحث عن أعراضك.

السلوك

على سبيل المثال: فحص الشامات
الموجودة على ظهري في المرأة

الشدة/ التكرار

مرتين يوميًا

على سبيل المثال: البحث عن
الأعراض على الإنترنت

حوالي ثلاث ساعات في نهاية
كل أسبوع

إذا كنت تتخبط في عديد من هذه السلوكيات، فقد ترغب في اختيار سلوك واحد أو اثنين للعمل عليه/ عليهما أثناء استكمالك لهذه المرحلة. يفضل بعض الأشخاص البدء بتقليل السلوكيات التي لها أكبر تأثير على حياتهم اليومية، في حين يفضل البعض الآخر البدء بتلك السلوكيات التي يشعرون أنه من الأسهل العمل عليها أولاً وبناء ثقتهم بالتدريج، والتعامل مع التغييرات الصعبة لاحقاً.

أي سلوك أو سلوكين من سلوكيات الفحص وطلب التطمين ستعمل عليه/
أو عليهما أولاً؟ سجله أدناه:

١.

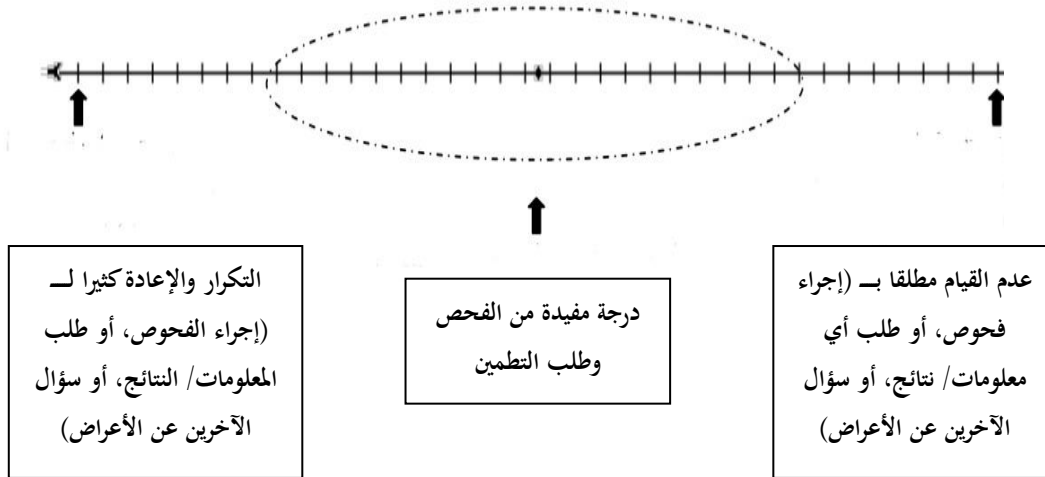
٢.

بمجرد أن تعمل على هذه الأمور لفترة من الوقت، يمكنك بعد ذلك العودة ومعالجة
السلوكيات المتبقية.

الفحص وطلب التطمين المفيدان في مقابل غير المفيدين

من المفيد عمومًا أن نكون على دراية بالتغيرات التي تطرأ على أجسامنا، وفحص أجسامنا بحثًا عن علامات اعتلال في الصحة، وطلب الآراء والمشورة الطبية. فهذه السلوكيات جميعًا تهدف إلى حمايتنا من مشكلات الصحة وتسعي لطول العمر.

متى إذن تصبح هذه السلوكيات مشكلة؟ ما السلوك الذي يُعتبر مبالغًا فيه؟ حسنًا، قد يختلف الأمر من سلوك إلى آخر، ولكن بشكل عام علينا التفكير في سلوكيات الطمأنة الصحية على أنها مُتصل. إذا كانت سلوكياتنا تقع في أي من طرفي المُتصل، فإننا بذلك لا ننخرط في مستويات "صحية" من الفحص وطلب التطمين.



على سبيل المثال، دعونا نفكر في السلوك الصحي للفحوصات الذاتية المنتظمة للثدي. إن السيدة التي لم تقم مطلقاً بإجراء فحص ذاتي للثدي قد تُعرّض نفسها للخطر من خلال عدم إدراكها للتغيرات التي تطرأ على أنسجة الثدي. ومع ذلك، فإن التي تقوم بالفحص يوميًا ربما يؤدي هذا الفحص المتكرر جدًا إلى عدم ملاحظتها أي تغييرات فعلية، ويمكن أن تصاب بعدم الراحة أو الألم بسبب استمرار الضغط والوخز.

لذلك لا يتمثل الهدف من هذه المرحلة في نقلك من أقصى طرف إلى أقصى طرف آخر، من خلال مطالبتك بإلغاء جميع سلوكيات الفحص والبحث عن الاطمئنان، إنما الهدف هو أن تكون قادرًا على تطوير مستويات أكثر فائدة لهذه السلوكيات وتقليل العواقب السلبية المرتبطة بالمستويات المرتفعة من الفحص وطلب التطمين.

إن المستويات المفرطة من الفحص وطلب التطمين قد يكون لها عواقب سلبية متعددة عليك، بالإضافة لتأجيل قلق الصحة. وفيما يلي بعض الأمثلة فقط:

- يمكن أن يؤدي الوخز الجسدي المتكرر إلى زيادة الشعور بالألم أو الحساسية.
- الزيارات الطبية والفحوص قد يكون لها تكاليف مالية كبيرة.

- قد يتم قضاء وقت كبير في الفحص وطلب التطمين بدلاً من الانخراط في الأنشطة التي يمكن أن تمنحك إحساساً بالمتعة أو الإنجاز (على سبيل المثال: العمل، والاجتماعيات).
- قد تتأثر أيضاً علاقاتك مع الأصدقاء والعائلة ومقدمي الرعاية الصحية، فالسعي المستمر للتطمين بجانب عدم وجود إجابات واضحة قد يجعلك أنت والآخرين تشعرين بالإحباط.

خذ لحظة لكتابة أي آثار سلبية لفحصك أو سعيك للتطمين. ماذا تلاحظ؟

هل تُعد هذه السلوكيات شيئاً قد تفكر في تغييره؟

ملاحظة:

في الوحدة التالية، سنتناول سلوكيات التجنب التي يمكن أن تحدث في أقصى الطرف الآخر من هذا المتصل (على سبيل المثال: الأشخاص الذين لم يقوموا مطلقاً بالفحص أو طلب المعلومات/ النتائج، أو لم يسألوا الآخرين أبداً عن أعراضهم).

كيفية تقليل عمليات الفحص والتطمين غير المفيدة

تتمثل إحدى طرق تقليل مستويات الفحص وطلب التطمين لدينا في تقييم مدى فائدة السلوك الحالي، والأخذ في الاعتبار السلوكيات الصحية البديلة واختبارها. نقترح عليك استخدام العملية التالية المكونة من ثلاث خطوات، وورقة العمل الموجودة في آخر هذه المرحلة لمساعدتك في معالجة هذه السلوكيات. لقد تم تصميم ورقة العمل هذه لإرشادك خلال عملية التقييم والتخطيط خطوة بخطوة، مما يسمح لك برؤية مدى فائدة سلوكياتك الحالية بشكل أوضح، وتقييم السلوكيات البديلة والتخطيط لها.

الخطوة ١ - قم بتقييم مدى فائدة سلوكك الحالي المتعلق بالصحة

للقيام بذلك، سوف تحتاج إلى:

- تحديد السلوك المتعلق بالصحة الذي ستبدأ في العمل عليه (على سبيل المثال: فحص ثديي يوميًا بحثًا عن وجود كتل)

ثم اسأل نفسك:

- ما هو الهدف من سلوكي؟
- هل هناك أي مزايا للقيام بهذا السلوك بالتكرار الذي أفعله حاليًا؟
- هل هناك أي عيوب للقيام بهذا السلوك بالتكرار الذي أفعله حاليًا؟
- هل هذا السلوك يحقق فعليًا هدفي؟

- ما مدى معقولية الاستمرار في هذا السلوك؟
- ما مدى معقولية القيام بذلك السلوك بالتكرار الذي أفعله؟
- هل مزايا هذا السلوك تفوق عيوبه؟

يجب أن تمنحك إجابات هذه الأسئلة بعض الأفكار حول مدى فائدة سلوكك الحالي، وما إذا كان ذلك شيئاً تريد الاستمرار في القيام به أو تغييره. ولكن تذكر أن تغيير سلوكك لا يعني بالضرورة التخلص منه! في بعض الأحيان قد يكون من المنطقي تقليل المقدار أو التكرار.

لذا فإن السؤال المهم التالي هو:

هل أحتاج إلى تقليل هذا السلوك أو تأجيله أو القضاء عليه؟ ولماذا؟

تقليل سلوكك أو تأجيله

تأجيل سلوكك يعني إرجاءه حتى وقت لاحق محدد بوضوح. إن تقليل أو تأجيل سلوكك أمر منطقي عندما يكون سلوكك متوافقاً مع النصيحة التي يقدمها المتخصصون الطبيون، لكنك تفعل ذلك:

- بإفراط، أو
- بشكل متكرر، أو
- تفعله في حالة عدم وجود أي أعراض ملحوظة.

على سبيل المثال، غالبًا ما يشجعنا الأطباء الممارسون أن نكون على دراية بالتغيرات في لون وشكل وحجم الشامات. ولكن ضع في اعتبارك الحالة التالية: ... بعد سماع نبأ وفاة صديق قديم له بسبب سرطان الجلد، شعر جيم بالقلق لأنه تجاهل كثيرا متابعة التغيير في شاماته وسيصاب بالسرطان. لذلك بدأ كل يوم في قياس حجم وشكل كل شامة - وأصبح يقضي ما يصل إلى ساعة كل يوم في عمل رسومات مفصلة وملاحظات بخصوص أبعاد كل شامة في جسده. وغالبًا ما كان يتأخر عن العمل نتيجة لذلك.

توصي المنظمة الموثوقة المعنية بالسرطان في استراليا The Cancer Council® of Australia، بفحص جسدك بصريًا مرة كل ثلاثة أشهر تقريبًا بحثًا عن علامات الإصابة بسرطان الجلد، مع ملاحظة أن هذا يجب أن يستغرق حوالي ١٥ دقيقة. كما ترى، يمثل سلوك "جيم" خروجًا كبيرًا عن هذه المعلومات الصحية، لذلك قد يفكر في تقليل أو تأجيل فحصه تدريجيًا حتى يصل إلى المستويات الموصى بها.

التخلص من سلوكك

إن التخلص من سلوكك أمر منطقي عندما يكون سلوكك مخالفًا لنصيحة الأطباء الممارسين. على سبيل المثال، لا يشجع معظم الأطباء استخدام غرف الدردشة على الإنترنت كوسيلة للحصول على المعلومات الصحية؛ نظرًا لمحدودية جودة هذا الشكل من التواصل. وبالمثل، في معظم الحالات، قد يثنيك الأطباء عن الخوض في أي فحص ذاتي ينتج عنه ألم أو انزعاج شديد.

تذكر، إذا لم تكن متأكدًا من أن لديك فهمًا جيدًا للمستويات الموصى بها من سلوكيات الفحص أو طلب التطمين، يمكنك استخدام "قائمة مراجعة تقييم المعلومات الصحية" المذكورة في الوحدة الخامسة^(*) لتقييم أي معلومات تفكر في استخدامها كدليل إرشادي. أو من الأفضل أن تسأل طبيبك عن الإرشادات المناسبة فيما يتعلق بإجراء الفحوصات المعملية والفحص الذاتي.

الخطوة ٢ - وضع هدف سلوكي جديد وتقييمه

بناءً على قرارك بتقليل سلوكك أو تأجيله أو القضاء عليه، ستحتاج إلى:

- وضع هدف سلوكي جديد.
- تحديد ما ستفعله بدقة للعمل نحو تحقيق هذا الهدف.

في بعض الظروف، يمكن بسهولة تحديد الهدف الجديد والسلوكيات المرتبطة به ومحاولة القيام به مباشرة. على سبيل المثال، تخيل أنك كنت تبحث عن "أسباب ارتعاش العضلات" على الإنترنت لمعرفة ما إذا كانت أعراضك طبيعية أو علامة على مرض خطير. قد يكون الهدف البديل هو "تأجيل أي بحث إضافي على الإنترنت"، حيث يمنحك هذا وقتًا لمعرفة ما إذا كانت الأعراض تتطور أو تختفي من تلقاء نفسها. قد يكون السلوك المحدد المرتبط بهذا الهدف هو "سأنتظر أسبوعًا وأرى ما إذا كانت الأعراض التي أعانيها تزداد سوءًا قبل القيام بخطوة إضافية".

(*) إضافة المترجمة: هذه المعلومات مذكورة في الوحدة الخامسة تحت عنوان "وقفة مهمة بشأن الدليل الواقعي".

ومع ذلك، في بعض الأحيان قد يكون الحد من سلوكيات معينة أو القضاء عليها أمراً يحتاج إلى القيام به بشكل تدريجي. على سبيل المثال، إذا كان على "جيم" تحديد هدف فوري بأن عليه "فحص الشامات بصرياً، مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر لمدة خمس عشرة دقيقة وفقاً لتوصيات مجلس السرطان"، فمن المحتمل أن يكون تطبيق ذلك صعباً للغاية على الفور. وبدلاً من ذلك، يمكنه تقسيم هدفه إلى خطوات أصغر، والعمل تدريجياً نحو الوصول لمستوى الفحص الموصى به.

ولإجراء تقليل تدريجي في سلوك معين، نوصيك باستخدام درجات السلم (المدرج) لمساعدتك.

(١) حدد هدفك العام ، و (٢) حدد الخطوات التدريجية اللازمة للعمل نحو تحقيق هدفك العام.

تعطيك كل خطوة على المدرج شعوراً بـ "الكرب" بين ٠ و ١٠٠، حيث ٠ = هذه الخطوة لا تثير الكرب على الإطلاق، و ١٠٠ = هذه الخطوة مثيرة للكرب بشدة. قد يشتمل سلمك على خطوات "بينية" أقل أو أكثر من المثال الوارد أدناه، ولكن الفكرة هي أن تصمم خطوات تدريجية لهدفك العام بطريقة قابلة للتحقيق. وهذا مثال لمدرج "جيم":

مدّج "جيم"

الهدف: فحص الشامات بصرياً، مرة واحدة فقط كل ثلاثة أشهر لمدة خمس عشرة دقيقة، وفقاً لتوصيات المنظمة المعنية بالسرطان.	الكرب (٠ : ١٠٠) ١٥
---	-----------------------

الخطوة	الكرب
١ فحص الشامات بصرياً (بدون رسم أو كتابة ملاحظات) كل يوم لمدة ٣٠ دقيقة فقط.	٢٥
٢ فحص الشامات بصرياً (بدون رسم أو كتابة ملاحظات) كل يومين لمدة ٢٠ دقيقة فقط.	٣٥
٣ فحص الشامات بصرياً (بدون رسم أو كتابة ملاحظات) كل ٤ أيام لمدة ٢٠ دقيقة فقط.	٤٥
٤ فحص الشامات بصرياً (بدون رسم أو كتابة ملاحظات) مرة أسبوعياً لمدة ٢٠ دقيقة فقط.	٥٥
٥ فحص الشامات بصرياً (بدون رسم أو كتابة ملاحظات) مرة كل أسبوعين لمدة ١٥ دقيقة فقط.	٦٥
٦ فحص الشامات بصرياً (بدون رسم أو كتابة ملاحظات) مرة كل شهر لمدة ١٥ دقيقة فقط.	٧٠
٧ فحص الشامات بصرياً (بدون رسم أو كتابة ملاحظات) مرة كل شهرين لمدة ١٥ دقيقة فقط.	٧٥
٨ فحص الشامات بصرياً (بدون رسم أو كتابة ملاحظات) مرة كل ٣ شهور لمدة ١٥ دقيقة فقط.	٨٥

إذا كنت بحاجة إلى تقسيم هدفك العام إلى خطوات أكثر قابلية للتطبيق، فيمكنك استخدام المدرج أدناه للقيام بذلك:

المدرج الخاص بي

الهدف:	الكرب (٠ : ١٠٠)
--------	-----------------

الخطوة	الكرب
١	
٢	
٣	
٤	
٥	
٦	
٧	
٨	

بمجرد تحديد هدفك السلوكي الجديد وما الذي ستفعله بدقة لتحقيق هذا الهدف، عليك أن تسأل نفسك:

- ما هو الهدف من هذا السلوك الجديد؟
 - هل هناك أي مزايا لفعل هذا السلوك الجديد بالتكرار الذي خططت له؟
 - هل هناك أي عيوب لفعل هذا السلوك الجديد بالتكرار الذي خططت له؟
 - في هذه المرحلة، ما مدى منطقية تجربة هذا السلوك الصحي البديل؟
- يجب الآن أن تكون كوّنت فكرة جيدة حول فائدة سلوكك الجديد، ونأمل أن تتجه خطواتك التدريجية نحو تجربة هذا السلوك الجديد. ومع ذلك، قد لا يكون القيام بذلك سهلاً! علينا أن نتوقع أننا سنشعر ببعض الضيق أثناء القيام بهذه الأشياء. فإذا كانت سهلة من البداية، لكنت فعلتها بالفعل من قبل! لذلك سوف تحتاج إلى مراعاة ما يلي:

• كيف سأتعامل مع أي قلق أو هم؟ ماذا سأقول لنفسي؟ ماذا سأفعل؟

في حين أن هناك عديداً من الأشياء التي يمكنك وضعها في الاعتبار هنا -لاسيما ما تم استخلاصه بالفعل من المرحلة الرابعة "تقليل التركيز على الأعراض والمخاوف الصحية"- فإليك موجزٌ لبعض الأفكار التي أقرّ أشخاص آخرون بأنها مفيدة:

- تذكير نفسك بأن "هذا القلق سوف يمر، ولن يستمر إلى الأبد".
- تذكير نفسك أن جسدك مثل سيارة قديمة، وسيجري في بعض الأحيان بخشونة، وليس كل صرير أو صوت يحتاج إلى إصلاح شامل للمحرك.

- تذكير نفسك أنك إذا قمت بالفحص أو طلب التطمين، فقد يخفف ذلك من بعض القلق على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل سيؤدي لاستمرار القلق (مثل: حلقة التطمين المفرغة).
- النظر إلى هذا على أنه تدريب جيد لتعلم التحمل والتقبل بأن صحتك لا يمكن أن يكون لها ضمان بنسبة ١٠٠٪ (تماماً مثل أي شخص آخر).
- استخدام تمارين الاسترخاء للسيطرة على التوتر.
- استخدام تمارين الانتباه المذكورة في المرحلة الرابعة لجذب انتباهك مرة أخرى إلى الحاضر، بدلاً من الاستمرار في التركيز على الأعراض والمخاوف الصحية.
- التخطيط لشيء مرح أو ممتع كمكافأة للقيام بأي خطوة صعبة.

الخطوة ٣ - تجربة السلوك الجديد

- إذا كنت قد قمت بالخطوتين ١ و ٢، فأنت الآن مستعدٌ للانخراط في سلوكك الجديد. حان الوقت الآن للقيام بذلك !! ثم...
- إذا كنت قادراً على فعل ما خططت له، فاسأل نفسك:
- ماذا اكتشفت في نفسك؟
 - ماذا اكتشفت في سلوكياتك الأصلية والجديدة؟

إذا لم تكن قادراً على فعل ما خططت له، فلا تقلق، قد يكون السبب أنك حددت مهمة شديدة الصعوبة لتنفيذها على الفور، أو أن دافعك قد انخفض قليلاً (أو كثيراً!) بمجرد مواجهة القلق والضيق الذي غالباً ما يصاحب كسر دائرة الطمأنينة.

لذلك، إذا واجهتك مشكلة في إكمال أي خطوة ، فننصحك بما يلي:

(١) ارجع إلى الخطوتين ١ و ٢ وأعد تقييم مزايا وعيوب سلوكياتك الأصلية وسلوكياتك الجديدة؟ بشكل عام، هل تجد من المنطقي المضي قدماً في السلوك الجديد؟ حاول التركيز على عيوب السلوك القديم ومزايا السلوك الجديد.

أو

(٢) قسم هدفك السلوكي الجديد في الخطوة ٢ إلى خطوات أكثر قابلية للتنفيذ باستخدام خطوات المدرّج.

لا تنس أيضاً أنه من الطبيعي أن تشعر ببعض الكرب أثناء تجربة هذه السلوكيات الجديدة، وأن تغيير سلوكك يشبه إلى حد ما ركوب الدراجة، فهو يتطلب التشجيع وغالباً ما يحتاج الأمر إلى كثير من التكرار قبل أن يصبح أقل إثارة للقلق وأكثر اعتيادية.

في الصفحتين التاليتين، توجد أمثلة على كيفية إكمال "ورقة عمل تقليل الفحص وطلب التطمين". يوضح المثال الأول سلوك سيدة كانت تقوم بفحص ثديها بشكل يومي بحثاً عن علامات الإصابة بسرطان الثدي. ويوضح المثال الثاني سلوك رجل كان يبحث عن أعراضه على الإنترنت. بعد أن قرأ هذين المثالين، هناك ورقة عمل فارغة لتقوم بتجربتها على سلوك الفحص أو طلب التطمين الخاص بك.

تقليل الفحص وطلب التطمين – مثال ١

الخطوة ١: تقييم مدى فائدة سلوكك الحالي

السلوك: فحص ثديي يوميًا بحثًا عن وجود كتل	
مزايا هذا السلوك	عيوب هذا السلوك
ما الهدف من سلوكي؟ هل هناك أي مزايا للقيام بهذا السلوك بالتردد الذي أفعله حاليًا؟ - لن أفوت أي كتلة إذا كانت موجودة. - إذا كانت هناك مشكلة؛ سألتقطها مبكرًا.	هل هناك أي عيوب للقيام بهذا السلوك بالتردد الذي أفعله حاليًا؟ هل هذا السلوك يحقق هدفي حقًا؟ - الفحص اليومي يُبقي ذهني متركزًا على احتمالية الإصابة بسرطان الثدي - والانشغال بهذا الأمر ليس شيئًا جيدًا. - الفحص اليومي لا يُعد ضمانًا بنسبة ١٠٠٪. لا يزال من الممكن تفويت شيء ما. - الفحص اليومي يجعل من الصعب ملاحظة وجود شيء جديد أو متغير. - في بعض الأحيان يجعل ثديي يؤلماني مما يزيد شعوري بالقلق من وجود مشكلة ما.

عند هذه المرحلة، ما مدى منطقية الاستمرار في اتباع هذا السلوك؟ ما مدى منطقية أن أفعل السلوك بالتكرار الذي أقوم به الآن؟ هل مزايا هذا السلوك تفوق مساوئه؟

- فحص ثديي أمر جيد. حتى أن طبيبي قال أنه يجب أن يكون على علم بأي تغييرات تحدث. لكن القيام بذلك كل يوم يجعلني أشعر بالألم وربما يجعل من الصعب ملاحظة أي مشكلات حقيقية.

هل أحتاج إلى تقليل هذا السلوك أو تأجيله أو القضاء عليه؟ لماذا؟

- أحتاج إلى تقليل مقدار الفحوص التي أجريها، حيث قال طبيبي إنه ليس من الضروري الفحص بالتكرار الذي أقوم به، وأن الفحوصات المتكررة تجعلني أشعر بالألم.

الخطوة ٢: وضع هدف سلوكي جديد وتقييمه

الهدف السلوكي الجديد: فحص ثديي مرة شهرياً	
ما الذي سأفعله على وجه التحديد؟ هل سأفعل ذلك على الفور أم بشكل تدريجي؟ سوف أقوم بفحص ثديي مرة واحدة فقط في الشهر. أعتقد أنه يمكنني أن أبدأ هذا على الفور، لذا سأجربه.	
مزايا هذا السلوك ما الهدف من هذا السلوك الجديد؟ هل هناك أي مزايا للقيام به بالتكرار الذي خططت له؟ سأظل قادرة على التقاط التغييرات التي تحدث.	مساوئ هذا السلوك هل هناك أي عيوب للقيام بهذا السلوك الجديد بالتكرار الذي خططت له؟ ستظل هناك أوقات أشعر فيها بالقلق بشأن سرطان الثدي.

إخبار نفسي بأنني لا أستطيع الفحص حتى وقت لاحق سيجعلني أشعر بعدم الارتياح لبعض الوقت.	لن يؤلمني ثديي - وقد يساعدني ذلك في ملاحظة ما إذا كان هناك ألم حقيقي، بدلاً من الألم الذي أحدثته من خلال الفحص الذي كنت أقوم به. لن أقضي كثيراً من الوقت في التفكير في سرطان الثدي. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الفحص، لكان طبيبي شجعتني على ما كنت أفعله من قبل.
عند هذه المرحلة، ما مدى منطقية تجربة هذا السلوك الصحي الجديد؟ أستطيع أن أرى أن هناك كثيراً من الأسباب لتجربة السلوك الجديد، وسيسعد طبيبي إذا كان بإمكانه تقليل الفحص.	
كيف سأتعامل مع أي هم وقلق؟ ماذا سأقول لنفسي؟ ماذا سأفعل؟ سأذكر نفسي بأنني لم أترك الفحص تماماً، ومن غير المرجح أن يفوتني أي شيء إذا واصلت الفحص مرة شهرياً. سأستخدم تمارين التأمل باستمرار للتعامل مع أي مخاوف تظهر.	

الخطوة ٣: تجربة السلوك الجديد

هل كنت قادراً على فعل ما خططت له؟
"نعم" ماذا اكتشفت في نفسي؟ ماذا اكتشفت في سلوكياتي الأصلية والجديدة؟ لقد وجدت صعوبة في عدم الفحص كل يوم لأنها أصبحت عادة. كان الأسبوعان الأولان شديدي الصعوبة، وسرعان ما راجعت بضع مرات إضافية. كان شيء جيد أن تلافيت

الألم الذي كان ينتج عن الضغط والوخز المستمر. أشعر أنني الآن في وضع أفضل
لملاحظة أي تغييرات حقيقية.

"لا"

قد أحتاج إلى:

١. العودة إلى الخطوتين ١ و ٢ لإعادة تقييم مزايا وعيوب سلوكياتي الأصلية والجديدة.

أو

٢. تقسيم هدفي الجديد في الخطوة ٢ إلى خطوات أكثر قابلية للتنفيذ باستخدام خطوات

المدرج

تقليل الفحص وطلب التطمين – مثال ٢

الخطوة ١: تقييم مدى فائدة سلوكك الحالي

السلوك: البحث عن أي أعراض جديدة على الانترنت	
مزايا هذا السلوك	عيوب هذا السلوك
- ما الهدف من سلوكي؟ هل هناك أي مزايا للقيام بهذا السلوك بالتردد الذي أفعله حالياً؟ - يمكنني معرفة ما إذا كانت أعراضتي طبيعية. - يمكنني الوصول إلى معلومات قد لا يعرفها طبيبي. - يمكنني الحصول على معلومات فورية بدلاً من انتظار موعد مع طبيبي.	- هل هناك أي عيوب للقيام بهذا السلوك بالتردد الذي أفعله حالياً؟ هل هذا السلوك يحقق هدفي حقاً؟ - لقد أمضيت وقتاً طويلاً في البحث عن أعراض انتهى بها الأمر إلى كونها غير ضارة، واختفت. - عندما أبحث عن أحد الأعراض، أحصل أحياناً على معلومات حول بعض المشكلات الصحية المخيفة بشكل خطير، مما يجعلني أشعر بمزيد من القلق. - حتى لو وجدت تطابقاً مع أعراضتي، فعادةً لا يمكن تأكيد ذلك حتى يجري طبيبي بعض الفحوص.

عند هذه المرحلة، ما مدى منطقية الاستمرار في اتباع هذا السلوك؟ ما مدى منطقية أن أفعله بالتكرار الذي أقوم به الآن؟ هل مزايا هذا السلوك تفوق مساوئه؟

بينما يمكنني الوصول بسرعة إلى كثير من المعلومات حول أعراضني الصحية على الإنترنت، لا يمكنني أبداً التأكد من أنني على الطريق الصحيح. وقد ينتهي بي الأمر بالقلق بشأن أعراض طبيعية.

هل أحتاج إلى تقليل هذا السلوك أو تأجيله أو القضاء عليه؟ لماذا؟

ربما لا يساعدني ذلك مطلقاً على معرفة ما إذا كانت لدي مشكلة بالفعل. إنه فقط يجعلني أكثر قلقاً. ربما ينبغي علي القضاء على هذا السلوك.

الخطوة ٢: وضع هدف سلوكي جديد وتقييمه

الهدف السلوكي الجديد: عدم استخدام الإنترنت للبحث عن أعراضني.	
ما الذي سأفعله على وجه التحديد؟ هل سأفعل ذلك على الفور أم بشكل تدريجي؟ سأتوقف عن استخدام الإنترنت للبحث عن تفسيرات لأعراضني.	
مزايا هذا السلوك	مساوئ هذا السلوك
ما الهدف من هذا السلوك الجديد؟ هل هناك أي مزايا للقيام به بالتكرار الذي خططت له؟ لن أترك نفسي أشعر بالقلق من الأمراض غير المتوقعة والمخيفة. لن أضيع الوقت في البحث عن الأعراض التي قد تكون طبيعية.	هل هناك أي عيوب للقيام بهذا السلوك الجديد بالتكرار الذي خططت له؟ لا أعرف ماذا سأفعل مع نفسي. لقد قضيت كثيراً من الوقت في إجراء هذا البحث في الماضي. سأفكر في طريقة أخرى لشغل وقتي.

عند هذه المرحلة، ما مدى منطقية تجربة هذا السلوك الصحي الجديد؟ أستطيع أن أرى أن بحثي على الإنترنت يجعلني أكثر قلقًا بشأن صحتي.
كيف سأتعامل مع أي هم وقلق؟ ماذا سأقول لنفسي؟ ماذا سأفعل؟ سألصق ملاحظة تذكير على جهاز الكمبيوتر الخاص بي بأن البحث عن الأعراض التي أعانيها يجعلني أشعر بالسوء. سوف أذكّر نفسي أن الرغبة في التحقق ستزول مع مرور الوقت – وأن عليّ فقط أن أتحري من هذه الرغبة. سوف أخرج من المنزل وأذهب للتمشية في نزهة للتخلص من إغراء البحث.

الخطوة ٣: تجربة السلوك الجديد

هل كنت قادرًا على فعل ما خططت له؟
"نعم" ماذا اكتشفت في نفسي؟ ماذا اكتشفت في سلوكياتي الأصلية والجديدة؟ عندما أوقفت البحث عن أعراض على الإنترنت، كنت في الواقع أقل تركيزًا على صحتي بشكل عام. في البداية كان من الصعب جدًا عدم البحث لأن جهاز الكمبيوتر ليس بعيدًا عني. كان عليّ أن أذكّر نفسي باستمرار أن الرغبة في البحث ستنتهي. أعتقد أنه سيكون من المفيد الاستمرار في هذا التغيير.
"لا"

قد أحتاج إلى:

١. العودة إلى الخطوتين ١ و ٢ لإعادة تقييم مزايا و عيوب سلوكياتي الأصلية والجديدة.

أو

٢. تقسيم هدفي الجديد في الخطوة ٢ إلى خطوات أكثر قابلية للتنفيذ باستخدام خطوات المدرج

ورقة العمل الخاصة بتقليل الفحص وطلب التطمين

الخطوة ١ : تقييم مدى فائدة سلوكك الحالي

السلوك:	
عيوب هذا السلوك هل هناك أي عيوب للقيام بهذا السلوك بالتكرار الذي أفعله حالياً؟ هل هذا السلوك يحقق هدفي حقاً؟	مزايا هذا السلوك ما الهدف من سلوكي؟ هل هناك أي مزايا للقيام بهذا السلوك بالتكرار الذي أفعله حالياً؟
عند هذه المرحلة، ما مدى منطقية الاستمرار في اتباع هذا السلوك؟ ما مدى منطقية أن أفعله بالتكرار الذي أقوم به الآن؟ هل مزايا هذا السلوك تفوق مساوئه؟	

هل أحتاج إلى تقليل هذا السلوك أو تأجيله أو القضاء عليه؟ لماذا؟

الخطوة ٢: وضع هدف سلوكي جديد وتقييمه

الهدف السلوكي الجديد:

ما الذي سأفعله على وجه التحديد؟ هل سأفعل ذلك على الفور أم بشكل تدريجي؟

مزايا هذا السلوك	مساوئ هذا السلوك
ما الهدف من هذا السلوك الجديد؟ هل هناك أي مزايا للقيام به بالتكرار الذي خططت له؟	هل هناك أي عيوب للقيام بهذا السلوك الجديد بالتكرار الذي خططت له؟
عند هذه المرحلة، ما مدى منطقية تجربة هذا السلوك الصحي الجديد؟	

كيف سأتعامل مع أي هم وقلق؟ ماذا سأقول لنفسي؟ ماذا سأفعل؟

الخطوة ٣: تجربة السلوك الجديد

هل كنت قادرًا على فعل ما خططت له؟

"نعم"

ماذا اكتشفت في نفسي؟ ماذا اكتشفت في سلوكياتي الأصلية والجديدة؟

"لا"

قد أحتاج إلى:

١. العودة إلى الخطوتين ١ و ٢ لإعادة تقييم مزايا وعيوب سلوكياتي الأصلية والجديدة.

أو

٢. تقسيم هدفي الجديد في الخطوة ٢ إلى خطوات أكثر قابلية للتنفيذ باستخدام خطوات

المدرج

ملخص المرحلة السادسة

- سينخرط معظمنا في سلوكيات فحص وطلب تطمين تتعلق بالصحة. إننا نقوم بذلك لتقليل قلقنا، ولزيادة إحساسنا بالسيطرة واليقين بشأن صحتنا، ولطمأنة أنفسنا بأن صحتنا ليست في خطر.
- قد يوفر الفحص وطلب التطمين إحساسًا بالراحة أو السيطرة على المدى القصير. ومع ذلك، على المدى الطويل، لا يمكننا أبدًا التأكد من أننا بصحة جيدة بنسبة ١٠٠٪، لذلك يستمر قلقنا وحاجتنا للفحص وطلب الطمأنينة في حلقة مفرغة.
- كلما قمنا بالفحص أكثر وطلبنا التطمين أكثر؛ قلت الفرص المتاحة أمامنا لممارسة تحمل وتقبل أن صحتنا لا يمكن أن يكون لها ضمان بنسبة ١٠٠٪ (تمامًا مثل أي شخص آخر).
- سلوكيات الفحص وطلب التطمين تقع على متصل، كلٌّ من الدرجة المرتفعة جدًا منها والقليل جدًا منها غير مفيد وغير صحي.
- المستويات المفرطة من الفحص والتطمين لها مجموعة من النتائج السلبية، بما في ذلك: زيادة الألم أو الحساسية، وزيادة التكاليف المالية، وتقليل الوقت الذي يقضيه الفرد في الاستمتاع أو المهام المتعلقة بالإنجاز (مثل: الاجتماعيات والعمل)، وصعوبات العلاقة.
- تتمثل إحدى طرق التغلب على المستويات المفرطة من البحث عن التطمين في تقييم واختبار سلوكيات صحية جديدة تنطوي على تقليل الفحص الحالي وطلب التطمين أو تأجيلهما أو إلغائهما.

• من الطبيعي أن تشعر ببعض الضيق أثناء تجربة سلوكيات صحية جديدة وتقليل الفحص وطلب التطمين. إذا وجدت الأمور صعبة، فاستخدم خطوات المدرج لتقسيم هدفك السلوكي الجديد إلى خطوات أصغر وأكثر قابلية للتنفيذ.

التالي ...

في المرحلة التالية، سنبدأ في استكشاف طرق لتقليل سلوكيات التجنب.

Helping Health Anxiety

About The Modules

CONTRIBUTORS

Dr Rebecca Anderson (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

Paula Nathan (MPsych¹)
Centre for Clinical Interventions

Dr Lisa Saulsman (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

¹Masters of Psychology (Clinical Psychology)

²Doctor of Philosophy (Clinical Psychology)

BACKGROUND

The concepts and strategies in these modules have been developed from evidence based psychological practice, primarily Cognitive-Behaviour Therapy (CBT). CBT for health anxiety is based on the approach that health anxiety is a result of problematic cognitions (thoughts) and behaviours.

REFERENCES

These are some of the professional references used to create the modules in this information package.

Abramowitz, J., Taylor, S., & McKay, D. (2010). Hypochondriasis and severe health anxiety. In McKay, D., Abramowitz, J., S., & Taylor, S. (Eds.). *Cognitive-behavior therapy: Turning failure into success* (pp. 327-346). Washington, DC: American Psychological Association.

Asmundson, G., & Taylor, S. (2005). *It's not all in your head: How worrying about your health could be making you sick – and what you can do about it*. New York: The Guilford Press.

Furer, P., & Walker, J. (2006). *Health anxiety treatment manual*. University of Manitoba: Manitoba.

Furer, P., Walker, J., & Stein, M. (2007). *Treating health anxiety and fear of death*. New York: Springer.

Papageorgiou, C., & Wells, A. (1998). Effects of attention training on hypochondriasis: A brief case series. *Psychological Medicine*, 28, 193-200.

Salkovskis, P., Warwick, H., & Deale, A. (2003). Cognitive-behavioural treatment for severe and persistent health anxiety (Hypochondriasis). *Brief Treatment and Crisis Intervention*, 3, 353-367.

Willson, R., & Veale, D. (2009). *Overcoming health anxiety: A self-help guide using cognitive behavioural techniques*. London: Robinson.

“HELPING HEALTH ANXIETY”

This module forms part of:

Anderson, R., Saulsman, L., & Nathan, P. (2011). *Helping Health Anxiety*. Perth, Western Australia: Centre for Clinical Interventions.

ISBN: 0 9757995 6 8

Created: August 2011

المرحلة السابعة

تحدي التجنب وسلوكيات الأمان

- ١- مقدمة
- ٢- ما هو التجنب وسلوكيات الأمان؟
- ٣- التعرض التدريجي
- ٤- التجنب وسلوكيات الأمان الخاصة بي
- ٥- التخطيط لأهدافك
- ٦- بناء المدرج
 - خطوات مدرج التعرض - مثال
 - خطوات مدرج التعرض - ورقة العمل
- ٧- اتخاذ خطوة
- ٨- صعود خطوات المدرج
- ٩- ملخص المرحلة
- ١٠- حول المراحل

مقدمة

أوضحنا في المرحلة السادسة أن السلوكيات المتعلقة بالصحة تقع على متصل، وقد يكون الكثير جداً أو القليل جداً من هذه السلوكيات غير مفيد لنا. وفي الوقت الذي قدمت فيه المرحلة السادسة السلوكيات التي قد نقوم بها كثيراً، فإن هذه المرحلة سوف تكشف عن السلوكيات التي قد نتجنبها أو نؤجلها بسبب مشاعر القلق. في المرحلة الثالثة، قدمنا مفهوم التجنب وسلوكيات الأمان، وفي هذه المرحلة سنعيد النظر في الأنواع الشائعة للتجنب وسلوكيات الأمان، وسنقدم طريقة للبدء تدريجياً في تحدي هذه السلوكيات والتغلب عليها.

ما هو التجنب وسلوكيات الأمان؟

عندما نشعر بالقلق بشأن صحتنا أو نتوقع الشعور بالقلق، فإننا غالبًا ما نتصرف بإحدى طريقتين لمحاولة السيطرة على قلقنا: تتمثل أولاهما في الانخراط في **التجنب**، حيث نبتعد عن تلك المواقف أو الأنشطة التي نربطها بالأمراض المخيفة أو التي تذكرنا بالموت. ويمكن أن يشمل ذلك:

- تجنب أشخاص (على سبيل المثال: الطاقم الطبي أو الأصدقاء أو الأقارب المرضى) أو
- تجنب أماكن (على سبيل المثال: المستشفيات، والحمامات العامة، دور الجنائز)، أو
- تجنب أنشطة (على سبيل المثال: حضور المواعيد الطبية، والتفكير في الموت، وكتابة وصية)

ونظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة يميلون إلى القلق أكثر من المعتاد بشأن الأعراض الجسدية في أجسامهم، فقد يتجنبون أيضًا الأنشطة التي تُحدث تغييرات في حالتهم الفسيولوجية (على سبيل المثال: ممارسة الرياضة، وممارسة الجنس، وتناول الأطعمة الغنية بالتوابل، وشرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين).

وتتمثل الطريقة الثانية في الانخراط في سلوكيات الأمان. فقد لا نتجنب موقفًا أو نشاطًا تمامًا، لكننا لن نقوم به إلا إذا تم اتخاذ احتياطات معينة. على سبيل المثال، يمكن للشخص الذي يخشى الإصابة بمرض ما أن يزور صديقًا مصابًا بمرض غير معدٍ إذا كان فقط يأخذ كورسا وقائيا من المضادات الحيوية، ويخطط لتقليل ملامسة الأشياء داخل منزل الصديق. وغالبًا ما يُنظر إلى سلوكيات الأمان على أنها نوع خفي من التجنب، لأنك لا تختبر مخاوفك ولا تتخبط في الموقف بشكل كامل.

قد يؤدي تجنب المواقف أو الأنشطة، أو استخدام سلوكيات الأمان عند التعامل مع هذه المواقف، إلى تقليل القلق الذي نشعر به على المدى القصير، ولكن من المحتمل أن يكون لذلك بعض الآثار غير المفيدة طويلة المدى. فعلى المدى الطويل، ستستمر همومنا ومخاوفنا الصحية، لأننا لم نمح أنفسنا الفرصة لمواجهة مخاوفنا ورؤية كيف تسير الأمور فعليًا. سنشعر أيضًا بالحاجة إلى استمرار استخدام التجنب و/ أو سلوكيات الأمان، لأننا لم نتعلم ما إذا كان بإمكاننا البقاء على قيد الحياة بدونها. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي استخدام التجنب وسلوكيات الأمان إلى استفاد إحساسنا بالثقة بالنفس، وقد تمنعنا هذه السلوكيات أيضًا من القيام بأشياء نرغب في القيام بها، مما يؤدي إلى حياة مقيدة وغير مرضية للغاية.

في النهاية، إذا كنت تريد التغلب على قلق الصحة ستحتاج إلى مواجهة مخاوفك وتحديها. في البداية قد يبدو التغلب على المخاوف التي تدفعك إلى

التجنب وسلوكيات الأمان أمرًا شاقًا. قد يشجعك بعض الأشخاص على مواجهة أكبر مخاوفك منذ الخطوة الأولى - "القفز إلى أقصى نقطة" وإنهاء الأمر. ومع ذلك، إذا حاولت معالجة أكبر مخاوفك على الفور، فقد ينتهي بك الأمر إلى الإرهاق، وقد يجعلك أكثر قلقًا مما كنت عليه عندما بدأت. لذلك يفضل كثير من الناس أن يأخذوا الأمر خطوة بخطوة، مثل صعود الدّرج. نحن نطلق على نهج صعود الدّرج هذا "التعرض التدريجي".

التعرض التدريجي

يتكون التعرض التدريجي من التعرض المنظم والمتكرر لمواقف أو أنشطة تثير القلق، يتم تقديمها بمستويات من الصعوبة، بدءًا من الموقف أو النشاط الذي يثير أقل قدر من القلق، ثم الانتقال نحو المواقف الأكثر تحديًا. **هناك عدد من الفوائد للانخراط في التعرض:**

- **يمنحك التعرض الفرصة لتحدي مخاوفك باستمرار.** فالأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة غالبًا ما يبالغون في تقدير احتمال إصابتهم بمشكلة صحية خطيرة حاليًا أو توقع الإصابة بها فيما بعد، ويقللون من قدرتهم على التعامل مع هذه المشكلات الصحية. يمنحك التعرض الفرصة لمواجهة مخاوفك من هذا المرض المحتمل، ومن خلال القيام بذلك ستقوم بتطوير تقييمات أكثر واقعية لاحتمال الإصابة بالمرض الخطير، وقدراتك الحقيقية على التأقلم.
- **يمنحك التعرض فرصة للتعود على أحاسيس القلق.** بينما تشعر بعدم الراحة على المدى القصير عندما تخبر مشاعر القلق، فإنك على المدى الطويل ستشعر بمزيد من التحكم في قلقك. ومن خلال تعرضك عمدًا لمشاعر القلق باستمرار، ستصبح أكثر تحملاً لها وأقل انزعاجاً منها.

- **يمنحك التعرض الفرصة لاستخدام مهاراتك.** عندما تواجه المواقف والأنشطة المخيفة بشكل متكرر، ستعتاد عليها بشكل تدريجي. إن الشعور بالراحة في هذه المواقف ليس فوريًا، وإنما تحتاج إلى البقاء في الموقف لفترة كافية حتى يُعَدِّل جسمك درجة القلق ويُخَفِّضه. بعد ذلك يمكنك استخدام الاستراتيجيات التي تعلمتها حتى الآن لمساعدتك على التعامل مع الأفكار والمشاعر المقلقة (على سبيل المثال: استخدام يوميات الأفكار لتحدي الأفكار غير المفيدة المتعلقة بالصحة).

- **يمنحك التعرض الفرصة لتحسين ثقتك بنفسك.** إذا كنت تخطط لهذه الخطوات بعناية، فسوف تبني ثقتك بنفسك، وسيتيح لك ذلك اتخاذ مزيد من الخطوات إلى الأمام. ومع زيادة الثقة، تزداد إمكانية مواجهتك لـ"مخاوفك" الأخرى.

التجنب وسلوكيات الأمان الخاصة بي

تتمثل الخطوة الأولى نحو التعرض التدريجي في تحديد المواقف والأنشطة التي تميل إلى تجنبها، أو أي سلوكيات أمان تقوم بها.

يمكنك الرجوع إلى المرحلة الثالثة، وربما تكون قد أدرجت بالفعل بعض أشكال التجنب وسلوكيات الأمان الخاصة بك. وإذا كنت بدأت العمل في يوميات الأفكار، ربما تكون قد ذكرت بعض المواقف التي شعرت بالقلق حيالها وتجنبتها، أو التي استخدمت فيها سلوكيات الأمان للتعامل معها، لذلك قد يكون من المفيد النظر في تلك المواقف.

لقد قدمنا لمساعدتك بعض الأمثلة على المواقف والأنشطة التي غالبًا ما تسبب الضيق للأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة، فإذا رأيت أيا منها مألوفًا لك؛ فيمكنك إعادة صياغتها في قائمة "التجنب وسلوكيات الأمان الخاصة بي"، بحيث تكون معبرة عنك أكثر.

تأكد من أنك فكّرت في كل سلوكيات الأمان المحتملة، ولاحظ أن بعضها قد يكون خفيًا (على سبيل المثال: حمل الأدوية "احتياطيًا"، وحمل الهاتف المحمول حتى تتمكن من الاتصال لطلب المساعدة). تأكد أيضًا من تضمينك

تلك الأنشطة التي تتجنبها لأنها قد تجلب لك أحاسيس جسدية مخيفة، مثل ممارسة الرياضة أو تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، إذا كان ذلك ينطبق عليك.

ستحتاج أيضًا أن تأخذ في اعتبارك ما إذا كنت تتجنب التفكير في المرض أو الموت، فمن الشائع جدًا أن يحاول الأشخاص الذين يعانون من قلق الصحة تجنب التفكير في تلك الأشياء التي يخافون منها كثيرًا، خاصة أفكار الموت والفناء. ويُعرف هذا بـ "كبح الأفكار". ولسوء الحظ، فإن محاولة عدم التفكير في شيء قد يكون له تأثير معاكس من خلال جعلنا نفكر فيه أكثر!

هل تتذكر في المرحلة الرابعة عندما طلبنا منك محاولة عدم التفكير في فيل وردي لمدة ٦٠ ثانية؟ هل تتذكر إلى أي مدى استطعت ذلك؟ إذا لم تكن قمت بتلك المحاولة، فقد ترغب في القيام بها الآن لترى مدى إمكان فعل ذلك. بشكل عام، يجد معظم الناس أنه كلما حاولوا عدم التفكير في شيء ما، كلما مالت عقولهم إلى التفكير فيه. إذا كان هذا النوع من التجنب مألوفًا لك، فقم بتسجيل الأشياء التي تتجنب التفكير فيها في قائمتك أيضًا.

الأشخاص والأماكن والأنشطة التي يتم تجنبها بشكل شائع لدى من يعاني من قلق الصحة:

- المتخصصون في المجال الطبي
- المواعيد الطبية
- استخدام الحمامات العامة

- المرور بـأماكن إقامة الجنازات
- كتابة الوصية
- الاتصال الهاتفي لمعرفة نتائج فحص ما
- تناول أطعمة قريبة من تاريخ انتهاء صلاحيتها
- الفحوصات الطبية أو المتابعة
- مشاهدة الأخبار أو قراءة الصحف
- زيارة قريب كان مريضاً مؤخراً
- مغادرة المنزل بدون أدوية أو هاتف جوال "حيث كان يأخذهم احتياطياً لربما يحدث شيء ما"
- التفكير في جنازتي
- مشاهدة الأعمال الدرامية الطبية على شاشة التلفزيون
- قراءة المعلومات التي قدمها الطبيب
- التمارين الرياضية
- صعود الدَرَج
- شرب القهوة
- ممارسة الجنس
- تناول الأطعمة الحارة
- شرب المشروبات الغازية
- زيارة صديق مصاب بمرض غير معدٍ
- قراءة نعي الوفيات

- الخروج في الأماكن العامة بدون معقم لليدين
- تناول دواء وصفه الطبيب لي
- إخبار الطبيب بأعراضه
- التفكير في كيفية تعامل الآخرين مع موتى

خذ لحظة لتسجيل الأمثلة الخاصة بك أدناه:

التجنب وسلوكيات الأمان الخاصة بي

الآن بعد أن حددت عددًا من المواقف التي تخافها وتتجنبها، كيف تبني خطوات المدرّج لتحقيق ما تريد الوصول إليه؟ دعنا أولاً نلقي نظرة على الهدف النهائي الذي تريد الوصول إليه، بعد ذلك يمكنك البدء في التفكير في الخطوات التي ستحتاج إلى اتخاذها لتحقيق تلك الأهداف من خلال بناء مدرّج التعرّض الخاص بك.

التخطيط لأهدافك

دعنا نفكر في كيفية تحويل تلك المواقف التي تخافها وتتجنبها إلى أهداف محددة ترغب في تحقيقها.

بدايةً قد ترغب في اختيار سلوك واحد أو اثنين للعمل عليه/ عليهما، بدلاً من محاولة تحدي كل ذلك مرة واحدة. عندما تخطط أهدافك للتعرض، يجب أن تركز على تلك السلوكيات التي تريد تغييرها، بدلاً من التخطيط لأهداف ليست مهمة بالنسبة لك. ومن خلال تحديد هدف مهم بالنسبة لك، تزداد احتمالية بذل الجهد وتحملك الانزعاج الطبيعي الذي يحدث عند القيام بتمارين التعرض.

من المهم أيضاً التفكير في وضع أهداف محددة. فكّر كيف يبدو سلوكك الآن، وكيف سيبدو إذا حققت هدفك. على سبيل المثال:

- إذا كان سلوكك الحالي هو "تجنب زيارة الأطباء"، فقد يكون هدفك هو "حضور موعد محدد في عيادة طبيبي".
- إذا كان سلوكك الحالي هو "تجنب ممارسة الرياضة"، فقد يكون هدفك هو "الانخراط في ممارسة الرياضة حتى أشعر بقلبي ينبض وتلهث أنفاسي".

قد يكون أيضاً السماح لنفسك بالتفكير تدريجياً في المرض وحتى في الموت جزءاً مهماً من تعافيك. فمثلاً:

- إذا كان سلوكك الحالي هو "تجنب التفكير في موتي"، قد يكون هدفك "كتابة وصيتي" أو "التخطيط لجنازتي"، رغم أن ذلك قد يبدو غريبًا.
- إذا كان سلوكك هو "عدم السماح لنفسك بالتفكير في الإصابة بالتصلب المتعدد"، فقد يكون هدفك "قراءة كتاب عن التصلب المتعدد" أو "كتابة قصة عن تشخيصك بالتصلب المتعدد".

يتيح لك العمل على مثل هذه الأهداف مواجهة أفكارك المخيفة تدريجيًا، وتقليل الكبح غير المفيد للأفكار الذي غالبًا ما يصاحب مثل هذه الأفكار.

أهدافي

مع وضع هذه الأفكار في الاعتبار، سجل هدفًا أو هدفين أدناه ترغب في العمل عليهما. خذ أيضًا لحظة للتفكير وتسجيل سبب أهمية العمل على هذا الهدف. قد تحتاج إلى مراجعة هذا لاحقًا إذا وجدت أن حافزك يتضاءل أو أنك غير متأكد من الاستمرار في خطوات مدرّجك.

الهدف المحدد رقم ١: _____
لماذا من المهم بالنسبة لي العمل على هذا الهدف؟

الهدف المحدد رقم ٢: _____
لماذا من المهم بالنسبة لي العمل على هذا الهدف؟

إذا كنت ترغب في العمل على مزيد من الأهداف، فمن الأفضل عادةً العودة والعمل على الخطوات السابقة نفسها مرة أخرى بدلاً من محاولة فعل كثير من الخطوات في وقت واحد والشعور بالإرهاق نتيجة لذلك.

بناء المدرج الخاص بك

يمكنك الآن البدء في بناء مدرج المواقف والأنشطة الذي ستصعده متجها نحو تحقيق هدفك. تذكر أنه من خلال اتباع نهج "خطوة بخطوة"، يمكنك تجاوز التحديات الأصغر، والتي بدورها ستساعدك على الشعور بمزيد من الثقة.

وجد عديد من الأشخاص الذين قاموا بتمارين التعرض أن تقسيم هدفهم العام إلى خطوات صغيرة ومحددة يساعدهم على الشعور بمزيد من الراحة من خلال معرفة ما سيحدث. هذا يعني أيضًا أنه عليك أن تتأكد أن الخطوات **صغيرة** بما يكفي لاتخاذها، لكنها **كبيرة** بما يكفي لأن تعتقد أنك تسير في الاتجاه الصحيح.

حاول التفكير في مجموعة من المواقف والأنشطة التي يمكنك القيام بها، بدءًا من أقلهم إثارة للقلق ثم الصعود تدريجياً حتى تصل إلى هدفك الرئيسي. كما فعلنا تماماً في المرحلة السابقة، يمكن إعطاء كل خطوة في المدرج تقديراً "للكرب" بين ٠ و ١٠٠، حيث يشير ٠ = إلى أن هذه الخطوة ليست مزعجة على الإطلاق، و ١٠٠ = هذه الخطوة مزعجة للغاية. قد يحتوي مدرجك على خطوات "بينية" أقل أو أكثر من المثال المذكور. بشكل عام، قد يحتاج الهدف شديد الصعوبة إلى كثير من الخطوات الصغيرة حتى لا تشعر بالإرهاق والإحباط أثناء صعود خطوات المدرج.

يمكنك تقسيم هدفك العام إلى خطوات أصغر من خلال تغيير **مَن** هناك، و**ماذا** تفعل، و**متى** تفعل ذلك، و**أين** تفعل ذلك، و**مدة** قيامك بذلك. في بعض الأحيان ستكون أهدافك مقيدة بتوفر فرص معينة، فمثلاً قد لا تكون المواعيد

الطبية متاحة بشكل متكرر بحيث يمكنك تنفيذ خطوات التعرض.. لذلك عليك التفكير في المواقف التي يمكن أن تكون بمثابة خطوات تساعدك على صعود خطوات المدرج لتصل إلى هدفك.

توضح الحالة التالية كيف يمكنك تحديد هدف وبناء خطوات للعمل على تحقيقه. يمكنك بعد ذلك استخدام ورقة عمل خطوات مدرج التعرض لإكمال الخطوات الخاصة بتحقيق هدفك.

يتجنب "فيل" الأماكن المرتبطة بالأشخاص المرضى. يتجنب المرافق الطبية لأنه يخشى التقاط أشياء من الأشخاص الآخرين الموجودين هناك من أجل المواعيد أو الإجراءات، كما أنه متردد بشكل خاص في حضور مواعيد الطبيب في عطلات نهاية الأسبوع عندما تكون العيادة في أكثر حالاتها ازدحاماً، على الرغم من أنه يعمل بدوام كامل ويجد صعوبة في الحضور خلال الأسبوع. كما يتجنب أحياناً الممر الطبي في السوبر ماركت المحلي، لأنه يخشى أن يكون هناك أشخاص مرضى قبله وربما لمسوا أشياء على الرفوف و"لوثوها". ولم يعد قادراً على الذهاب إلى مراكز التسوق الأكبر لأنه يشعر أن خطر التلوث أعلى في هذه المراكز. يدرك "فيل" أنه قد تأخر كثيراً عن موعد الفحص الخاص به، ويشعر بالإحباط من نفسه في كل مرة يضطر فيها إلى التسوق.

حدد "فيل" هدفاً يتمثل في "حضور موعد في عيادة طبيبه". لقد أدرك أن هذا أمر مهم لأنه كان متأخراً جداً عن موعد الفحص السنوي، ويتسبب تأجيل هذا الموعد في تزايد مقدار قلقه بشأن صحته. أثناء تصميم "فيل" لخطوات مدرج التعرض، تبين له أن أي خطوة تتضمن حضور موعد الطبيب مباشرة ستكون

صعبة للغاية (الشدة = ٨٠). لذلك صمّم بعض الخطوات حول زيارة الممر الطبي في عدد من محلات السوبر ماركت، وزيارة الصيدلية، ومجرد دخول عيادة من العيادات التي لا تتطلب حجزاً مسبقاً؛ حتى يتمكن من بناء ثقته تدريجياً للانخراط في الخطوة الأصعب المتمثلة في زيارة عيادة الطبيب ولقائه. حدد "فيل" أيضاً أنه سيحتاج إلى تقليل سلوك الأمان تدريجياً الخاص بعدم لمس الأشياء في هذه المواقف، حتى يتمكن حقاً من مواجهة خوفه من إصابته بالمرض. هذا هو مدرج "فيل":

خطوات مدرج التعرض – مثال

الهدف: حضور موعد في عيادة طبيبي

الخطوة	الكرب (٠ : ١٠٠)
١	أذهب إلى السوبر ماركت المحلي، وأقف في الممر الطبي لمدة خمس دقائق، دون أن ألمس أي شيء.
٢	أذهب إلى السوبر ماركت المحلي، وأقف في الممر الطبي لمدة عشر دقائق، ألمس مجموعة من الأشياء (على سبيل المثال: النقاط علب مختلفة من المناديل، قراءة المعلومات الموجودة على علبة مستحلبات السعال).
٣	أذهب إلى متجر كبير في السوبر ماركت، وأقف في الممر الطبي لمدة عشر دقائق ، لا ألمس أي شيء.
٤	أذهب إلى متجر كبير في السوبر ماركت، وأقف في الممر الطبي لمدة عشر دقائق، وألمس مجموعة من الأشياء.
٥	أذهب إلى الصيدلية المحلية، في نهاية الأسبوع ، وأبقى لمدة عشر دقائق ، وألمس مجموعة من الأشياء.
٦	أذهب إلى الصيدلية المحلية، في عطلة نهاية الأسبوع ، وأبقى لمدة عشر دقائق ، وألمس مجموعة من الأشياء.
٧	أدخل بعد ساعات العمل في عيادة من العيادات التي لا تتطلب حجزاً مسبقاً، وأجلس في غرفة الانتظار لمدة ١٥ دقيقة، لا ألمس أي شيء.

٨	أدخل بعد ساعات العمل في عيادة من العيادات التي لا تتطلب حجزاً مسبقاً، وأجلس في غرفة الانتظار لمدة ١٥ دقيقة، وألمس الأشياء الموجودة في غرفة الانتظار (على سبيل المثال: المجلات)	٧٥
٩	احضر إلى العيادة أثناء ساعات العمل دون حجز موعد مسبق، واجلس في حجرة الانتظار لمدة ١٥ دقيقة، وألمس الأشياء الموجودة في غرفة الانتظار (مثل: المجلات)	٨٠
١٠	احضر إلى العيادة مع حجز موعد مسبق، وألمس الأشياء الموجودة في غرفة الانتظار (على سبيل المثال: المجلات)	٩٠

التعرض للأفكار المخيفة

- يمكن أن يشمل مدرّج التعرض أيضًا التعرض للأفكار المخيفة حول المرض والموت. يمكن دمج الأنشطة التالية في مدرّجك لمساعدتك على مواجهة التدريجية للأفكار المخيفة بشأن المرض والموت بدلاً من تجنبها.
- قراءة النعي لإثارة أفكار حول مشاعر الأحباء عندما يرحل شخص ما.
 - كتابة كلمة "موت" بشكل متكرر على قطعة من الورق لإثارة أفكار الموت.
 - إعداد وصية لمواجهة حقيقة الموت.
 - زيارة جنازة أو مقبرة للتعرض للعمليات المرتبطة بالموت.
 - التخطيط لجنازتك الخاصة. مناقشة هذه الخطة مع الآخرين.
 - قراءة قصة كتبها شخص آخر تم تشخيصه بمرض لا يُرجى شفاؤه.
 - مشاهدة فيلم أو قراءة كتاب تعاني الشخصية المحورية فيه من الحالة نفسها التي تخاف منها.
 - كتابة نعيك لمواجهة حقيقة الموت. اكتبه كما لو أنك ستموت هذا الأسبوع، في عمرك الحالي.

قد يكون من المفيد أيضًا مواجهة مخاوفك الكبرى مباشرة من خلال كتابة قصة مقلقة. قد تكون القصة حول تشخيصك بمرض عضال، أو حول وفاتك، أو كيف سيتعامل الآخرون عند موتك. إذا كنت ستجرب هذا، فتأكد من كتابة القصة بصيغة المتكلم، وكأن ذلك يحدث هنا والآن. ركز على ما تشعر به الآن وما تفكر فيه أو تفعله الآن. هنا مثال:

أنا في عيادة الطبيب بعد أن اتصل بي. عادة ما يكون سعيدًا برؤيتي ولكن هذه المرة يبدو كئيبيًا وجادًا. أعلم بالفعل أن هناك خطبًا ولكن أحاول إقناع نفسي بأن هذا لا يمكن أن يحدث لي. جلست على الكرسي وبدأ يقول إنه تسلم نتائج الفحص الخاص بي. وبينما كان يقول الكلمات أومأت برأسي وأنا أقول "حسنًا" ولكن قلبي ينبض بسرعة كبيرة وأشعر بالإعياء لدرجة أنه من الصعب التركيز فيما يقوله. سلمني كتيبًا عن مرض العصبون الحركي *motor neuron disease* ويتحدث عن إحالتي إلى أخصائي.

لا يمكنني أن أستمع حقًا لأن رأسي مليء بتلك الكلمات "بقي لك من سنتين إلى خمس سنوات". لأول مرة في حياتي، أعلم حقًا أنني سأموت. أفكر في مدى سوء الأمر وما إذا كنت سأرحل بسرعة أو أعاني من الألم. ثم بدأت أفكر في أطفالي. كل ما يمكنني التركيز عليه هو أنهم سيرونني أتهور وهذا كل ما سيتذكرونه مني لأنهم صغار جدًا. أشعر بأنني مكبل وعاجز للغاية، وأنا أعرف أنه لا يوجد علاج.

كيف شعرت عند قراءة القصة أعلاه؟ سيجد معظم الناس الأمر على الأقل مزعجًا قليلًا عند القراءة، حتى لو لم يكن قلقًا بشأن مرض العصبون الحركي، أو ليس لديه أطفال. كم مرة يومياً تعتقد أنك تحتاج إلى قراءة هذه القصة على مدار الأسبوع المقبل حتى تصبح غير مؤثرة عليك كما حدث اليوم؟

تذكر أنه في أي تمرين للتعرض لا يكفي التعرض مرة واحدة في كثير من الأحيان. ستحتاج إلى تكرار تمارين التعرض عدة مرات لمواجهة هذه الأفكار المخيفة حقًا، ولكي تلاحظ انخفاض القلق والضيق المرتبط بهذه الأفكار. قد تحتاج إلى قراءة قصتك المقلقة عدة مرات في اليوم، على مدار أسبوع أو أسبوعين، قبل أن ترى تغييرًا ملحوظًا في مستوى انزعاجك.

ورقة عمل خطوات مدرج التعرض

الهدف:

الخطوة	الكرب (١٠٠ : ٠)

تذكر أن المدرج الخاص بك قد يحتوي على خطوات أكثر أو أقل اعتمادًا على مدى صعوبة هدفك العام. ويمكنك تضمين مزيد من الخطوات "البينية" إذا كنت تعتقد أن القفزة من خطوة لأخرى كبيرة جدًا.

يمكنك تقسيم هدفك العام إلى خطوات أصغر من خلال تغيير:

من هناك؟

ماذا تفعل؟

متى تفعل ذلك؟

أين تفعل ذلك؟

مدة قيامك بذلك؟

اتخاذ خطوة

بعد أن حددت هدفًا تريد العمل عليه، أين نذهب؟ أولاً، دعونا نلقي نظرة على كيفية اتخاذ خطوة على المدرج. ثم نكتشف كيفية صعود الدرجات.

خطط لخطوتك الأولى

قد يكون من المفيد تحديد تاريخ ووقت ومكان محددين تبدأ فيهم خطوتك الأولى. إنك بهذه الطريقة تلتزم التزامًا صارمًا تجاه نفسك لبدء عملية التغيير. عادةً ستبدأ من الخطوة التي تحصل على أدنى معدل "كرب". إذا كان هدفك يحتوي على بضع خطوات فقط، فمن المفيد غالبًا العمل بشكل تدريجي للوصول إلى هذا الهدف، على الرغم من أنه قد يبدو "مضيعة للوقت". فهذه الخطوات التدريجية تمنحك مواقف إضافية حتى يعتاد جسمك على الأشياء غير المريحة لك. كما أنها توفر لك فرصًا إضافية لجمع الأدلة حول أي أفكار غير مفيدة متعلقة بالصحة قد تراودك.

توقع بعض القلق

عندما تدخل الموقف، تذكر أنك -في أي خطوة- ستشعر على الأرجح ببعض القلق أو الانزعاج. هذا هو السبب في أهمية البدء على نطاق صغير، ثم تشق طريقك. هذه الطريقة تمنحك فرصة للتكيف مع هذا المستوى من القلق، بحيث لا تطغى عليك المستويات المرتفعة من التوتر. وبشكل عام، فإن الطريقة الوحيدة للتعود على هذه المشاعر هو معاشتها.

تذكر أفكارك الواقعية المتعلقة بالصحة

إذا لم تكن قد أكملت "مذكرات الأفكار" لتحدي أي تفكير غير مفيد متعلق بالصحة، فقد ترغب في إكمال واحدة من تلك المذكرات قبل اتخاذ خطواتك الأولى. أما إذا كنت قد أكملت واحدة، فذكّر نفسك بأفكارك الواقعية المتعلقة بالصحة إذا لاحظت ظهور أي من الأفكار غير المفيدة.

ابق في الموقف

بالطبع من المتوقع حدوث بعض القلق، وقد يكون من المغري مغادرة الموقف إذا شعرت بعدم الارتياح، لكن حاول البقاء في الموقف حتى يزول القلق. وبهذه الطريقة يمكنك أن ترى أنه على الرغم من وجود مشاعر **مخيفة**، فإنها ليست **خطيرة**، بل إنها تهدأ. أما إذا غادرت الموقف بمجرد ارتفاع مستوى القلق إلى أعلى نقطة؛ فسيكون من الصعب عليك اجتياز الخطوة نفسها في المرة القادمة. يجب في كل مرة أن تحاول مواجهة أكبر قدر ممكن من الخوف ومحاولة "تخطي" القلق - مثل ركوب الأمواج.

تخلّ عن سلوكيات الأمان

تتطلب بعض الخطوات في مدرج التعرض أن تتعرف على سلوكيات الأمان وتتخلّى عنها. بغض النظر عن الموقف أو النشاط، حاول أن تكون صادقاً مع نفسك بشأن ما إذا كنت تنخرط في موقف التعرض بشكل كامل، أم أنك تفعل ذلك فقط إذا كنت تأخذ بعض الاحتياطات. يعني الانخراط الكامل أن تكون واعياً تماماً بما يحدث داخلك وما يحدث من حولك. هذا يعني أيضاً عدم تناول الكحول أو المخدرات لمحاولة "الهروب ذهنياً" من تمرين التعرض. تذكر أنك إذا وجدت من الصعب للغاية التخلي عن سلوك الأمان على الفور، فيمكنك استخدام المدرج الخاص بك لتقليله تدريجياً.

صعود المدرج

حسنًا، بعد أن أصبح لديك الآن بعض النصائح حول كيفية اجتياز خطوة واحدة، كيف يمكنك الاستمرار في المضي قدمًا والصعود إلى أعلى؟ فيما يلي بعض الإرشادات حول كيفية الاستمرار في الصعود حتى تصل إلى هدفك.

اتخذ خطوة واحدة في كل مرة

صعود المدرج لا يعني القيام بقفزة عملاقة مرة واحدة، إنما يعني اتخاذ خطوة صغيرة واحدة في كل مرة. ابدأ بالخطوة الأقل صعوبة ثم شق طريقك تدريجيًا إلى أعلى المدرج. عندما تصعد إلى أعلى المدرج، سيصبح معدل "الكرب" أعلى، ولكنك أيضًا ستكون قد اعتدت على القلق في كل خطوة من الخطوات السابقة. هدفك الأساسي في كل خطوة هو إكمال تلك الخطوة... تلك الخطوة فقط.

كرر الخطوة مرارًا وتكرارًا

كرر كل خطوة، وقم بها بتتابع وثيق للتأكد من أنك تشعر بالراحة في الموقف قبل الانتقال إلى الخطوة التالية. قد يستغرق هذا ٣ أو ٤ مرات. إذا دخلت في موقف مرة واحدة فقط، فقد تشعر بالارتياح لانتهاؤ الأمر، وقتها ستقنع نفسك أنك كنت محظوظًا لأنك تجاوزته، وتعتقد أنك إذا فعلت ذلك مرة أخرى فلن تسير الأمور على ما يرام. لذا من الأفضل أن تكرر الخطوة في أسرع وقت ممكن؛ حتى تعتاد على الموقف بسرعة أكبر وتصبح أكثر راحة، وبذلك تكون مقتنعًا حقًا أن الخطوة لم تعد مشكلة بالنسبة لك.

اعترف بنجاحاتك واجتيازك الخطوات التي اتخذتها

عندما تشعر بالارتياح تجاه خطوة معينة، اعترف بنجاحاتك واعترف بالخطوات التي اتخذتها حتى الآن. يمكنك أيضا التخطيط لبعض المكافآت للاعتراف بتقدمك على طول الطريق.

تعامل مع خطوات التراجع

لدينا جميعًا أيام صعود وأيام هبوط، وفي بعض الأحيان قد تعتقد أنك قد تراجع "خطوة إلى الوراء" لأن تمرين التعرض لم يتم كما كنت تأمل. كل مرة نقوم فيها بتمرين التعرض من المحتمل أن تكون مختلفة عن غيرها. لهذا السبب من المهم أن تقوم بالخطوة مرارًا وتكرارًا حتى تشعر بالراحة تجاه هذه الخطوة. إذا كنت تواجه بعض المشكلات في خطوة معينة، فربما تحتاج لإنشاء "جسر" أو خطوة بينية، ويتضمن هذا التخطيط لخطوة أخرى أقل إزعاجًا بدرجة طفيفة ولها معدل "كرب" أقل قليلًا. وقد تفكر في شيء بديل، وهو أن تحاول العودة إلى الخطوة السابقة وتتخذها كفرصة لإنعاش مهاراتك قبل محاولة الصعود مرة أخرى. لا تنس تحديد تاريخ ووقت ومكان محددين عندما تشرع في اتخاذ الخطوة التالية.

استخدم يوميات التعرض

ستجد في الصفحة التالية "يوميات التعرض" لتسجيل تفاصيل حول تمارين التعرض التي تقوم بها. هذا مفيد لأنه يساعدك على الاعتراف بالخطوات التي قمت بها، ويذكرك بالأشياء التي ساعدتك في تجاوز ذلك، ويساعدك على تحديد ما يمكنك القيام به إذا لم تسر الخطوة كما تتوقع.

يوميّات التعرّض

يمكنك استخدام هذه الورقة لتسجيل تقدمك على المدرج الخاص بك. يمكنك وصف ما خططت لفعله، وتقديرات "الكرب" الخاصة بشعورك بالتوتر كما كنت تتوقعها، ودرجة شعورك بالتوتر كما حدثت في الواقع. كما يُطلب منك في العمود الأخير تدوين أي تعليقات حول تجربة التعرّض - هل كنت قادرًا على فعل ما خططت له؟ ما الذي ساعدك على القيام بذلك؟ إذا كنت قد واجهت قدرًا كبيرًا من الصعوبة، فيمكنك تدوين سبب ذلك في اعتقادك، وكيف يمكنك إعداد نفسك في المرة القادمة.

تمرين التعرّض المخطط له	درجة الكرب المتوقعة (١٠٠ : ٠)	درجة الكرب الفعلية (١٠٠ : ٠)	هل قمت بتنفيذ الخطوة بالفعل؟ ما الذي ساعدك على إكمال هذه الخطوة؟ أو صف ما الذي جعل إكمال هذه الخطوة صعبًا؟ وكيف يمكنك الاستعداد في المرة القادمة؟

ملخص المرحلة السابعة

- تجنب المواقف أو الأنشطة أو استخدام سلوكيات أمان للتعامل معها، قد يقلل من القلق الذي تشعر به على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل قد يعمل على استمرار قلق الصحة لديك.
- تُعرّف مواجهة المواقف، والأنشطة المخيفة، والأفكار حول المرض والموت، بالتعرض.
- يمنحك التعرض الفرصة لـ:
 - التعود على المواقف/ الأنشطة التي كنت تخشى منها سابقاً.
 - التعود على أحاسيس القلق.
 - الاستمرار في تحدي مخاوفك.
 - استخدام مهاراتك.
 - تحسين ثقتك بنفسك.
- يسمح لك مُدرج التعرض بتقسيم تمارين التعرض التي تخطط لها إلى خطوات أكثر قابلية للتنفيذ. يمكن تسجيل ذلك على خطوات المدرج؛ حتى تعرف الخطوات التي يتعين عليك اتخاذها للوصول إلى هدفك العام.
- عند اتخاذك خطوة، من المهم أن تتذكر ما يلي:
 - خطط جيداً - كن محدداً بشأن ما ستفعله ومتى.
 - توقع بعض القلق.
 - تذكر أفكارك الواقعية المتعلقة بالصحة من مذكرات أفكارك.
 - حاول البقاء في الموقف أو النشاط حتى يقل قلقك.
 - تخلّ عن أي سلوكيات أمان تكون واعياً بها.

• عند صعود المدرج:

- خذ خطوة واحدة في المرة الواحدة.
- قم بالخطوة بشكل متكرر - تأكد من أنك تشعر بالراحة في تلك الخطوة قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.
- اعترف باجتيازك الخطوات التي اتخذتها.
- توقع أن يكون لديك تراجع في بعض الخطوات، واعلم أن كل شخص لديه أيام صعود وأيام هبوط. إذا كنت تواجه صعوبة في إكمال خطوة ما؛ فعد إلى المسار الصحيح إما عن طريق إضافة خطوة بين الخطوات، أو العودة إلى الخطوة السابقة وتنشيط مهاراتك قبل محاولة الصعود مرة أخرى.

التالي ...

في المرحلة التالية، سوف نتعلم تعديل أي قواعد أو افتراضات غير مفيدة لدينا متعلقة بالصحة، وتطوير قواعد أكثر واقعية ومرونة.

Helping Health Anxiety

About The Modules

CONTRIBUTORS

Dr Rebecca Anderson (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

Paula Nathan (MPsych¹)
Centre for Clinical Interventions

Dr Lisa Saulsman (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

¹Masters of Psychology (Clinical Psychology)

²Doctor of Philosophy (Clinical Psychology)

BACKGROUND

The concepts and strategies in these modules have been developed from evidence based psychological practice, primarily Cognitive-Behaviour Therapy (CBT). CBT for health anxiety is based on the approach that health anxiety is a result of problematic cognitions (thoughts) and behaviours.

REFERENCES

These are some of the professional references used to create the modules in this information package.

Abramowitz, J., Taylor, S., & McKay, D. (2010). Hypochondriasis and severe health anxiety. In McKay, D., Abramowitz, J., S., & Taylor, S. (Eds.). *Cognitive-behavior therapy: Turning failure into success* (pp. 327-346). Washington, DC: American Psychological Association.

Asmundson, G., & Taylor, S. (2005). *It's not all in your head: How worrying about your health could be making you sick – and what you can do about it*. New York: The Guilford Press.

Furer, P., & Walker, J. (2006). *Health anxiety treatment manual*. University of Manitoba: Manitoba.

Furer, P., Walker, J., & Stein, M. (2007). *Treating health anxiety and fear of death*. New York: Springer.

Papageorgiou, C., & Wells, A. (1998). Effects of attention training on hypochondriasis: A brief case series. *Psychological Medicine*, 28, 193-200.

Salkovskis, P., Warwick, H., & Deale, A. (2003). Cognitive-behavioural treatment for severe and persistent health anxiety (Hypochondriasis). *Brief Treatment and Crisis Intervention*, 3, 353-367.

Willson, R., & Veale, D. (2009). *Overcoming health anxiety: A self-help guide using cognitive behavioural techniques*. London: Robinson.

"HELPING HEALTH ANXIETY"

This module forms part of:

Anderson, R., Saulsman, L., & Nathan, P. (2011). *Helping Health Anxiety*. Perth, Western Australia: Centre for Clinical Interventions.

ISBN: 0 9757995 6 8

Created: August 2011

This is a translation of CCI (Centre for Clinical Interventions) materials as translated by [Amara Yehia Arafat] but not reviewed by CCI (Centre for Clinical Interventions, Western Australia). Original materials located at www.cci.health.wa.gov.au

المرحلة الثامنة

تعديل القواعد والافتراضات المرتبطة بالصحة

١- مقدمة

٢- القواعد والافتراضات المفيدة مقابل غير المفيدة

٣- تحديد القواعد والافتراضات غير المفيدة المرتبطة بالصحة لدي

٤- تعديل القواعد والافتراضات المرتبطة بالصحة

ورقة عمل (مثال)

ورقة عمل

٥- المتابعة

٦- ملخص المرحلة

٧- حول المراحل

مقدمة

لقد تعلمت الآن استراتيجيات لتقليل مقدار الوقت الذي تقضيه في القلق والتركيز على الأعراض الصحية، وأخرى لتحدي الأفكار غير المفيدة المتعلقة بالصحة، وأيضا استراتيجيات لتقليل السلوكيات غير المفيدة المتعلقة بالصحة. نأمل أن تجد هذه الاستراتيجيات مفيدة يوما بعد يوم في تحسين طريقة تفكيرك، وشعورك تجاه صحتك، وسلوكك المتعلق بصحتك. الآن بعد أن أصبح لديك بعض الخبرة في العمل مع آليات إدارة قلق الصحة، من المهم أيضًا معالجة الأسباب الكامنة الأكثر صعوبة التي تسببت في قلقك بشأن صحتك. في هذه المرحلة، سنناقش تعديل القواعد والافتراضات الأساسية التي أدت إلى معاناتك من قلق الصحة.

القواعد والافتراضات المفيدة مقابل

غير المفيدة

كما ذكرنا في المرحلة الثانية، لدينا جميعًا قواعد وافتراضات نعيش بها حياتنا. على الرغم من أننا لم ندرس هذه "القواعد" بشكل محدد، فإننا نتعلمها من خلال تجاربنا السابقة، ومن ملاحظة الأشخاص الآخرين المؤثرين علينا في

سنواتنا المبكرة. إنك قد لا تدرك حتى أن هذه القواعد أو الافتراضات تكوّنت لديك، لكنها على أي حال تؤثر باستمرار على أفكارك وسلوكك.

كما ذكرنا سابقاً، فإن بعض القواعد والافتراضات مفيد والبعض الآخر ليس كذلك. إننا جميعاً نحتاج إلى إرشادات في حياتنا لمساعدتنا على فهم العالم والتكيف في حياتنا اليومية. لذا فإن وجود القواعد في حد ذاته ليس أمراً سيئاً.

القواعد والافتراضات المفيدة تكون واقعية ومرنة إلى حد ما. ومن الأمثلة على القواعد الصحية، "يجب أن يتوقف السائقون عند الإشارة الحمراء". هذه قاعدة مفيدة لأن هناك أدلة تشير إلى أن عدم التوقف عند الإشارة الضوئية الحمراء قد يؤدي إلى وقوع حادث للسيارة. لذا فإن الحفاظ على هذه القاعدة يمكن أن يساعد في ضمان بقائنا!

القواعد المفيدة أيضاً مرنة وقابلة للتكيف، وهذا يساعدنا على تكيف سلوكنا مع المواقف المختلفة. على سبيل المثال، فإن القاعدة التي تقول: "من الجيد محاولة تناول الطعام الصحي" تُعد قاعدة مفيدة؛ لأن هناك أدلة تدعم حقيقة أن مشاكلك الصحية ستصبح أقل إذا تناولت أطعمة صحية. ولكن هناك أيضاً مرونة في هذه القاعدة بحيث تأخذ في الاعتبار المناسبات التي قد تُفضّل فيها تناول الأطعمة الأقل صحية دون شعور بالذنب (على سبيل المثال، أعياد الميلاد أو الكريسماس).

أما القواعد غير المفيدة هي تلك القواعد غير المرنة وغير المنطقية. على سبيل المثال، فإن الاعتقاد بأن "طبيبي يجب أن يكون قادراً على شرح كل الأحاسيس والتغيرات الجسدية لديّ" هو اعتقاد غير منطقي، بمعنى أنه من غير المحتمل أن يكون طبيبك قادراً على الحفاظ على هذا المعيار في كل مرة تراه

فيها. فمن غير الممكن أو المعقول أن تتوقع من طبيبك أن يعرف بالضبط ما يحدث داخل جسمك في جميع الأوقات. لذلك، فإن هذا النوع من القواعد غير المفيدة سيُبقيك فقط قلقًا بشأن صحتك، وغير راضٍ أو ربما محبطًا من طبيبك.

تحديد الافتراضات والقواعد غير المفيدة المتعلقة بالصحة

لنأخذ الآن بعض الوقت لتحديد القواعد والافتراضات غير المفيدة المتعلقة بالصحة التي ربما تكونت لديك. لعلك لديك فكرة بالفعل عن هذه القواعد والافتراضات من العمل الذي أكملته في المرحلة الثانية. إن لم تكن متأكدًا، فهناك عدة طرق يمكنك من خلالها البدء في تحديد هذه القواعد أو الافتراضات.

خذ لحظة لتسجيل بعض الردود على الأسئلة التالية:

• كيف كان المحيطون بي يستجيبون للمخاوف الصحية في الماضي؟ ما الذي يمكن أن أكون قد تعلمته منهم؟

• ما هي المعايير التي أتوقع أنني ألتزم بها فيما يتعلق بصحتي؟

• ما هي المعايير التي أتوقع أن يتفق معها طبيبي أو غيره من المختصين في المجال الطبي؟

• ما هي الأعراض التي يمكنني أن أشعر بها دون قلق؟

• ما هي الأعراض أو الأحاسيس الجسمية التي لا أتعلمها مطلقاً؟

- ما هي التوقعات السلبية التي أقوم بها بشكل متكرر حول صحتي؟

(ملاحظة: قد ترغب في مراجعة يوميات أفكارك الموجودة في المرحلة الخامسة؛ لمعرفة المواضيع المتكررة).

يمكن أن تكون القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة في شكل عبارات مثل:

"يجب/ لابد/ ينبغي عليّ دائماً..."	على سبيل المثال: "يجب أن آخذ جميع الأعراض والتغيرات الجسدية على محمل الجد." "يجب أن أتخلص من الأعراض لأكون بصحة جيدة".
"يجب/ لابد/ ينبغي على طبيبي دائماً..."	على سبيل المثال: "يجب أن يكون طبيبي متيقناً." "يجب أن يكون طبيبي قادراً على شرح كل الأحاسيس والتغيرات الجسدية لدي".
"لا يجب/ لا ينبغي أبداً..."	على سبيل المثال: "لا يجب أبداً أن أتجاهل أي عرض".
"لا يجب/ لا ينبغي على طبيبي أبداً..."	على سبيل المثال: "لا يجب أن يستبعد طبيبي أبداً أي عرض حتى يتم إجراء جميع الفحوص الممكنة"

على سبيل المثال: إذا كان طبيبي لا يعرف بالضبط ما هي المشكلة، فلا بد أن الأمر خطير حقًا." "إن لم أواصل ما أفعل، فقد يفوت طبيبي شيء مهم"	"إذا...، إذن..."
---	-------------------------

الآن بعد أن قرأت هذا القسم حول تحديد القواعد والافتراضات الخاصة بك المتعلقة بالصحة، هل تمكنت من تحديد أي منها يعمل في حياتك؟ ما هي بعض تلك القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة؟ خذ لحظات قليلة لكتابتها.

تعديل القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة

لعلك أصبحت قادراً الآن على تحديد تلك القواعد والافتراضات التي كانت توجه أفكارك ومشاعرك وسلوكياتك اليومية المتعلقة بالصحة. ويمكنك العمل - كما في المراحل السابقة تماماً - على تحدي تلك القواعد والافتراضات الخاصة بك المتعلقة بالصحة عن طريق طرح أسئلة محددة على نفسك، واستخدام أوراق العمل لإرشادك خلال ذلك خطوة بخطوة. إذا كنت قد قمت بالتدريبات الواردة في المراحل السابقة؛ فمن المحتمل أن تجد تغيير القواعد والافتراضات أسهل قليلاً بالنسبة لك. وبشكل عام، ستكون قد عالجت بالفعل تلك الأفكار والمشاعر والسلوكيات التي كانت تُغذي القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة الخاصة بك يوماً بعد يوم.

الهدف من استكمال ورقة العمل الخاصة بـ "تعديل القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة الخاصة بي" ليس التخلص من هذه القواعد أو الافتراضات الخاصة بك، بل تعديلها إلى توجيهات صحية أكثر واقعية ومرونة.

قبل إكمال ورقة العمل، اقرأ الخطوات التالية:

١. حدد القاعدة أو الافتراض المتعلق بالصحة الذي ترغب في تعديله

قد يكون لديك عدد من القواعد أو الافتراضات التي ترغب في العمل عليها. يفضل بعض الناس التعامل مع القاعدة أو الافتراض الذي يؤثر عليهم

أكثر من غيره، في حين يفضل آخرون البدء بالقاعدة أو الافتراض الذي يعتقدون أن تحدّيه سيكون أسهل؛ حتى يتمكنوا من بناء بعض الثقة. كلا الطريقتين جيد، ولا يوجد طريق صحيح أو خاطئ للبدء به.

٢. اسأل نفسك "من أين أتت هذه القاعدة/ الافتراض؟ لماذا لا يزال موجوداً؟"

الغرض من الجزء الأول في السؤال هو التفكير في سبب تكوّن هذه القاعدة أو الافتراض. كما ذكرنا سابقاً، غالباً ما تتكوّن هذه القواعد والافتراضات كوسيلة لحماية، ولجعلنا نشعر بأننا أقل ضعفاً. لذلك من الممكن تماماً أن تكون القواعد أو الافتراضات منطقية في الوقت الذي تكوّنت فيه. الغرض من الجزء الثاني في السؤال هو فحص سبب استمرار تمسكك بهذه القواعد أو الافتراضات. اسأل نفسك، "ما هي مزايا أن أحيا متمسكاً بهذه القاعدة أو الافتراض؟ ما هي الفوائد التي أحصل عليها؟ ما الذي تحميني منه هذه القواعد أو الافتراضات الآن؟"

٣. اسأل نفسك "ما هو تأثير هذه القاعدة/ الافتراض على حياتي؟"

توقف لحظة لتسجيل كيف أثر التمسك بهذه القاعدة أو الافتراض على تفكيرك ومشاعرك وسلوكياتك. كيف أثر على علاقاتك بالآخرين، بما في ذلك المختصين في المجال الصحي؟ كيف أثر ذلك على قدرتك على القيام بالأشياء التي تقدّرهما والتي تمنحك إحساساً بالمتعة أو الرضا؟

٤. اسأل نفسك "ما هي الطرق التي تعتبر بها هذه القاعدة غير منطقية أو غير واقعية أو غير مفيدة؟"

• هل القاعدة الخاصة بك قابلة للتحقق بالفعل؟ (على سبيل المثال: إذا كنت تعتقد أنه "يجب أن أتحرك من الأعراض لأكون بصحة جيدة" - هل يمكنك فعلاً أن تكون خالياً من الأعراض؟)

• هل تستطيع أنت أو طبيبك الوصول حقا إلى هذا المعيار؟ هل من الممكن أن تكون لدى طبيبك مجموعة مختلفة من القواعد أو الافتراضات؟ (على سبيل المثال: إذا كنت تعتقد أنه "يجب أن يكون طبيبي قادراً على شرح كل الأحاسيس والتغيرات الجسدية لديّ" - فهل يعرف طبيبك قواعدك/افتراضاتك؟ هل يتبع طبيبك القواعد أو الافتراضات نفسها؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فما هي القواعد أو الافتراضات التي يعملون في ظلها؟ وهل يستطيع الأطباء دائماً شرح كل شيء؟)

• هل عيوب هذه القاعدة/الافتراض تفوق المزايا؟ إذا كانت هناك مزايا أكثر من العيوب؛ فربما لا تحتاج إلى تحدي هذه القاعدة/الافتراض. ولكن إذا قررت أن القاعدة/الافتراض غير مفيد، فلننتقل إلى الخطوة التالية.

٥. الآن، فكر ملياً ما هي القاعدة أو الافتراض الأكثر توازناً ومرونة.

ضع في اعتبارك استخدام مصطلحات أقل تطرفاً من المصطلحات السابقة "يجب" و "ينبغي"، فمثلاً يمكن استخدام: "أحياناً"، "أفضّل ذلك إذا ..."، "أود ..."، "سيكون من الجيد إذا ...".

على سبيل المثال: بدلاً من القاعدة غير المفيدة "يجب ألا أتجاهل أبداً أي عرض"، ضع في اعتبارك قاعد بديلة مثل: "سأحتاج أحياناً إلى الانتباه لأعراض معينة، مثل الألم والحمى وعلامات العدوى. ومع ذلك، تتحسن

معظم الأعراض بمرور الوقت، ومن الطبيعي جدًا أن أشعر بأحاسيس مختلفة، بما في ذلك الأوجاع والآلام".

يمكنك أيضًا التفكير في تغيير عبارات "إذا... إذن..." إلى استخلاص أقل إثارة للقلق. على سبيل المثال: بدلاً من الافتراض غير المفيد "إذا كان طبيبي لا يعرف بالضبط ما هي المشكلة، فلا بد أن الأمر خطير حقًا"، فكر في افتراض بديل "إذا كان طبيبي لا يعرف بالضبط ما هي المشكلة، فربما لا داعي للقلق".

قد ينتهي الأمر بالقواعد والافتراضات المتوازنة إلى أن تكون أطول في صياغتها من القواعد والافتراضات القديمة، هذا لأنها أكثر تطوراً – لأنك تعمل على جعلها واقعية ومرنة وقابلة للتكيف. إذا وجدت صعوبة في التفكير في قاعدة أو افتراض بديل أكثر توازناً، فلا تقلق، استمر في اتباع الاستراتيجيات التي تعلمتها في المراحل السابقة للتعامل مع أفكارك ومشاعرك وسلوكياتك اليومية المتعلقة بالصحة. ومن خلال القيام بذلك، ستبذل أمامك القواعد والافتراضات الأكثر توازناً بمرور الوقت.

٦. أخيراً، اسأل نفسك "ما الذي يمكنني فعله يومياً لوضع هذه القاعدة/ الافتراض موضع التنفيذ؟"

لماذا تعتقد أنه من المهم القيام بذلك؟ تذكر أن القاعدة أو الافتراض القديم الخاص بك قد يظل مستمراً في العمل لبعض الوقت، وقد يستمر في توجيه سلوكك فيما يتعلق بصحتك. لذلك من المهم ألا تكون لديك قاعدة جديدة فحسب، بل سلوكيات جديدة تصاحب هذه القاعدة حتى تعتاد تلك القاعدة، وتصبح جزءاً من طريقتك الجديدة في العمل.

في الصفحة التالية مثال على كيفية إكمال "ورقة عمل تعديل القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة". وفي الصفحة التي تلي ذلك توجد ورقة عمل فارغة. بعد أن تتاح لك الفرصة لإلقاء نظرة على المثال، حاول إكمال ورقة عمل بنفسك لتعديل إحدى القواعد أو الافتراضات غير المفيدة المتعلقة بالصحة.

تعديل القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة الخاصة بي

(مثال)

القاعدة أو الافتراض المتعلق بالصحة الذي أرغب في تعديله

يجب أن أكون خاليا من الأعراض لأكون بصحة جيدة

من أين أتت هذه القاعدة/ الافتراض؟ لماذا لا يزال موجودا؟

لطالما كان أفراد أسرتي يقلقون على صحتهم.

كانت والدتي تأخذنا إلى الطبيب للحصول على مضادات حيوية حتى

لو كان لدينا أدنى درجة من أعراض البرد.

كنا إذا أخبرناها عن أي وجع أو ألم، كانت تشعر حقا بالهم والقلق.

وحتى الآن ما زلت أشعر بالقلق من أنني إذا تغاضيت عن هذا المعيار،

سأعرض نفسي للمرض.

ما هو تأثير هذه القاعدة/ الافتراض على حياتي؟

أفكر وأقلق دائما بشأن أي أحاسيس في جسدي.

أشعر بالحاجة للذهاب إلى الطبيب في كل مرة ألاحظ فيها شيئا غريبا

أو جديدا في جسدي.

لا أحب الشعور بالتعب، لذلك لا أقوم بجهد كبير. ومن ثم أفقد كثيرًا من الأشياء الممتعة التي يقوم بها أصدقائي.
أجد صعوبة في التركيز في العمل، خاصة إذا شعرت بشيء ما يحدث في جسدي.

ما هي الطرق التي تُعتبر بها هذه القاعدة غير منطقية أو غير واقعية أو غير مفيدة؟

عندما أقول لنفسي، "يجب أن أكون خاليًا من الأعراض حتى أكون بصحة جيدة"، فأنا أضع معيارًا غير قابل للتحقيق.
من المستحيل أن أكون خاليًا من الأعراض ومن الطبيعي أن أشعر ببعض الأوجاع والآلام من وقت لآخر.
حتى بعض الأشخاص "الأصحاء" يعانون من الأوجاع والآلام أحيانًا.

ما هي القاعدة أو الافتراض الأكثر توازنًا ومرونة؟

أفضل ألا أشعر بأي إزعاج أو أحاسيس غريبة في جسدي، لكن من غير المحتمل أن أكون دائمًا خاليًا من الأعراض.
ربما يكون من المفيد أن أفكر في محاولة الحفاظ على نمط حياة صحي أكثر من القلق بشأن جميع الأعراض والأحاسيس الغريبة في جسدي.

ما الذي يمكنني فعله يوميًا لوضع هذه القاعدة/ الافتراض موضع التنفيذ؟

سأبدأ في القيام بمزيد من الأنشطة مع أصدقائي وأترك نفسي أشعر
بالتعب من حين لآخر.

سأحرص على شراء الفواكه والخضروات الطازجة كل أسبوع لتحسين
نظامي الغذائي.

سأستخدم استراتيجيات الانتباه والتأجيل حتى لو شعرت ببعض
الأحاسيس الغريبة في جسدي؛ لكي أتمكن من مواصلة الحياة.

تعديل القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة الخاصة بي

القاعدة أو الافتراض المتعلق بالصحة الذي أرغب في تعديله
من أين أتت هذه القاعدة/ الافتراض؟ لماذا لا يزال موجوداً؟
ما هو تأثير هذه القاعدة/ الافتراض على حياتي؟
ما هي الطرق التي تُعتبر بها هذه القاعدة/ الافتراض غير منطقي أو غير واقعي أو غير مفيد؟
ما هي القاعدة أو الافتراض الأكثر توازناً ومرونة.
ما الذي يمكنني فعله يومياً لوضع هذه القاعدة/ الافتراض موضع التنفيذ؟

المتابعة

الآن بعد أن أكملت ورقة العمل الخاصة بك، تأكد من الاحتفاظ بنسخة من هذه القاعدة أو الافتراض الجديد في مكان يسهل عليك الوصول إليه. وبشكل عام، من المحتمل أن تظهر القواعد القديمة المتعلقة بالصحة من وقت لآخر، حيث إنها قد تستغرق بعض الوقت لكي تبلى. ولكي تصبح مؤمناً بالقاعدة أو الافتراض الجديد؛ فإنك تحتاج إلى تذكير نفسك به باستمرار.

الأهم من ذلك، أن تستمر في وضع القاعدة الجديدة موضع التنفيذ من خلال الإجراءات اليومية التي تخطط لها. وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو صعباً بالنسبة لك الآن؛ فإنه سيصبح أسهل مع استمرارك في فعله، وفي النهاية ستصبح طريقةً جديدةً تعيش بها حياتك.

تذكر أن الهدف ليس التخلص من القواعد المفيدة المتعلقة بالصحة (على سبيل المثال: "إذا كان لدي ألم شديد، فينبغي عليّ مراجعة الطبيب")، وإنما هدفنا هو تعديل القواعد غير الواقعية وغير المفيدة والتي عفا عليها الزمن.

ملخص المرحلة الثامنة

- لدينا جميعاً قواعد وافتراضات نعيش بها حياتنا. وعلى الرغم من أننا قد لا نكون على وعي بها، لكنها تؤثر باستمرار على أفكارنا وسلوكياتنا.
- القواعد المفيدة هي تلك التي تتسم بالواقعية والمرونة إلى حد ما، ولقد تكونت في الأساس لمساعدتنا على العمل والحفاظ على سلامتنا.
- القواعد غير المفيدة هي تلك القواعد غير المرنة وغير المعقولة.
- على الرغم من أننا قد نطوّر قواعد وافتراضات متعلقة بالصحة لمحاولة حماية أنفسنا، فإنها إذا كانت غير مرنة أو غير معقولة يمكن أن تعمل على استمرار قلق الصحة لدينا.
- لكي تقوم بتعديل أي قاعدة أو افتراض متعلق بالصحة، يمكنك أن:
- تضع في اعتبارك من أين جاءت تلك القاعدة أو الافتراض، ولماذا لا يزال موجودا حالياً.
- تحدد التأثيرات الحالية للقاعدة أو الافتراض.
- تضع في اعتبارك الطرق التي تعتبر بها هذه القاعدة غير منطقية أو غير واقعية أو غير مفيدة.
- تطوّر قاعدة أو افتراضاً جديداً متوازناً ومرناً.
- تفكّر في طرق جديدة للسلوك من شأنها أن تضع القاعدة أو الافتراض الجديد موضع التنفيذ.

التالي ...

في المرحلة التالية، سنقوم بتطوير خطة إدارة ذاتية لعيش حياة صحية؛ لكي تحافظ على كل ما تعلمته خلال هذه المراحل.

Helping Health Anxiety

About The Modules

CONTRIBUTORS

Dr Rebecca Anderson (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

Paula Nathan (MPsych¹)
Centre for Clinical Interventions

Dr Lisa Saulsman (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

¹Masters of Psychology (Clinical Psychology)

²Doctor of Philosophy (Clinical Psychology)

BACKGROUND

The concepts and strategies in these modules have been developed from evidence based psychological practice, primarily Cognitive-Behaviour Therapy (CBT). CBT for health anxiety is based on the approach that health anxiety is a result of problematic cognitions (thoughts) and behaviours.

REFERENCES

These are some of the professional references used to create the modules in this information package.

Abramowitz, J., Taylor, S., & McKay, D. (2010). Hypochondriasis and severe health anxiety. In McKay, D., Abramowitz, J., S., & Taylor, S. (Eds.). *Cognitive-behavior therapy: Turning failure into success* (pp. 327-346). Washington, DC: American Psychological Association.

Asmundson, G., & Taylor, S. (2005). *It's not all in your head: How worrying about your health could be making you sick – and what you can do about it*. New York: The Guilford Press.

Furer, P., & Walker, J. (2006). *Health anxiety treatment manual*. University of Manitoba: Manitoba.

Furer, P., Walker, J., & Stein, M. (2007). *Treating health anxiety and fear of death*. New York: Springer.

Papageorgiou, C., & Wells, A. (1998). Effects of attention training on hypochondriasis: A brief case series. *Psychological Medicine*, 28, 193-200.

Salkovskis, P., Warwick, H., & Deale, A. (2003). Cognitive-behavioural treatment for severe and persistent health anxiety (Hypochondriasis). *Brief Treatment and Crisis Intervention*, 3, 353-367.

Willson, R., & Veale, D. (2009). *Overcoming health anxiety: A self-help guide using cognitive behavioural techniques*. London: Robinson.

“HELPING HEALTH ANXIETY”

This module forms part of:

Anderson, R., Saulsman, L., & Nathan, P. (2011). *Helping Health Anxiety*. Perth, Western Australia: Centre for Clinical Interventions.

ISBN: 0 9757995 6 8

Created: August 2011

المرحلة التاسعة

الحياة الصحية والتخطيط لإدارة الذات

١- مقدمة

٢- إعادة النظر في نموذج قلق الصحة

٣- طريقة جديدة للعمل

٤- منع الانتكاس

٥- خطة إدارة الذات

٦- الحياة الصحية

٧- ملخص المرحلة

٨- حول المراحل

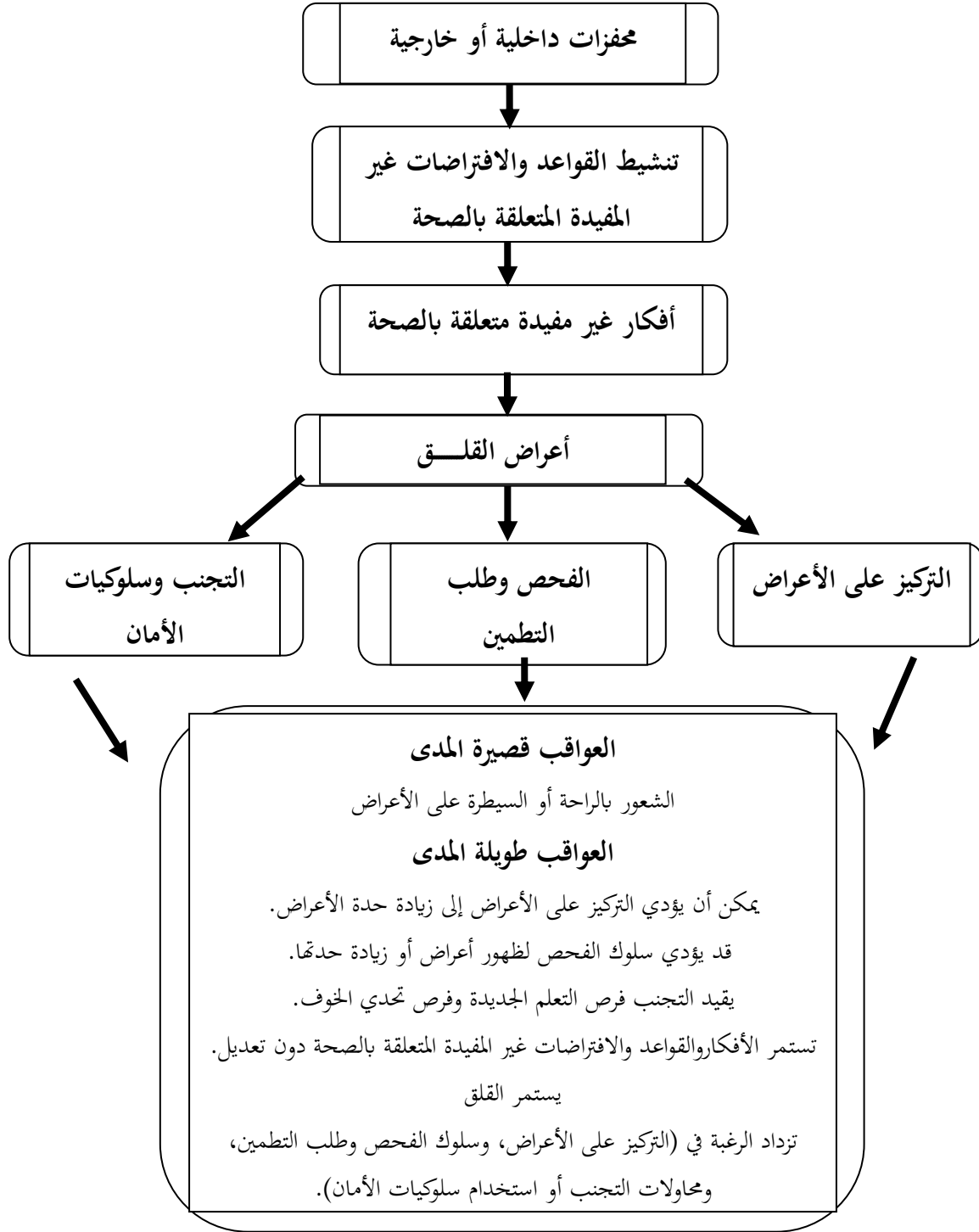
مقدمة

تهانينا على وصولك إلى نهاية حزمة المعلومات هذه! ستجد في هذه المرحلة الأخيرة ملخصًا لجميع المفاهيم والاستراتيجيات المهمة التي تم تقديمها لك في المراحل السابقة. ستجد أيضًا خطة لإدارة الذات مصممة لمساعدتك على البقاء على المسار الصحيح في المستقبل.

إعادة النظر في نموذج قلق الصحة

هل تتذكر نموذج كيفية استمرار قلق الصحة الذي تحدثنا عنه في المرحلة الثالثة؟ لقد أوضح كيف يمكن لبعض المحفزات الداخلية أو الخارجية تنشيط قواعدك أو افتراضاتك المتعلقة بالصحة، وبمجرد تنشيطها يمكن أن تؤثر هذه القواعد والافتراضات سلبًا على طريقة تفكيرك في صحتك وتفسيرك للمعلومات المتعلقة بالصحة. وكلما زاد تفكيرك بهذه الطريقة السلبية؛ زاد شعورك بالقلق، وزادت رغبتك في التركيز على الأعراض، وزاد أيضًا سلوك الفحص والسعي إلى التطمين، وقد يزداد تجنب الأشياء التي تذكرك بمخاوفك الصحية. قد يؤدي قيامك بهذه السلوكيات إلى بعض الشعور بالراحة أو السيطرة على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل تستمر الحلقة المفرغة في الدوران في كل مرة تواجه فيها مشيرًا للقلق.

يوجد فيما يلي نموذج مبسط لتنشيط ذاكرتك.



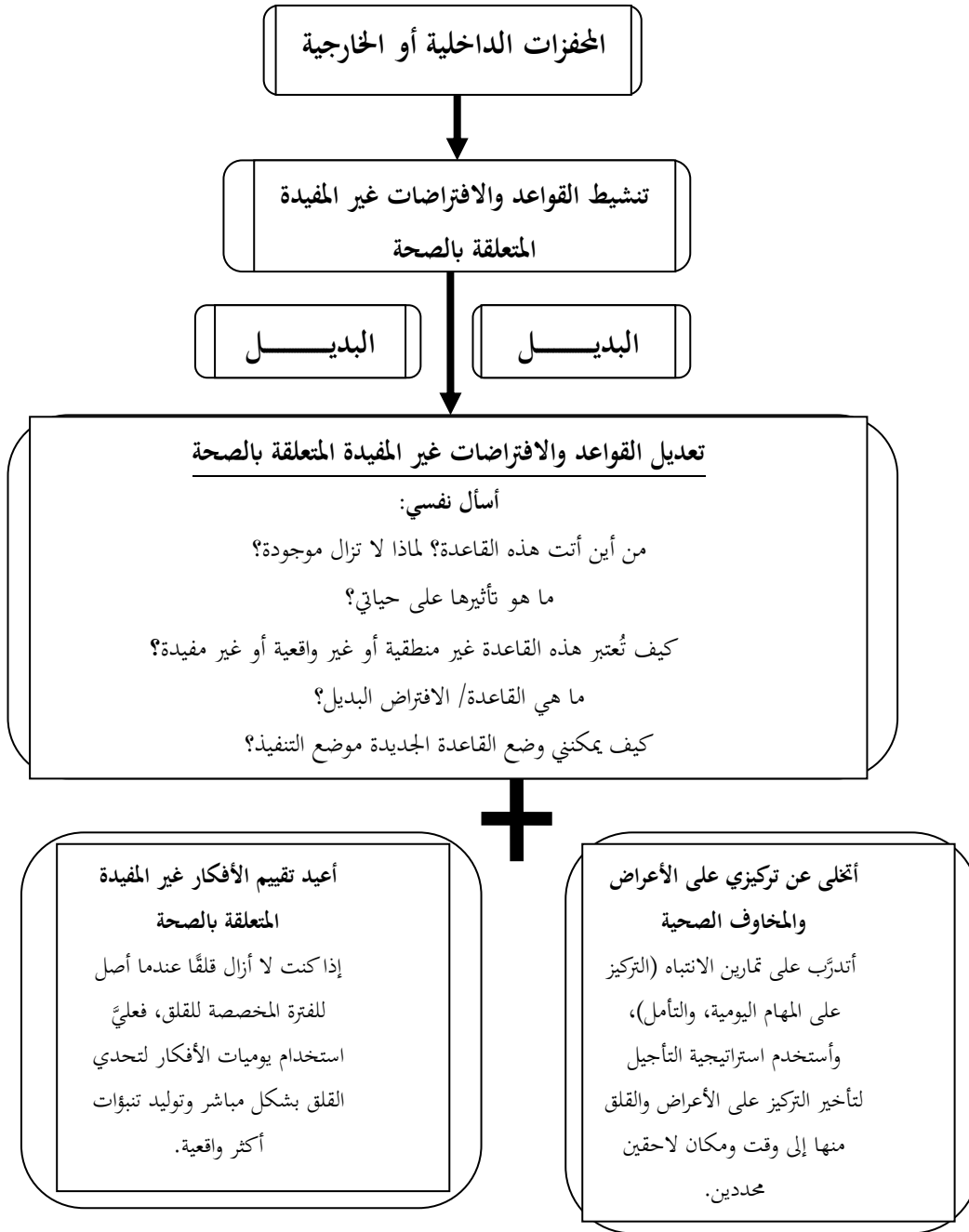
This is a translation of CCI (Centre for Clinical Interventions) materials as translated by [Amara Yehia Arafa] but not reviewed by CCI (Centre for Clinical Interventions, Western Australia). Original materials located at www.cci.health.wa.gov.au

طريقة جديدة للعمل

يمثل نموذج قلق الصحة القديم حلقة مفرغة، حيث تتسبب الأشياء التي تفكر فيها وتفعلها في زيادة مقدار القلق بشأن صحتك، وتؤدي إلى تكرار الأحاسيس الجسدية التي تواجهها وتزيد شدتها. الشيء الجيد في هذه الحلقة هو أنه يمكنك (**عكسها**) من دورة سلبية إلى دورة إيجابية. إنها مثل عجلة تتحرك في اتجاه واحد ولها قوة دفع خلفها، ومن خلال إجراء بعض التغييرات ووضع بعض القوة ضد الحركة القديمة، يمكنك عادةً جعلها تدور في الاتجاه المعاكس. في البداية، قد تستلزم محاولة تغيير اتجاه العجلة جهدًا حقيقيًا، وقد تكون غير سلسة، ولكن مع بعض الإصرار يصبح الأمر أسهل، وفي النهاية تجمع العجلة قوة الدفع الخاصة بها في الاتجاه الجديد.

نأمل أن تكون قادرًا الآن على البدء في تفكيك حلقة قلق الصحة القديمة. لذلك دعونا نتوقف لحظة لمراجعة الاستراتيجيات الرئيسية المقدمة في هذه المرحلة، ونرى كيف يمكن أن نجعلها معًا في نموذج جديد.

طريقتي الجديدة في العمل





لاحظ أنه في النموذج الجديد لا يزال بإمكان المحفزات الداخلية أو الخارجية تنشيط القواعد والافتراضات القديمة غير المفيدة المتعلقة بالصحة، وذلك لأن هذه القواعد والافتراضات غير المفيدة كانت موجودة بشكل عام لفترة طويلة، لذلك لا يمكنك أن تتوقع اختفاءها بين عشية وضحاها. الخطوة الأساسية هي أنك بدلاً من السماح لهذه القواعد والافتراضات غير المفيدة بتوجيه أفكارك ومشاعرك وسلوكياتك، فإنك تختار القيام بالأشياء بشكل مختلف، وبمرور الوقت تتلاشى هذه القواعد والافتراضات القديمة ولا يتم تفعيلها بسهولة.

لذلك عندما يتم تنشيط قواعدك وافتراضاتك القديمة المتعلقة بالصحة عليك أن تقوم بـ :

- تعديل قواعدك وافتراضاتك المتعلقة بالصحة عن طريق تحديها، وإنتاج قواعد وافتراضات صحية مفيدة جديدة، ووضعها موضع التنفيذ.
- تخلّ عن تركيزك على الأعراض والمخاوف الصحية من خلال ممارسة تمارين الانتباه (التركيز على المهام اليومية، والتأمل)، واستخدام استراتيجية التأجيل لتأخير التركيز على الأعراض والقلق منها إلى وقت ومكان لاحقين محددين.
- أعد تقييم أي أفكار غير مفيدة متعلقة بالصحة باستخدام "يوميات الأفكار" أثناء فترة القلق؛ لمعالجة أي أفكار لا زالت تظهر مرة أخرى.
- قلل أي سلوكيات فحص وطلب تطمين غير مفيدة من خلال تقييم مدى فائدة السلوك القديم، وتخليق سلوك جديد أكثر فائدة، ثم اختبره.
- قلل أي تجنب أو سلوكيات أمان من خلال المواجهة التدريجية للأفكار والأشخاص والأماكن والأنشطة المثيرة للقلق.
- يمكن أن يؤدي القيام بكل هذه الأشياء إلى مجموعة من الفوائد طويلة المدى، على الرغم من صعوبة ذلك على المدى القصير. الشيء الرئيسي هنا

هو "الاستمرارية"، لأنه كلما زاد استخدامك للاستراتيجيات المذكورة أعلاه، زادت احتمالية دوران الحلقة المفرغة القديمة بشكل عكسي.

منع الانتكاس

الآن بعد أن وصلت إلى نهاية حزمة المعلومات هذه، فإن أهم شيء هو الاستمرارية! من المهم أن تعرف أنه رغم محاولتك الجادة للقيام بكل الاستراتيجيات على الوجه الصحيح، فيمكنك توقع حدوث بعض التراجع على طول الطريق، فالتغيير ليس عملية تقدم إلى الأمام في خط مستقيم.

فكر في الأمر كأنه محاولة تعلم رياضة جديدة. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تشعر بأن المهارات أصبحت طبيعية أكثر، وأنت تعلمت كل القواعد الجديدة. سوف تحتاج إلى المثابرة والممارسة لجعل الأمر أسهل على نفسك. قد تواجه أحياناً بعض السجال القوي، لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك الاستسلام! هذا يعني فقط أنك قد تحتاج إلى مزيد من التدريب.

حاول ألا تركز كثيراً على أي انتكاسة تواجهها. ركز انتباهك بدلاً من هذا- على ما ستفعله بعد ذلك للعودة إلى المسار الصحيح، مثل ممارسة الاستراتيجيات التي تم تلخيصها في نموذج "طريقتي الجديدة في العمل". يمكنك حتى استخدام أي انتكاسة تواجهها كطريقة لتعلم شيء جديد عن نفسك؛ للمساعدة في تجنب مشكلات مماثلة في المستقبل.

قد يكون من المفيد تصميم خطة لإدارة الذات مخصصة للتعرف على الإشارات الأولية للانتكاس، ووضع الأمور في نصابها الصحيح بأسرع ما يمكن. بهذه الطريقة يمكنك منع الانتكاسة الصغيرة أن تتحول إلى انتكاسة كبيرة.

في الصفحة التالية توجد ورقة عمل "خطة إدارة الذات" لتحديد:

- علامات الإنذار المبكرة للانتكاس. هذه هي المؤشرات التي يمكنك مراقبتها والتي تشير إلى أنك قد تبدأ في القلق بشأن صحتك مرة أخرى.
- المواقف الإشكالية المحتملة. هذه هي الأشياء التي يمكن أن تحفز حدوث نوبة أخرى من قلق الصحة في المستقبل.

من خلال وعيك بهذه العلامات المبكرة والمحفزات المحتملة، ستكون في وضع أفضل لـ "اكتشاف" بداية قلق الصحة، واتخاذ إجراء مبكر لمنعه من أن يصبح أسوأ.

هناك أيضًا مساحة لك لتسجيل طريقة المساعدة:

- الاستراتيجيات أو التقنيات. هذه هي الأشياء التي تعلمتها والتي تساعد في تقليل قلق الصحة لديك.
- مقولات أو عبارات المواجهة. هذه العبارات يمكن أن تتضمن القواعد أو الافتراضات الصحية الجديدة الخاصة بك، والأفكار التي طورتها في يوميات الأفكار، أو أي أشياء أخرى تجدها مفيدة لتذكير نفسك بها من تلك المراحل.

خطة إدارة الذات

ما هي علامات الإنذار المبكرة التي تخبرني أنني قد أتجه نحو انتكاسة وأحتاج إلى القيام بشيء حيال ذلك بنفسني؟ (على سبيل المثال: أفكار معينة/ سلوكيات مثل الفحص أو التجنب/ أشياء يقولها الآخرون لي/ أعراض قلق).

ما المواقف التي قد تُثير مشكلات محتملة بالنسبة لي؟ (على سبيل المثال: أوقات تزايد الضغوط، عند إجراء الفحوصات الطبية، عند تلقي تشخيص ما).

ما هي الاستراتيجيات/ التقنيات التي تعلمتها والتي يمكنني تطبيقها عندما ألاحظ بعض علامات الإنذار المبكرة؟

ما هي بعض مقولات أو عبارات المواجهة المفيدة التي يمكنني استخدامها لمساعدة نفسي على التأقلم عندما أشعر بالقلق أو الهم أو أعاني من انتكاسة؟

الحياة الصحيّة

لعلك تذكر أنه في بداية المرحلة الأولى ناقشنا فكرة أن "الصحة" لا تشير فقط إلى غياب المرض أو العلة أو الإصابة، وإنما تشير غالبًا إلى حالة الأداء الجسدي والعقلي والاجتماعي للشخص. لذلك فإن الخطوة الأخيرة للتغلب على قلق الصحة هي التفكير في كيفية تحسين تلك المجالات. وبصفة عامة، إذا كنت تتخذ خطوات حقيقية لتحسين صحتك العامة، ستكون أقل قلقًا بشأنها!

ستجد في صفحة تالية مكانًا لكتابة أفكارك حول الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين صحتك العامة. ونوصيك بدلاً من تحديد هدف عام، أن تكون محددًا في الخطوات التي ستقوم بها بالفعل. على سبيل المثال: قد تنتظر إلى المساحة المخصصة لـ "النظام الغذائي" وتعتقد أنك ترغب في تناول مزيد من الأطعمة الصحية. ولكي تبدأ بالفعل في ذلك؛ يمكنك كتابة "عندما أقوم بالتسوق سأشتري فواكه وخضروات طازجة".

فيما يلي بعض الأسئلة التي قد تساعدك على تحديد ما إذا كنت بحاجة إلى القيام بشيء ما لتحسين كل مجال من مجالات صحتك العامة؛ وذلك في "ورقة عمل الحياة الصحية". ولقد قدمنا أيضًا مثالًا على كيفية وضع هدف محدد لكل مجال من تلك المجالات.

- **الأنشطة الاجتماعية والمساندة:** هل تحتاج إلى التواصل مع الأصدقاء القدامى؟ هل أنت بحاجة لبدء بعض الصداقات الجديدة؟
"سأتصل بجين هذا الأسبوع لتناول القهوة معها".

- **إدارة الضغط:** هل هناك كثير من الضغط في حياتك في الوقت الحالي؟ كيف يمكنك تقليلها؟
"سألتحق بفصل اليوجا يوم الثلاثاء، وسأغادر العمل في الوقت المحدد للوصول إلى هناك".
- **النظام الغذائي:** هل تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا، وهل هناك مشكلات في نظامك الغذائي؟
"سأقتصر على فنجان واحد من القهوة يوميًا هذا الأسبوع".
- **التمرينات الرياضية:** كم مرة تمارس الرياضة؟ هل تحتاج إلى ممارسة مزيد من التمارين أم أقل؟
"سأمشي مع الكلب مرتين هذا الأسبوع بدلاً من ترك شريكي يقوم بذلك".
- **الأنشطة الممتعة أو المسلية:** هل لديك ما يكفي من المرح في حياتك؟ هل هناك أشياء اعتدت الاستمتاع بها ولكنك قلّصت من فعلها أو توقفت عن أدائها؟ هل تضع "المرح" في آخر قائمة الأولويات؟
"سأشتري لعبة بانوراما هذا الخميس، وأبدأ في لعبها".
- **النوم:** هل تحصل على قسط كافٍ من الراحة؟ هل تجد صعوبة في الدخول في النوم أو في النوم المتصل؟ هل تؤجل النوم لأنك تقوم بأشياء أخرى؟ هل لديك عادات نوم جيدة؟
"سأخرج التلفزيون من غرفة النوم؛ لأنني أبقى مستيقظًا لوقت متأخر عما يجب".
- **الأهداف الشخصية:** هل هناك أي شيء ترغب في تحقيقه وتحتاج للبدء في العمل عليه؟ ما هي أهدافك على المدى القصير والمتوسط والطويل؟ ماذا يوجد في قائمة "المهام" الخاصة بك؟ من بين كل الأشياء الموجودة في قائمة "المهام"، ما هي الأشياء التي ترغب في تحقيقها أكثر من غيرها؟ ما هي الخطوة الواضحة التي يمكنك اتخاذها نحو هذا الهدف؟

"سأزور أقاربي أكثر مما سبق، وسأبدأ بزيارة خالتي يوم السبت".

• **أخرى:** هل هناك أي شيء آخر يمكنك القيام به لتحسين صحتك العامة؟
هل تحتاج إلى تقليل تناول الكحول؟ هل في خطتك القيام بفحص طبي مع طبيبك أو طبيب أسنانك؟ إذا كنت قد أوصيت بدواء أو برنامج علاجي آخر، فهل تحافظ عليه؟ إذا لم تكن كذلك، كيف ستحافظ عليه؟
"سأتصل بطبيب الأسنان الخاص بي لحجز موعد للفحص".

لعلك الآن قد حددت بعض التغييرات التي ترغب في إجرائها، وقد ترغب في توفير "يوميّات" لك؛ حتى تتمكن من جدولة كل من هذه الأنشطة، وتحافظ على سيرك لتحقيق أهدافك الجديدة.

ورقة عمل الحياة الصحيّة

إدارة الضغوط	الأنشطة الاجتماعية والمساندة
التمارين الرياضية	النظام الغذائي
النوم	الأنشطة الممتعة والمسلية
أخرى	الأهداف الشخصية

ملخص المرحلة التاسعة

- لكي تدور الحلقة المفرغة لقلق الصحة بشكل عكسي؛ فإنك تحتاج إلى:
 - تعديل القواعد والافتراضات المتعلقة بالصحة الخاصة بك.
 - تخلّ عن تركيزك على الأعراض المقلقة.
 - أعد تقييم أي أفكار غير مفيدة متعلقة بالصحة.
 - قلل من سلوكيات الفحص أو طلب التطمين غير المفيدة.
 - قلل من التجنب أو سلوكيات الأمان.
- يستغرق تغيير القواعد والأفكار والسلوكيات المتعلقة بالصحة وقتاً ومراña كثيراً.
- توقع الانتكاسات، ولكن بدلاً من التركيز عليها، استخدم خطة إدارة الذات الخاصة بك للتعرف عليها مبكراً، ومنعها من التفاقم، والعودة إلى المسار الصحيح.
- انخرط في السلوكيات التي تعزز صحتك العامة، مثل الحصول على المساعدة الاجتماعية، وإدارة الضغوط لديك، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة الرياضة بانتظام، وتوفير وقت للاستمتاع، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتحديد الأهداف الشخصية وتحقيقها، والحد من تناول الكحول، وحضور الفحوص بانتظام، وإدارة أي مشاكل صحية لديك.

وصلنا إلى النهاية...

تهانينا! لقد وصلت إلى نهاية البرنامج. نأمل أن تكون قد وجدته مفيداً، وأن تحافظ على المكاسب التي حققتها. استمر في استخدام الاستراتيجيات وراجع المراحل من وقت لآخر.

حظاً طيباً...

Helping Health Anxiety

About The Modules

CONTRIBUTORS

Dr Rebecca Anderson (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

Paula Nathan (MPsych¹)
Centre for Clinical Interventions

Dr Lisa Saulsman (MPsych¹; PhD²)
Centre for Clinical Interventions

¹Masters of Psychology (Clinical Psychology)

²Doctor of Philosophy (Clinical Psychology)

BACKGROUND

The concepts and strategies in these modules have been developed from evidence based psychological practice, primarily Cognitive-Behaviour Therapy (CBT). CBT for health anxiety is based on the approach that health anxiety is a result of problematic cognitions (thoughts) and behaviours.

REFERENCES

These are some of the professional references used to create the modules in this information package.

Abramowitz, J., Taylor, S., & McKay, D. (2010). Hypochondriasis and severe health anxiety. In McKay, D., Abramowitz, J., S., & Taylor, S. (Eds.). *Cognitive-behavior therapy: Turning failure into success* (pp. 327-346). Washington, DC: American Psychological Association.

Asmundson, G., & Taylor, S. (2005). *It's not all in your head: How worrying about your health could be making you sick – and what you can do about it*. New York: The Guilford Press.

Furer, P., & Walker, J. (2006). *Health anxiety treatment manual*. University of Manitoba: Manitoba.

Furer, P., Walker, J., & Stein, M. (2007). *Treating health anxiety and fear of death*. New York: Springer.

Papageorgiou, C., & Wells, A. (1998). Effects of attention training on hypochondriasis: A brief case series. *Psychological Medicine*, 28, 193-200.

Salkovskis, P., Warwick, H., & Deale, A. (2003). Cognitive-behavioural treatment for severe and persistent health anxiety (Hypochondriasis). *Brief Treatment and Crisis Intervention*, 3, 353-367.

Willson, R., & Veale, D. (2009). *Overcoming health anxiety: A self-help guide using cognitive behavioural techniques*. London: Robinson.

“HELPING HEALTH ANXIETY”

This module forms part of:

Anderson, R., Saulsman, L., & Nathan, P. (2011). *Helping Health Anxiety*. Perth, Western Australia: Centre for Clinical Interventions.

ISBN: 0 9757995 6 8

Created: August 2011